

DAS KOMPLETTPAKET FÜRS PFLEGEEXAMEN

Pflegeexamen-Komplettpaket



Alle 9 PLAN-Lernhilfen in einem Paket – 154 Seiten Prüfungswissen, Fallbeispiele, Karten, Formulare und Notfall-Poster.

Bestehen ist planbar.

Schriftlich

Mündlich

Praxis

Notfall

Formulare

9

Lernhilfen

154

Seiten

A4

druckfertig

INHALT

1 Prüfungsfragen-Sammlung

3 Taschenkarten-Set

5 Prophylaxen-Kompodium

7 Dokumentationsvorlagen

9 ... und Examens-Spickzettel

2 Mündliche Prüfungssimulation

4 Notfallkarten Anästhesie & Intensiv

6 Pflegeplanungs-Vorlagen

8 Reanimation & Notfallalgorithmen

△ Lernhilfen für Ausbildung und Prüfung. Es gelten deine Lehrinhalte, aktuelle Leitlinien und die Standards deiner Einrichtung.

Inhalt des Komplettpakets

Jede Lernhilfe beginnt mit einem eigenen Deckblatt. Seitenzahlen beziehen sich auf dieses Gesamt-PDF.

Prüfungsfragen-Sammlung 300 Fragen mit Erklärungen	S. 3
Mündliche Prüfungssimulation 20 Fallbeispiele im Prüfungsdialog	S. 66
Taschenkarten-Set 40 Karten zum Ausschneiden	S. 94
Notfallkarten Anästhesie & Intensiv 19 Medikamente	S. 105
Prophylaxen-Kompodium 16 Themen mit Standards	S. 112
Pflegeplanungs-Vorlagen 8 Formulare + Musterbeispiel	S. 130
Dokumentationsvorlagen 5 Formulare	S. 141
Reanimation & Notfallalgorithmen 4 Algorithmus-Poster	S. 147
Examens-Spickzettel 60+ Kernfakten	S. 152



Prüfungsfragen-Sammlung

300 Multiple-Choice-Fragen aus 15 Fachbereichen – zum Selbsttest mit Lösungsschlüssel und verständlichen Erklärungen im Anhang.

Bestehen ist planbar.

Multiple Choice

Erklärungen

3 Schwierigkeitsstufen

Lösungsschlüssel

300

Fragen

15

Fachbereiche

A4

druckfertig

INHALT

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Generalistische Ausbildung & Recht | 2 Pflegeprozess & Pflegeplanung |
| 3 Prävention & Gesundheitsförderung | 4 Mobilität & Bewegung |
| 5 Notfall & Akutsituationen | 6 Innere Medizin |
| 7 Chirurgie | 8 Pädiatrie |
| 9 Gynäkologie & Geburtshilfe | 10 ... und 6 weitere Bereiche |

△ Lernhilfe zur Prüfungsvorbereitung. Inhalte nach bestem Wissen erstellt – maßgeblich sind deine Lehrinhalte, aktuelle Leitlinien und die Standards deiner Einrichtung.

So nutzt du die Sammlung

Erst alle Fragen eines Bereichs beantworten, dann im Lösungsteil kontrollieren. Falsche Antworten markieren und nach ein paar Tagen wiederholen.

SCHWIERIGKEIT

• leicht • ●● mittel • ●●● schwer

EHRLICH TESTEN

Lösungen stehen gesammelt am Ende – kein Spoiler beim Lernen.

FACHBEREICHE

01 Generalistische Ausbildung & Recht · 20 Fragen

02 Pflegeprozess & Pflegeplanung · 20 Fragen

03 Prävention & Gesundheitsförderung · 20 Fragen

04 Mobilität & Bewegung · 20 Fragen

05 Notfall & Akutsituationen · 20 Fragen

06 Innere Medizin · 20 Fragen

07 Chirurgie · 20 Fragen

08 Pädiatrie · 20 Fragen

09 Gynäkologie & Geburtshilfe · 20 Fragen

10 Psychiatrie · 20 Fragen

11 Psychologie & Kommunikation · 20 Fragen

12 Altenpflege & Geriatrie · 20 Fragen

13 Palliativpflege · 20 Fragen

14 Rehabilitation · 20 Fragen

15 Anerkennung & Berufszulassung · 20 Fragen

1 Generalistische Ausbildung & Recht

20 Fragen

1 Wer ist in der generalistischen Ausbildung der „Träger der praktischen Ausbildung“?

● ●

- ☐ A Die Berufsgenossenschaft als zuständiger Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
- ☐ B Das jeweilige Schulministerium des Bundeslandes als oberste zuständige Behörde
- ☐ C Die Einrichtung, die den Ausbildungsvertrag schließt und die praktische Ausbildung verantwortet
- ☐ D Die zuständige Krankenkasse als Kostenträger der monatlichen Ausbildungsvergütung

2 Wie lange dauert die generalistische Pflegeausbildung in Vollzeit?

●

- ☐ A 3 Jahre (in Teilzeit bis zu 5 Jahre)
- ☐ B Ein Jahr in Vollzeit ohne jede Möglichkeit einer weiteren Verlängerung
- ☐ C Zehn Jahre durchgehend berufsbegleitend in dauerhafter Teilzeitform
- ☐ D Sechs Monate als stark verkürzte und komprimierte Intensivausbildung

3 Was sind „vorbehaltene Tätigkeiten“ nach dem Pflegeberufgesetz?

● ● ●

- ☐ A Tätigkeiten, die nur ausgebildeten Pflegefachpersonen vorbehalten sind (z. B. Erhebung und Steuerung des Pflegeprozesses)
- ☐ B Bestimmte organisatorische Aufgaben im Bereich der Stationsverwaltung und Ablaufplanung
- ☐ C Reine hauswirtschaftliche und Reinigungstätigkeiten im Umfeld der Pflegeeinrichtung
- ☐ D Alltägliche Aufgaben, die grundsätzlich jede beliebige Person ohne Ausbildung übernehmen darf

4 Welche Versorgungsbereiche decken die Pflichteinsätze der generalistischen Ausbildung ab?

● ●

- ☐ A Stationäre Akutpflege, stationäre Langzeitpflege und ambulante Pflege
- ☐ B Ausschließlich die Versorgung von Patienten auf der Intensivstation
- ☐ C Ausschließlich verwaltende und organisatorische Tätigkeiten der Einrichtung
- ☐ D Ausschließlich die Assistenz bei Operationen im OP-Bereich

5 Was prüft die 3. Praxisbegleitung?

● ●

- ☐ A Die Grundlagen der Anästhesie und Narkoseführung
- ☐ B CE 09-11: komplexe Pflegesituationen und Koordination
- ☐ C Ausschließlich die Bedienung medizinischer Geräte
- ☐ D Nur einfache Tätigkeiten der pflegerischen Grundpflege

6 Was ist Kinästhetik-Grundprinzip?

● ●

- ☐ A Nur von Physiotherapeuten anwendbar
- ☐ B Natürliche Bewegungsmuster nutzen
- ☐ C Schnelle Pflege ohne Hilfsmittel
- ☐ D Vollständige Übernahme

7 Womit beginnt der Pflegeprozess?

● ●

- | | |
|--|--|
| ☐ A Mit der abschließenden Bewertung und Evaluation der erbrachten Pflege | ☐ B Mit der Vorbereitung und Durchführung der Entlassung des Patienten |
| ☐ C Mit der Abrechnung der erbrachten Pflegeleistungen gegenüber der Kasse | ☐ D Mit der Informationssammlung (Assessment / Erhebung des Pflegebedarfs) |

8 Was prüft die 1. Praxisbegleitung?

● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Abschlussprüfung | ☐ B Anästhesievorbereitung |
| ☐ C CE 01/02/03: Einstieg | ☐ D ECMO-Bedienung |

9 Was ist Evaluation im Pflegeprozess?

● ●

- | | |
|--|--|
| ☐ A Pflegediagnose stellen | ☐ B Durchführung der Maßnahmen |
| ☐ C Aufnahme des Patienten | ☐ D Überprüfung ob Pflegeziele |

10 Wie viele Stunden umfasst die generalistische Pflegeausbildung insgesamt etwa?

● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Rund 500 Stunden, aufgeteilt auf Theorie und Praxis | ☐ B Rund 4600 Stunden (etwa 2100 Theorie + 2500 Praxis) |
| ☐ C Rund 100 Stunden im Rahmen eines kurzen Grundkurses | ☐ D Deutlich über 20.000 Stunden über die gesamte Ausbildung |

11 Was ermöglicht die Zwischenprüfung nach etwa zwei Dritteln der Ausbildung?

● ● ●

- | | |
|--|--|
| ☐ A Den sofortigen und vollwertigen Abschluss der Berufsausbildung | ☐ B Den Wechsel in ein Hochschulstudium ganz ohne weitere Prüfung |
| ☐ C Sie ermöglicht nichts Besonderes und ist ohne Bedeutung | ☐ D Eine Standortbestimmung; in einigen Ländern kann darauf ein Pflegefachassistenten-Abschluss aufbauen |

12 Wie viele Stunden umfasst der Vertiefungseinsatz?

● ●

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ☐ A 800h | ☐ B 500h |
| ☐ C 120h | ☐ D 280h |

13 Welche schulische Zugangsvoraussetzung gilt üblicherweise für die generalistische Pflegeausbildung?

● ●

- | | |
|--|---|
| ☐ A Ausschließlich das Abitur oder eine gleichwertige allgemeine Hochschulreife | ☐ B Ein mittlerer Schulabschluss oder ein Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Ausbildung bzw. Pflegeassistenten |
| ☐ C Gar kein bestimmter Schulabschluss, da der Zugang zur Ausbildung völlig frei ist | ☐ D Ein bereits erfolgreich abgeschlossenes Studium in einem medizinischen Fachbereich |

14 Was regelt das PfIBG?

●

- | | |
|--|--|
| ☐ A Generalistische Ausbildung | ☐ B Die Ausbildung zur Krankenpflege |
| ☐ C Die Ausbildung zur Altenpflege | ☐ D ATA/OTA-Ausbildung |

15 Worum geht es im Pflegemodell von Dorothea Orem?

● ● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Um die Ernährung allein | ☐ B Um die Technik der Blutabnahme |
| ☐ C Um die Selbstpflege und den Ausgleich von Selbstpflegedefiziten | ☐ D Um die Krankenhausfinanzierung |

16 Was ist die NANDA-Pflegediagnose?

● ● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Eine ärztliche Diagnose zur Feststellung einer Erkrankung | ☐ B Ein System, das ausschließlich in den USA angewendet wird |
| ☐ C Internationales Klassifikationssystem für Pflegediagnosen | ☐ D Ein längst veraltetes und nicht mehr gebräuchliches System |

17 Was sind CE 01-11 in der GPA?

● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Einzelne schriftliche und mündliche Prüfungen im Verlauf der Ausbildung | ☐ B Die verschiedenen praktischen Einsätze in Klinik und ambulanter Pflege |
| ☐ C Erworbene Zusatzzertifikate für einzelne Fachbereiche der Pflege | ☐ D Curriculare Einheiten = Lernbereiche der generalistischen Pflegeausbildung |

18 Seit wann ist die generalistische Pflegeausbildung in Kraft?

●

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ A 01.01.2020 | ☐ B 01.09.2021 |
| ☐ C 01.01.2022 | ☐ D 01.01.2018 |

19 Was ist der Pädiatrie-Pflichteinsatz in der GPA?

● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Ein rein optionaler Einsatz ohne festgelegte Mindeststundenzahl | ☐ B Ein Pflichteinsatz im Umfang von insgesamt 300 Stunden |
| ☐ C Ein Wahlpflichteinsatz von 500 Stunden am Ende der Ausbildung | ☐ D Pflicht: 120h Kinder- und Jugendmedizin |

20 Welche CE behandelt Akutsituationen?

● ●

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ A CE 05 | ☐ B CE 09 |
| ☐ C CE 03 | ☐ D CE 06 |

2 Pflegeprozess & Pflegeplanung

20 Fragen

21 Was sind die 4 Hauptbestandteile einer Pflegeplanung?

- | | |
|--|--|
| ☐ A Pflegeproblem/Pflegediagnose, Pflegeziel | ☐ B Problem, Diagnose, Therapie, Entlassung |
| ☐ C Anamnese, Befund, Plan, Kontrolle | ☐ D Aufnahme, Behandlung, Pflege, Entlassung |

22 Was ist Dekubitus-Kategorie II?

- | | |
|--|--|
| ☐ A Muskel/Knochen sichtbar | ☐ B Blasenbildung oder Erosion |
| ☐ C Vollhautverlust bis Subkutis | ☐ D Nicht-wegdrückbare Rötung |

23 Was sind Ressourcen in der Pflegeplanung?

- | | |
|--|--|
| ☐ A Bestehende Pflegeprobleme und Defizite | ☐ B Vorhandene Fähigkeiten und Stärken |
| ☐ C Verfügbares Pflegematerial und Hilfsmittel | ☐ D Die ärztlichen Diagnosen des Patienten |

24 Was ist der Pflegebericht?

- | | |
|--|---|
| ☐ A Reine Verlaufskurve der Vitalzeichen | ☐ B Täglicher Bericht der ärztlichen Visite |
| ☐ C Dokumentation von Pflegeverlauf und Reaktionen | ☐ D Dokumentation nur der Medikamentengabe |

25 Wie formuliert man konkrete Pflegemaßnahmen?

- | | |
|---|--|
| ☐ A Konkret: WER, WAS, WANN/WIE OFT | ☐ B Nur die Medikamentengabe notieren |
| ☐ C Allgemein: Patient pflegen | ☐ D Übernahme der ärztlichen Anordnungen |

26 Was ist ein (hausinterner) Pflegestandard?

- | | |
|---|--|
| ☐ A Ein gesetzlich verankertes Verbot bestimmter Pflegehandlungen | ☐ B Ein verbindlicher Dienstplan für den Ablauf der Schicht |
| ☐ C Eine unverbindliche Idee ohne festgelegte Vorgaben zur Durchführung | ☐ D Eine verbindliche Vorgabe, wie eine bestimmte Pflegemaßnahme fachgerecht durchzuführen ist |

27 Was gilt bei Clostridium-difficile-Infektion bezüglich Händehygiene?

- | | |
|---|--|
| ☐ A Keine besondere Hygiene nötig | ☐ B Händewaschen statt Alkohol-Desinfektion |
| ☐ C Es genügen Einmalhandschuhe | ☐ D Händedesinfektion mit Alkohol wie normal |

28 Wann sollten Einmalhandschuhe NICHT getragen werden?

- | | |
|--|--|
| ☐ A Bei Wundversorgung | ☐ B Beim normalen Patientenkontakt |
| ☐ C Bei Katheteranlage | ☐ D Bei Blutentnahme |

29 Was ist Pflegeüberleitung?

● ●

- ☐ A Fortbildung
- ☐ B Eine Pflegediagnose
- ☐ C Übergabe innerhalb Station
- ☐ D Strukturierte Weitergabe

30 Was sind die 5 Momente der WHO-Händehygiene?

● ●

- ☐ A Vor Patientenkontakt · Vor aseptischer Tätigkeit · Nach Körperflüssigkeit · Nach Patientenkontakt · Nach Umgebung
- ☐ B Beim Betreten · Beim Verlassen · Beim Verbandswechsel
- ☐ C Morgens · Mittags · Abends · Nach Blut · Nach WC
- ☐ D Vor/nach der Pause · Nach der Toilette · Vor dem Essen

31 Was ist Pflegevisite?

● ●

- ☐ A Kontrollrundgang nur durch die Stationsleitung
- ☐ B Systematische Überprüfung des Pflegeprozesses
- ☐ C Anleitung der Auszubildenden am Patientenbett
- ☐ D Ärztliche Visite ohne Pflegebeteiligung

32 Was ist die NRS und wie wird sie eingesetzt?

●

- ☐ A Nationales Sturzregister
- ☐ B Reanimationsschema
- ☐ C Numerische Rating-Skala
- ☐ D Nutritional Risk Screening

33 Was ist der Unterschied Pflegediagnose vs. ärztliche Diagnose?

● ●

- ☐ A Beide beschreiben dieselbe Krankheit
- ☐ B Pflegediagnose weniger wichtig
- ☐ C Ärztlich = Krankheit/Pathologie
- ☐ D Ärztlich ist detaillierter

34 Was sind potenzielle Pflegeprobleme?

● ●

- ☐ A Medikamentennebenwirkungen
- ☐ B Ärztliche Diagnosen
- ☐ C Risiken/Gefährdungen, die noch nicht eingetreten sind
- ☐ D Bereits eingetretene Probleme

35 Welche Handschuhe werden bei sterilen Eingriffen verwendet?

● ●

- ☐ A Haushaltshandschuhe
- ☐ B Sterile OP-Handschuhe (Non-Touch-Anlegetechnik)
- ☐ C Normale Untersuchungshandschuhe
- ☐ D Latexfreie Handschuhe nur bei Allergie

36 Welche Wäsche kommt in den roten Sack?

●

- ☐ A Gebrauchte Abdecktücher aus dem Operationssaal
- ☐ B Ganz normale, nur leicht verschmutzte Bettwäsche
- ☐ C Grundsätzlich die gesamte Wäsche aller Patienten
- ☐ D Infektionswäsche – direkt verschlossen im Zimmer entsorgen

37
Was ist bei der Isolierung eines MRSA-Patienten zu beachten?

● ● ●

- ☐ **A** Der Patient darf grundsätzlich gar nicht besucht werden
- ☐ **B** Einzelzimmer, Schutzkittel, Handschuhe und FFP2 bei engem Kontakt
- ☐ **C** Es genügt das alleinige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
- ☐ **D** Es genügt das alleinige Tragen von Einmalhandschuhen

38
Was muss bei der Formulierung eines Pflegeproblems enthalten sein?

● ●

- ☐ **A** Problem, Ziel und Maßnahme gemeinsam
- ☐ **B** Symptome und ärztliche Verdachtsdiagnose
- ☐ **C** Problem + Ursache (Ätiologie)
- ☐ **D** Pflegeziel und geplante Maßnahme

39
Was ist ein korrektes SMART-Pflegeziel?

● ●

- ☐ **A** Mobilität verbessern
- ☐ **B** Patient geht am 3. Tag mit Hilfe 10m
- ☐ **C** Schmerzen reduzieren
- ☐ **D** Patient soll sich besser fühlen

40
Was ist Virginia Hendersons Pflegemodell?

● ● ●

- ☐ **A** 14 Grundbedürfnisse – Hilfe zur Selbstständigkeit
- ☐ **B** Ein reines Pflegeprozessmodell zur Ablaufsteuerung der Pflege
- ☐ **C** Das AEDL-Modell der aktivitätsorientierten Lebensbereiche
- ☐ **D** Das Konzept der Salutogenese zur Entstehung von Gesundheit

3 Prävention & Gesundheitsförderung

20 Fragen

41 Wer gibt in Deutschland die offiziellen Impfeempfehlungen heraus?

- ☐ A WHO
- ☐ B STIKO am RKI
- ☐ C Hausärzterverband
- ☐ D Pflegekammer

42 Was ist das Ziel der motivierenden Gesprächsführung (Motivational Interviewing)?

- ☐ A Den Patienten mit Nachdruck zu einer Entscheidung zu überreden
- ☐ B Die eigene Veränderungsmotivation des Patienten stärken
- ☐ C Dem Patienten klare Anweisungen und Vorgaben zu erteilen
- ☐ D Eine ärztliche Diagnose für den Patienten zu stellen

43 Was ist ein Ziel des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)?

- ☐ A Krankenstände durch Druck senken
- ☐ B Gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen schaffen und Beschäftigte gesund halten
- ☐ C Gesetzliche Vorgaben nur minimal erfüllen
- ☐ D Ausschließlich Kosten einsparen

44 Wie hebt man beim Anheben von Lasten rückschonend?

- ☐ A Mit rundem Rücken und gestreckten Beinen
- ☐ B Ruckartig und möglichst schnell
- ☐ C Aus den Beinen heben, Rücken gerade, Last nah am Körper
- ☐ D Grundsätzlich allein und ohne Hilfsmittel

45 Womit prüft man, ob eine Hautrötung ein Dekubitus Kategorie 1 sein könnte?

- ☐ A Mit dem Thermometer
- ☐ B Mit dem Blutdruckmessgerät
- ☐ C Mit einer Blutentnahme
- ☐ D Mit dem Fingertest (Wegdrückbarkeit prüfen)

46 Was ist ein Kernziel der Patientenedukation?

- ☐ A Abhängigkeit erhöhen
- ☐ B Informationen zurückhalten
- ☐ C Gesundheitskompetenz und Selbstmanagement stärken
- ☐ D Reine Medikamentenverteilung

47 Welche Aufgabe hat das Robert Koch-Institut (RKI)?

- ☐ A Infektionskrankheiten überwachen und Präventionsempfehlungen erarbeiten
- ☐ B Die Zulassung und Prüfung neuer Arzneimittel und Impfstoffe
- ☐ C Die Ausbildung und Prüfung von Pflegekräften im Land
- ☐ D Die Festlegung der Höhe der Beiträge zur Krankenversicherung

48 Wie lange sollte die hygienische Händedesinfektion üblicherweise einwirken?

● ●

- ☐ A Mindestens 30 Sekunden
 ☐ B Etwa 3 Sekunden
 ☐ C Genau 5 Minuten
 ☐ D Die Zeit spielt keine Rolle

49 Welche Maßnahme ist am wirksamsten gegen nosokomiale Infektionen?

●

- ☐ A Hygienische Händedesinfektion
 ☐ B Antibiotika-Prophylaxe bei allen Patienten
 ☐ C Tägliches Wischen der Fußböden
 ☐ D Mundschutz für Besucher

50 Was beschreibt das Konzept der Salutogenese (Antonovsky)?

● ●

- ☐ A Entstehung und Erhalt von Gesundheit
 ☐ B Entstehung von Krankheit
 ☐ C Reine Risikovermeidung
 ☐ D Genetische Vererbung

51 Was ist ein typisches Beispiel für Sekundärprävention?

●

- ☐ A Schutzimpfung
 ☐ B Rehabilitation nach Schlaganfall
 ☐ C Gesunde Ernährung
 ☐ D Krebsfrüherkennungsuntersuchung

52 Welche Pflegemaßnahme dient der Soor- und Parotitisprophylaxe?

● ●

- ☐ A Den Patienten nüchtern lassen
 ☐ B Vorsorgliche Antibiotika-Gabe
 ☐ C Sauerstoffgabe über die Nase
 ☐ D Regelmäßige Mund- und Zahnpflege sowie Speichelanregung

53 Welche Maßnahme zählt zur physikalischen Thromboseprophylaxe?

● ●

- ☐ A Die strikte Einhaltung durchgehender und dauerhafter Bettruhe
 ☐ B Frühmobilisation und medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe
 ☐ C Eine möglichst tiefe Lagerung beider Beine des Patienten
 ☐ D Das Trinken großer Mengen von koffeinhaltigem Kaffee

54 Welche Schutzausrüstung schützt am ehesten vor einer Tröpfcheninfektion?

● ●

- ☐ A Ein Mund-Nasen-Schutz bzw. eine Atemschutzmaske
 ☐ B Sterile Einmalhandschuhe für den direkten Patientenkontakt
 ☐ C Eine Kopfhaut zur Abdeckung von Haaren und Kopfhaut
 ☐ D Überschuhe zum Schutz vor Verunreinigung des Bodens

55 Welcher Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist beeinflussbar (modifizierbar)?

●

- ☐ A Das Lebensalter
 ☐ B Rauchen und Bewegungsmangel
 ☐ C Die genetische Veranlagung
 ☐ D Das Geschlecht

56 Was versteht man unter Quartärprävention?

● ● ●

- | | |
|---|---|
| ☐ A Die Schutzimpfung von Neugeborenen gegen Infektionen | ☐ B Ein Früherkennungs-Screening zur Entdeckung von Krebs |
| ☐ C Vermeidung unnötiger oder übermäßiger medizinischer Maßnahmen (Übersorgung) | ☐ D Die Erste Hilfe am Ort eines eingetretenen Unfalls |

57 Wie viele „Momente der Händedesinfektion“ definiert die WHO?

●

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ☐ A Zwei | ☐ B Drei |
| ☐ C Fünf | ☐ D Zehn |

58 Welche Impfung wird für Pflegepersonal arbeitsmedizinisch besonders empfohlen?

● ●

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ A Gelbfieber | ☐ B Tollwut |
| ☐ C FSME für alle | ☐ D Hepatitis B |

59 Welche Maßnahme senkt das Aspirationsrisiko bei der Nahrungsaufnahme?

● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Den Patienten im Liegen füttern | ☐ B Aufrechte Sitzposition und angepasste Kostkonsistenz |
| ☐ C Große Bissen schnell anreichen | ☐ D Während des Schluckens ablenken |

60 Was bedeutet Empowerment in der Gesundheitsförderung?

●

- | | |
|--|--|
| ☐ A Die wohlmeinende Bevormundung und Entscheidungsübernahme für den Patienten | ☐ B Die reine Weitergabe von Informationen ohne aktive Beteiligung des Patienten |
| ☐ C Befähigung zu mehr Selbstbestimmung und Kontrolle über die eigene Gesundheit | ☐ D Die gezielte Gabe von Medikamenten zur Verbesserung der Gesundheit |

4 Mobilität & Bewegung

20 Fragen

61 Wodurch unterscheidet sich ein Rollator von einem Gehbock?

● ●

- | | |
|---|---|
| ☐ A Der Rollator hat Räder für flüssiges Gehen, der Gehbock wird angehoben und versetzt | ☐ B Beide Gehhilfen sind vollständig identisch und gleich zu bedienen |
| ☐ C Der Gehbock verfügt zusätzlich über einen elektrischen Antrieb | ☐ D Der Rollator ist ausschließlich für Kinder gedacht und gebaut |

62 Was ist das wichtigste Prinzip der Kontrakturenprophylaxe?

● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Strikte Bettruhe | ☐ B Hochlagerung aller Gelenke |
| ☐ C Fixierung der Gelenke | ☐ D Regelmäßige Bewegung und physiologische Lagerung |

63 Welche Umgebungsmaßnahme senkt das Sturzrisiko?

●

- | | |
|--|--|
| ☐ A Lose herumliegende Teppiche und Läufer auf dem Boden | ☐ B Eine bewusst gedämpfte, schwache Beleuchtung der Räume |
| ☐ C Gute Beleuchtung, rutschfeste Schuhe und freie Wege | ☐ D Feuchte, frisch gewischte und dadurch glatte Böden |

64 Was kennzeichnet einen individuellen Bewegungsförderungsplan?

● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Ein starres Schema für alle Patienten | ☐ B Ausschließlich ärztliche Anordnung ohne Pflege |
| ☐ C Den Verzicht auf Dokumentation | ☐ D An Ressourcen, Risiko und Zielen des Patienten ausgerichtete Maßnahmen |

65 Wie beugt man einem orthostatischen Kreislaufabfall beim Mobilisieren vor?

● ●

- | | |
|--|---|
| ☐ A Den Patienten ruckartig aufstehen lassen | ☐ B Sofort längere Strecken gehen lassen |
| ☐ C Flach liegend aus dem Bett ziehen | ☐ D Stufenweise mobilisieren: erst aufsetzen, Kreislauf adaptieren lassen, dann aufstehen |

66 Worauf zielt der Expertenstandard Dekubitusprophylaxe (DNQP) primär ab?

●

- | | |
|--|--|
| ☐ A Wundversorgung bestehender Dekubitus | ☐ B Tägliches Wiegen |
| ☐ C Druckentlastung und Risikoeinschätzung | ☐ D Antibiotikagabe |

67 Was kennzeichnet aktivierende Körperpflege?

●

- | | |
|--|---|
| ☐ A Pflegekraft übernimmt vollständig | ☐ B Pflege nur durch Angehörige |
| ☐ C Ressourcen des Patienten werden einbezogen | ☐ D Verzicht auf Körperpflege |

68 Was ist rückschonendes Arbeiten beim Transfer?

- ☐ A Last körpernah, aus den Beinen heben, Rücken gerade, nicht verdrehen
- ☐ B Last weit vom Körper weg halten und den Rücken verdrehen
- ☐ C Mit gestreckten Beinen bücken
- ☐ D Ruckartig und schnell heben

69 Welcher Faktor erhöht das Sturzrisiko?

- ☐ A Regelmäßige Bewegung
- ☐ B Polypharmazie und Sehstörungen
- ☐ C Rutschfeste Schuhe
- ☐ D Gute Beleuchtung

70 Für welche Patientengruppe ist das Bobath-Konzept vor allem gedacht?

- ☐ A Frisch operierte Patienten mit einer Bauchwunde
- ☐ B Ausschließlich Neugeborene und junge Säuglinge
- ☐ C Menschen mit zentralen neurologischen Störungen, z. B. nach Schlaganfall
- ☐ D Patienten mit einer harmlosen fieberhaften Erkältung

71 Wann ist ein Patientenlifter indiziert?

- ☐ A Bei voll mobilen Patienten, die sich selbstständig bewegen können
- ☐ B Grundsätzlich nie, da ein Transfer immer manuell erfolgen sollte
- ☐ C Ausschließlich während der Nacht zur Entlastung des Personals
- ☐ D Bei schwer immobilen Patienten, die nicht sicher manuell transferiert werden können

72 Welche Maßnahme gehört zur Basis-Thromboseprophylaxe?

- ☐ A Bettruhe ohne Bewegung
- ☐ B Frühmobilisation und Bewegungsübungen
- ☐ C Flüssigkeitsrestriktion
- ☐ D Wärmflasche an den Beinen

73 Was bewirkt die 30-Grad-Schräglage?

- ☐ A Sie fixiert den Patienten dauerhaft in einer festen Position
- ☐ B Sie entlastet Kreuzbein und Trochanter durch Gewichtsverlagerung auf die Gesäßmuskulatur
- ☐ C Sie macht eine regelmäßige Inspektion der Haut überflüssig
- ☐ D Sie dient ausschließlich der erleichterten Nahrungsaufnahme

74 Was ist das Ziel der Mikrolagerung (Mikrobewegung)?

- ☐ A Den Patienten jeweils vollständig auf die andere Seite umzudrehen
- ☐ B Vor allem die Bettwäsche und die Matratze zu schonen
- ☐ C Jede Form von Bewegung möglichst vollständig zu vermeiden
- ☐ D Durch kleine Positionsveränderungen die Druckpunkte regelmäßig leicht zu verändern

75 Was beschreibt die Virchow-Trias?

●●●

- ☐ A Drei verschiedene Bereiche des Blutzuckerspiegels
- ☐ B Die drei Schweregrade eines entstehenden Dekubitus
- ☐ C Gefäßwandschaden, verlangsamter Blutfluss und erhöhte Gerinnungsneigung
- ☐ D Drei aufeinanderfolgende Stufen des Bewusstseins

76 Welche Reihenfolge ist bei der Mobilisation sinnvoll?

●

- ☐ A Sofort gehen, dann hinsetzen
- ☐ B Bett, dann an die Bettkante setzen, sicherer Stand, dann Gehen
- ☐ C Nur passiv im Bett belassen
- ☐ D Direkt Treppen steigen

77 Wofür wird ein Rutsch- bzw. Transferbrett eingesetzt?

●

- ☐ A Zur nicht-invasiven Messung des arteriellen Blutdrucks
- ☐ B Um sitzende Transfers (z. B. Bett-Rollstuhl) zu erleichtern
- ☐ C Zur Versorgung und zum Verbinden von offenen Wunden
- ☐ D Zum Anreichen von Speisen und Getränken beim Essen

78 Welche Sicherheitsmaßnahme gehört zu jedem Rollstuhl-Transfer?

●

- ☐ A Die Feststellbremsen bewusst offen und gelöst lassen
- ☐ B Die Fußstützen des Rollstuhls unten und ausgeklappt lassen
- ☐ C Den Transfer ohne vorherige Ansage an den Patienten beginnen
- ☐ D Bremsen feststellen und auf festes Schuhwerk achten

79 Welche Körperstellen sind in Rückenlage besonders dekubitusgefährdet?

●

- ☐ A Vor allem die Handflächen und die Innenseiten der Unterarme
- ☐ B Kreuzbein, Fersen und Hinterkopf
- ☐ C In erster Linie der Bauchnabel und die umgebende Bauchdecke
- ☐ D Hauptsächlich die Wangen und die seitlichen Gesichtspartien

80 Bei welcher Erkrankung sind Kompressions- bzw. Thrombosestrümpfe mit Vorsicht anzuwenden oder kontraindiziert?

●●●

- ☐ A Bei einer leichten Erkältung mit Schnupfen und Husten
- ☐ B Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
- ☐ C Bei völlig gesunden Beinen ohne jede Gefäßerkrankung
- ☐ D Bei anhaltenden Kopfschmerzen und Migräne des Patienten

5 Notfall & Akutsituationen

20 Fragen

81 Wie ist das Verhältnis von Thoraxkompressionen zu Beatmungen bei der Erwachsenen-Reanimation (ERC 2025)? ●

☐ A 30:2

☐ B 5:1

☐ C 10:2

☐ D 15:2

82 Wann wird die stabile Seitenlage angewendet? ●

☐ A Bei ansprechbaren und wachen Patienten mit klarem Bewusstsein

☐ B Bei einem eingetretenen Kreislaufstillstand ohne Atmung

☐ C Bei bewusstlosen Personen mit normaler (ausreichender) Atmung

☐ D Bei einem Bruch des Beins mit sichtbarer Fehlstellung

83 Wofür steht das 'E' im ABCDE-Schema? ●●

☐ A Erhebung des Elektrolythaushalts und Beurteilung des Ernährungszustands

☐ B Elektrokardiogramm zur fortlaufenden Kontrolle des Herzrhythmus schreiben

☐ C Exposure/Environment – Entkleiden, Untersuchen, Wärmeerhalt

☐ D Erhebung der Eigen- und Fremdanamnese gemeinsam mit den Angehörigen

84 Welches Symptom ist typisch für einen akuten Herzinfarkt? ●●

☐ A Ausschließlich ein isolierter Kopfschmerz ohne jegliche weitere Begleitsymptome

☐ B Ein örtlich eng begrenzter, wandernder Juckreiz am Unterschenkel

☐ C Anhaltender Brustschmerz/Druck, evtl. Ausstrahlung in Arm oder Kiefer, Kaltschweißigkeit

☐ D Ein grundsätzlich in jedem Fall begleitend auftretendes hohes Fieber

85 Wie werden nicht-defibrillierbare Rhythmen (Asystolie, PEA) behandelt? ●●●

☐ A Sofortige Defibrillation mit maximaler Energie, da grundsätzlich jeder Herzstillstand schockbar ist

☐ B Zunächst nur abwarten und den Herzrhythmus über mehrere Minuten hinweg am Monitor beobachten

☐ C Hochwertige Herzdruckmassage und frühzeitig Adrenalin, keine Defibrillation

☐ D Ausschließlich Beatmung ohne begleitende Herzdruckmassage, bis der Notarzt eintrifft

86 Was wird im ABCDE-Schema ZUERST beurteilt? ●

☐ A Exposure

☐ B Breathing

☐ C Airway

☐ D Disability

87 Welche Nummer ist der europaweite Notruf? ●

☐ A 110

☐ B 116117

☐ C 19222

☐ D 112

88 Wie viele Dringlichkeitsstufen hat das Manchester-Triage-System (MTS)?

- ☐ A 5
 ☐ B 3
- ☐ C 6
 ☐ D 4

89 Welche Kompressionsfrequenz empfiehlt der ERC 2025 bei der Reanimation?

- ☐ A 100–120/min
 ☐ B 60–80/min
- ☐ C 80–100/min
 ☐ D 140–160/min

90 Was ist die richtige Erstmaßnahme bei einer kleinflächigen Verbrennung?

- ☐ A Die verbrannte Stelle sofort mit Eis oder einem Kühlakku direkt auf der Haut kühlen
 ☐ B Butter, Speiseöl oder Mehl großzügig auf die verbrannte Hautstelle auftragen
- ☐ C Mit lauwarmem Wasser kühlen, keine Hausmittel, Wunde locker keimarm bedecken
 ☐ D Entstehende Brandblasen umgehend öffnen und die abgelöste Haut vorsichtig entfernen

91 Wofür steht das 'C' im ABCDE-Schema?

- ☐ A Consciousness
 ☐ B Circulation
- ☐ C Control
 ☐ D Capillary

92 Wie tief wird beim Erwachsenen thoraxkomprimiert (ERC 2025)?

- ☐ A 5–6 cm
 ☐ B 2–3 cm
- ☐ C 3–4 cm
 ☐ D 7–8 cm

93 Die MTS-Stufe GRÜN bedeutet ...

- ☐ A 10 min
 ☐ B sofort
- ☐ C nicht dringend, 120 min
 ☐ D normal, 90 min

94 Worauf ist bei der Thoraxkompression zu achten?

- ☐ A Eine möglichst weiche und nachgebende Unterlage unter dem Brustkorb
 ☐ B Nur eine flache, oberflächliche Drucktiefe ohne vollständige Kompression
- ☐ C Harte Unterlage, vollständige Entlastung nach jeder Kompression, Unterbrechungen minimieren
 ☐ D Ein bewusst langsames und gleichmäßiges Drücken mit langen Pausen

95 Wie beginnt die Reanimation beim Kind durch geschultes Personal (ERC 2025)?

- ☐ A Sofort mit 30 Herzdruckmassagen beginnen, noch vor jeder Beatmung
 ☐ B Mit 5 initialen Beatmungen, dann Kompressionen zu Beatmungen im Verhältnis 15:2
- ☐ C Ausschließlich beatmen und dabei ganz auf Kompressionen verzichten
 ☐ D Im Verhältnis 30:2 vorgehen, jedoch vollständig ohne Beatmungen

96 Welche Schockform entsteht durch massiven Flüssigkeits- oder Blutverlust?

● ●

- ☐ A Kardiogener Schock
 ☐ B Septischer Schock
- ☐ C Hypovolämischer Schock
 ☐ D Anaphylaktischer Schock

97 Welche Zeichen sprechen für einen hypovolämischen Schock?

● ●

- ☐ A Blasse, kaltschweißige Haut, schneller schwacher Puls, niedriger Blutdruck
 ☐ B Warme, rosige Haut und langsamer Puls
- ☐ C Hoher Blutdruck und trockene Haut
 ☐ D Rote Wangen und Fieber

98 Was tut man bei einem ansprechbaren Erwachsenen mit vollständiger Atemwegsverlegung durch einen Fremdkörper?

● ●

- ☐ A Sofort mit der Herzdruckmassage beginnen, obwohl der Patient noch bei Bewusstsein und ansprechbar ist
 ☐ B Dem Patienten reichlich Wasser zu trinken geben, um den Fremdkörper hinunterzuspülen
- ☐ C Zunächst abwarten, ob sich der Fremdkörper von selbst durch weiteres Husten löst
 ☐ D Bis zu 5 Rückenschläge, dann bis zu 5 Oberbauchkompressionen (Heimlich) im Wechsel

99 Welcher Wartezeit entspricht die MTS-Stufe ORANGE (sehr dringend)?

● ●

- ☐ A sofort
 ☐ B 10 Minuten
- ☐ C 90 Minuten
 ☐ D 30 Minuten

100 Was wird im ABCDE-Schema unter 'B' beurteilt?

●

- ☐ A Breathing – die Atmung (Atemfrequenz, SpO₂, Auskultation)
 ☐ B Der Blutzuckerspiegel und der allgemeine Stoffwechselzustand des Patienten
- ☐ C Der arterielle Blutdruck und die aktuelle Herzfrequenz
 ☐ D Der Bewusstseinszustand und die Reaktion der Pupillen auf Licht

6 Innere Medizin

20 Fragen

101 Ab welchem Wert spricht man von arterieller Hypertonie?

- ☐ A 140/90 mmHg
- ☐ B 120/80 mmHg
- ☐ C 130/80 mmHg
- ☐ D 160/100 mmHg

102 Welcher Normbereich gilt für Bikarbonat (HCO_3^-) im Blut?

- ☐ A 22–26 mmol/l
- ☐ B 2–6 mmol/l
- ☐ C 40–50 mmol/l
- ☐ D 60–70 mmol/l

103 Welche arterielle Sauerstoffsättigung ($\text{SaO}_2/\text{SpO}_2$) gilt bei Lungengesunden als normal?

- ☐ A Etwa 50–60 %
- ☐ B Etwa 70–80 %
- ☐ C Etwa 95–99 %
- ☐ D Genau 100 % erforderlich

104 Wodurch wird eine arterielle BGA meist gewonnen?

- ☐ A Aus einer gewöhnlichen venösen Verweilkanüle am Handrücken
- ☐ B Aus einer frisch gewonnenen Urinprobe des Patienten
- ☐ C Ausschließlich durch einen kleinen Stich in die Fingerbeere
- ☐ D Durch arterielle Punktion (z. B. A. radialis, nach Allen-Test) oder aus einem arteriellen Katheter

105 Was ist Dysphagie nach Schlaganfall und welche Gefahr besteht?

- ☐ A Hörstörung
- ☐ B Sehstörung
- ☐ C Schluckstörung
- ☐ D Gehstörung

106 Was bedeutet FAST beim Schlaganfall?

- ☐ A Fast, Accurate, Safe, Treatment
- ☐ B Focused Assessment Stroke Tool
- ☐ C First Aid Stroke Treatment
- ☐ D Face, Arms (Armlähmung), Speech

107 Was unterscheidet Asthma bronchiale typischerweise von der COPD?

- ☐ A Es gibt keinen Unterschied
- ☐ B Asthma ist immer irreversibel
- ☐ C Asthma ist meist anfallsartig und weitgehend reversibel
- ☐ D Asthma betrifft nur ältere Raucher

108 Was bedeutet eine Azidose?

- ☐ A Ein pH über 7,45
- ☐ B Ein pH unter 7,35 (Übersäuerung des Blutes)
- ☐ C Ein normaler pH
- ☐ D Ein hoher Sauerstoffwert

109 Ab welchen pH-Werten wird es akut lebensbedrohlich?

● ● ●

- (A) pH unter 7,0 oder über 7,8 (B) Bei den Normalwerten von pH 7,35 und pH 7,45
(C) Bereits bei einem leicht abweichenden pH von 7,30 (D) Bereits bei einem leicht abweichenden pH von 7,50

110 Wie verändert sich die BGA bei einer respiratorischen Azidose (z. B. schwere COPD, Hypoventilation)?

● ● ●

- (A) pH hoch, pCO₂ niedrig (B) pH niedrig, HCO₃ stark erniedrigt
(C) pH normal, alle Werte normal (D) pH niedrig, pCO₂ erhöht

111 Was bedeutet NYHA III bei Herzinsuffizienz?

● ●

- (A) Keine Symptome (B) Symptome in Ruhe
(C) Symptome bei leichter Belastung (D) Symptome bei stärkerer Belastung

112 Was ist die Kussmaul-Atmung?

● ● ●

- (A) Eine flache, langsame und ruhige Atmung während des Schlafs (B) Ein vollständiger Stillstand der Atmung über mehrere Sekunden
(C) Eine tiefe, gleichmäßig beschleunigte Atmung als Kompensation der metabolischen Azidose (D) Eine feuchte, rasselnde Atmung wie beim Lungenödem

113 Was ist das Bobath-Konzept in der Schlaganfallpflege?

● ●

- (A) Dekubitusprophylaxe-Konzept (B) Medikamentöse Therapie
(C) Kommunikationshilfe (D) Rehabilitationskonzept: betroffene

114 Welches Symptom weist auf ein Lungenödem hin?

● ● ●

- (A) Eine trockene, unauffällige Haut ganz ohne begleitende Beschwerden (B) Anhaltende, krampfartige Schmerzen im Bereich des Bauchraums
(C) Eine sichtbare Schwellung im Bereich der großen Gelenke (D) Schwere Atemnot mit brodelnden Rasselgeräuschen, ggf. schaumiger Auswurf

115 Warum darf bei COPD NICHT unkontrolliert hochdosiert O₂ gegeben werden?

● ● ●

- (A) O₂ verschlimmert Bronchitis (B) O₂ ist zu teuer
(C) Hypoxischer Atemantrieb: zu viel (D) Keine Kontraindikation

116 Was findet man typischerweise bei einer respiratorischen Alkalose (Hyperventilation)?

● ● ●

- (A) pH niedrig, pCO₂ hoch (B) pH hoch, HCO₃ stark erhöht
(C) pH hoch, pCO₂ erniedrigt (D) alle Werte normal

117
Welcher BGA-Wert ist der respiratorische (atmungsbedingte) Parameter?

● ●

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☐ A Bikarbonat (HCO_3^-) | ☐ B Base Excess |
| ☐ C Der CO_2 -Partialdruck (pCO_2) | ☐ D Natrium |

118
Welcher pH-Bereich des arteriellen Blutes gilt als normal?

● ●

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ A 6,8–7,0 | ☐ B 7,35–7,45 |
| ☐ C 7,60–7,80 | ☐ D 8,0–8,4 |

119
Welcher Normwert gilt für den arteriellen CO_2 -Partialdruck (pCO_2)?

● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Etwa 5–15 mmHg | ☐ B Etwa 80–100 mmHg |
| ☐ C Etwa 120–140 mmHg | ☐ D Etwa 35–45 mmHg |

120
Welche Symptome sprechen für eine Lungenembolie?

● ● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Plötzliche Atemnot, atemabhängiger Brustschmerz und Tachykardie | ☐ B Über Stunden langsam zunehmende, dumpfe Schmerzen im Bauchraum |
| ☐ C Ein ausgeprägter, großflächiger Juckreiz der gesamten Haut | ☐ D Ausschließlich ein anhaltender, drückender Kopfschmerz |

7 Chirurgie

20 Fragen

121 Welchen Nutzen hat die postoperative Frühmobilisation?

- ☐ A Sie erhöht das Risiko für eine Thrombose deutlich
- ☐ B Sie dient rein kosmetischen und ästhetischen Zwecken
- ☐ C Sie senkt Thrombose-, Pneumonie- und Ileusrisiko und fördert die Darmtätigkeit
- ☐ D Sie ist nach einer Operation grundsätzlich untersagt

122 Welche Zeichen sprechen für eine Wundinfektion?

- ☐ A Eine blasse, kühle und trockene Umgebung der Wunde
- ☐ B Eine auffällig rasche und komplikationslose Heilung
- ☐ C Rötung, Schwellung, Überwärmung, Schmerz und ggf. eitriges Sekret
- ☐ D Das vollständige Ausbleiben jeglicher Veränderung

123 Was ist der postoperative Harnverhalt?

- ☐ A Die Unfähigkeit, die volle Blase spontan zu entleeren
- ☐ B Ein ungewöhnlich häufiges Wasserlassen in kleinen Mengen
- ☐ C Eine bakterielle Infektion der Operationswunde
- ☐ D Ein Verschluss des Darms mit fehlender Passage

124 Wie lange sollen Patienten vor einer geplanten Operation in der Regel nüchtern sein?

- ☐ A Klare Flüssigkeiten bis 2 h, feste Nahrung bis 6 h vorher
- ☐ B Gar nicht nüchtern
- ☐ C 24 Stunden komplett ohne alles
- ☐ D Nur 30 Minuten vorher

125 Was ist ein postoperativer (paralytischer) Ileus?

- ☐ A Eine bakterielle Infektion der frischen Operationswunde
- ☐ B Eine nach der Operation auftretende Entzündung der Lunge
- ☐ C Ein Verschluss einer Vene durch ein Blutgerinnsel
- ☐ D Ein Darmstillstand mit fehlender Peristaltik nach der OP

126 Wie sollte präoperativ eine notwendige Haarentfernung erfolgen?

- ☐ A Mit einer trockenen Rasur bereits am Vortag der Operation
- ☐ B Grundsätzlich gar nicht, indem die Haare herausgerissen werden
- ☐ C Mit einer scharfen Klinge lange Zeit vor dem Eingriff
- ☐ D Wenn nötig zeitnah vor der OP mit einem Clipper kürzen (keine Nassrasur mit Klinge)

127 Wann wird eine Wunddrainage in der Regel entfernt?

● ●

- ☐ A Unmittelbar und grundsätzlich sofort im Anschluss an die Operation
- ☐ B Wenn die Fördermenge deutlich zurückgegangen ist (nach ärztlicher Anordnung)
- ☐ C Grundsätzlich immer erst nach mehreren Wochen, unabhängig von der Fördermenge
- ☐ D Niemals, da eine liegende Wunddrainage dauerhaft im Körper verbleibt

128 Was ist Schmerzerfassung mit NRS und wann handeln?

● ●

- ☐ A Nur einmal täglich erheben
- ☐ B NRS 0-10, ab NRS ≥ 4
- ☐ C Erst auf Nachfrage erheben
- ☐ D Nur bei Schmerzen > 8

129 Was kennzeichnet eine Redon-Drainage?

● ●

- ☐ A Eine geschlossene Saugdrainage mit Unterdruck (Sog)
- ☐ B Eine offene Drainage ohne Sog
- ☐ C Ein Blasenkatheter
- ☐ D Eine Magensonde

130 Warum ist Wärme bei Appendizitisverdacht kontraindiziert?

● ●

- ☐ A Wärme ist erlaubt
- ☐ B Wärme fördert Entzündung
- ☐ C Nur Kälte ist verboten
- ☐ D Es gibt keinen medizinischen Grund

131 Was ist bei der Versorgung eines frisch angelegten Stomas (z. B. Kolostomie) wichtig?

● ● ●

- ☐ A Die umgebende Haut möglichst kräftig und aggressiv reinigen und rubbeln
- ☐ B Das Stoma vorsichtshalber abbinden, um Ausscheidungen zu verhindern
- ☐ C Auf jegliche Beobachtung von Durchblutung und Hautzustand verzichten
- ☐ D Farbe/Durchblutung des Stomas beurteilen, Haut schützen, dichte Versorgung wählen und Betroffene anleiten

132 Wofür steht PONV in der perioperativen Pflege?

● ●

- ☐ A Ein bestimmter gemessener Wert des arteriellen Blutdrucks
- ☐ B Postoperative Übelkeit und Erbrechen (postoperative nausea and vomiting)
- ☐ C Ein spezieller Verbandtyp für frische Operationswunden
- ☐ D Eine bestimmte Lagerungsform des Patienten nach der Operation

133 Was ist der McBurney-Punkt?

● ●

- ☐ A Ein typischer Druckschmerzpunkt im Bereich der erkrankten Niere
- ☐ B Ein charakteristischer Druckpunkt über der entzündeten Gallenblase
- ☐ C Druckschmerzpunkt im rechten Unterbauch bei Appendizitis
- ☐ D Ein bestimmter Schmerzpunkt zur Beurteilung von Herzbeschwerden

134 Worauf achtet die Pflege bei liegender Wunddrainage?

● ●

- | | |
|--|--|
| ☐ A Ausschließlich auf die Farbe und Sauberkeit der Bettwäsche des Patienten | ☐ B Auf Menge und Aussehen des Sekrets, Sog/ Durchgängigkeit und Zeichen einer Nachblutung |
| ☐ C Auf gar nichts, da die Drainage sich vollständig selbst überwacht | ☐ D Nur einmal wöchentlich im Rahmen des routinemäßigen Verbandwechsels |

135 Was ist Thromboseprophylaxe nach TEP?

● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Ausschließlich das Tragen von Kompressionsstrümpfen | ☐ B Die Einhaltung von durchgehender und strenger Bettruhe |
| ☐ C Ausschließlich die tägliche Einnahme von Aspirin | ☐ D NMH, Kompressionsstrümpfe und Frühmobilisation |

136 Warum ist die Ein- und Ausfuhrbilanz postoperativ wichtig?

● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Ausschließlich zur zusätzlichen Beschäftigung des Pflegepersonals | ☐ B Um Flüssigkeitshaushalt, Urinausscheidung und Drainageverluste zu überwachen |
| ☐ C Die Bilanz ist postoperativ ohne wesentliche Bedeutung | ☐ D Sie ist ausschließlich bei Kindern und Säuglingen erforderlich |

137 Was gilt für die Einwilligung (Aufklärung) vor einer Operation?

● ●

- | | |
|---|---|
| ☐ A Auf eine Einwilligung kann in aller Regel verzichtet werden | ☐ B Der Patient muss rechtzeitig aufgeklärt werden und informiert einwilligen |
| ☐ C Über den Eingriff entscheiden grundsätzlich die Angehörigen | ☐ D Die Aufklärung erfolgt erst nach dem Ende der Operation |

138 Was wird beim Verbandwechsel an der Wunde beurteilt und dokumentiert?

● ●

- | | |
|--|---|
| ☐ A Größe/Tiefe, Wundgrund, Wundränder, Sekret (Menge/Geruch) und Entzündungszeichen | ☐ B Ausschließlich die Uhrzeit des Verbandwechsels für die fortlaufende Verlaufsdocumentation |
| ☐ C Nur der vollständige Vor- und Nachname des Patienten zum Abgleich mit der Kurve | ☐ D Lediglich, ob überhaupt ein Verband vorhanden ist, ohne jede weitere Beurteilung |

139 Warum wird vor bestimmten Eingriffen die OP-Seite bzw. -Stelle markiert?

●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Aus rein dekorativen und ästhetischen Gründen der Übersichtlichkeit | ☐ B Vor allem, um während des Eingriffs wertvolle Zeit einzusparen |
| ☐ C Zur Vermeidung von Eingriffsverwechslungen (Patientensicherheit) | ☐ D Das Markieren der Operationsstelle ist eigentlich unüblich |

140 Was sind typische Komplikationen nach Appendektomie?

● ●

- | | |
|--|---|
| ☐ A Wundinfektion | ☐ B Reine Wundschmerzen |
| ☐ C Nur leichte Übelkeit | ☐ D Keine |

8 Pädiatrie

20 Fragen

141 Welchen Vorteil hat Muttermilch für Säuglinge?

- ☐ A Sie liefert bedarfsgerechte Nährstoffe und Abwehrstoffe (Nestschutz)
- ☐ B Sie ist nährstoffärmer als jede Ersatznahrung
- ☐ C Sie erhöht das Infektionsrisiko
- ☐ D Sie enthält keinerlei Antikörper

142 Was ist bei Scharlach zu beachten?

- ☐ A Er wird durch Viren verursacht und braucht keine Behandlung
- ☐ B Er ist nicht ansteckend
- ☐ C Er tritt nur bei Erwachsenen auf
- ☐ D Er wird durch Streptokokken verursacht und mit Antibiotika behandelt

143 Was sind motorische Entwicklungsmeilensteine im 1. Lebensjahr?

- ☐ A Laufen mit 6 Monaten
- ☐ B Kopfkontrolle 3 Mo., Drehen 5-6 Mo.
- ☐ C Sprechen mit 6 Monaten
- ☐ D Alle Kinder entwickeln sich gleich

144 Was sind die Pflichteinsatz-Stunden in der Pädiatrie laut GPA?

- ☐ A 60h
- ☐ B 240h
- ☐ C 120h
- ☐ D 500h

145 Welche Diabetesform tritt typischerweise im Kindes- und Jugendalter auf?

- ☐ A Diabetes Typ 2
- ☐ B Schwangerschaftsdiabetes
- ☐ C Diabetes Typ 1 (absoluter Insulinmangel)
- ☐ D Im Kindesalter kommt kein Diabetes vor

146 Was ist Neugeborenen-Gelbsucht (Neonataler Ikterus)?

- ☐ A Eine bakterielle oder virale Infektion des Neugeborenen
- ☐ B Physiologisch erhöhter Bilirubinwert (meist Tag 2-7)
- ☐ C Eine angeborene, genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung
- ☐ D Eine ernsthafte Erkrankung der noch unreifen kindlichen Leber

147 Was ist bei der Medikamentendosierung bei Kindern zu beachten?

- ☐ A Gewichtsabhängige Dosierung
- ☐ B Gleich wie Erwachsene
- ☐ C Halbe Erwachsenendosis
- ☐ D Immer als Zäpfchen geben

148 Was ist Fieberkrampf und wie reagiert man?

● ●

- ☐ A Sofort mit einer vollständigen Reanimation beginnen
- ☐ B Es handelt sich grundsätzlich um eine echte Epilepsie
- ☐ C Tonisch-klonischer Krampf bei Fieber im Kindesalter
- ☐ D Die alleinige Senkung des Fiebers ist immer ausreichend

149 Was ist Exsikkose beim Kind?

● ●

- ☐ A Austrocknung (Dehydratation)
- ☐ B Eine hartnäckige Verstopfung mit ausbleibendem Stuhlgang
- ☐ C Ein deutliches Übergewicht des Kindes über der Altersnorm
- ☐ D Ein fieberhafter Infekt mit erhöhter Körpertemperatur

150 Was ist Rooming-in und welche Vorteile hat es?

● ●

- ☐ A Möglichkeit für Eltern, rund um die Uhr beim Kind zu bleiben
- ☐ B Ein hotelähnlicher Service für die begleitenden Eltern
- ☐ C Eine Möglichkeit, die ausschließlich auf der Intensivstation gilt
- ☐ D Ein Angebot, das ausschließlich den Müttern offensteht

151 Was sind Normwerte für Atemfrequenz bei Neugeborenen?

● ●

- ☐ A 40-60/min
- ☐ B 12-16/min
- ☐ C 30-40/min
- ☐ D 20-30/min

152 Was sind Normwerte für Herzfrequenz bei Neugeborenen?

● ●

- ☐ A 100-120/min
- ☐ B 120-160/min
- ☐ C 80-100/min
- ☐ D 60-80/min

153 Was sind entwicklungsgerechte Schmerzeinschätzungsinstrumente für Kinder?

● ●

- ☐ A KUSS, FACES-Skala, NRS
- ☐ B Kinder können keinen Schmerz äußern
- ☐ C Allein anhand der Herzfrequenz
- ☐ D Nur NRS 0-10

154 Ab wann gilt ein Neugeborenes als Frühgeborenes?

● ●

- ☐ A Ab einem Geburtsgewicht über 4000 g
- ☐ B Bei einer Geburt nach dem errechneten Termin
- ☐ C Nur bei Zwillingen
- ☐ D Bei Geburt vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche

155 Wie kommuniziert man altersgerecht mit einem kranken Kind?

● ●

- ☐ A Mit Fachbegriffen wie bei Erwachsenen
- ☐ B Indem man seine Ängste bagatellisiert
- ☐ C Indem man gar nicht mit dem Kind spricht
- ☐ D In einfacher, ehrlicher Sprache auf Augenhöhe, unter Einbezug von Spiel und Bezugsperson

156 Was ist Pseudokrupp und wie wird er behandelt?

● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Virös bedingter | ☐ B Echte Diphtherie |
| ☐ C Bronchitis | ☐ D Asthma-Anfall |

157 Was ist Kindesmisshandlung und welche Pflichten hat Pflegepersonal?

● ● ●

- | | |
|--|---|
| ☐ A Betrifft nur körperliche Gewalt | ☐ B Nicht melden |
| ☐ C Erst bei sichtbaren Verletzungen | ☐ D Schutzauftrag nach §8a SGB VIII |

158 Was gehört zur Unfallverhütung bei Kleinkindern?

●

- | | |
|---|---|
| ☐ A Steckdosen im Kinderzimmer bewusst offen und zugänglich lassen | ☐ B Sicherungen wie Treppengitter und Steckdosensicherungen sowie das Wegräumen von Kleinteilen und Giftstoffen |
| ☐ C Reinigungs- und Putzmittel in Reichweite der Kinder aufbewahren | ☐ D Kleinkinder in der Nähe von Wasser unbeaufsichtigt spielen lassen |

159 Was ist eine typische Ursache der Bronchiolitis/obstruktiven Bronchitis bei Säuglingen im Winter?

● ● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Eine Nahrungsmittelallergie | ☐ B Ein Sonnenbrand |
| ☐ C Eine Verletzung | ☐ D Das RS-Virus (RSV) |

160 Wodurch werden Windpocken (Varizellen) verursacht?

● ●

- | | |
|--|---|
| ☐ A Durch Bakterien | ☐ B Durch eine Allergie |
| ☐ C Durch das Varizella-Zoster-Virus | ☐ D Durch Vitaminmangel |

9 Gynäkologie & Geburtshilfe

20 Fragen

161 Warum wird unter der Geburt ein CTG geschrieben?

- ☐ A Nur zur Dokumentation
- ☐ B Um das Gewicht des Kindes zu bestimmen
- ☐ C Um den Blutdruck der Mutter zu messen
- ☐ D Um Wehentätigkeit und kindliche Herztöne zu überwachen und eine Sauerstoffunterversorgung früh zu erkennen

162 Warum ist der Wärmeerhalt beim Neugeborenen so wichtig?

- ☐ A Nur aus Komfortgründen
- ☐ B Das ist nur bei Frühgeborenen relevant
- ☐ C Neugeborene kühlen wegen großer Körperoberfläche und unreifer Thermoregulation schnell aus
- ☐ D Damit sie besser schlafen

163 Worauf muss das Neugeborene einer Mutter mit GDM nach der Geburt überwacht werden?

- ☐ A Auf Hypoglykämie (Unterzucker)
- ☐ B Auf Fieber
- ☐ C Sofort auf Übergewicht
- ☐ D Auf Bluthochdruck

164 Welche medikamentöse Therapie ist bei GDM Mittel der Wahl, wenn Ernährung nicht ausreicht?

- ☐ A Gar keine Therapie
- ☐ B Cortison
- ☐ C Orale Antidiabetika (Tabletten)
- ☐ D Insulin – orale Antidiabetika sind in der Schwangerschaft nicht Mittel der Wahl

165 Was ist die einzige kausale Therapie des HELLP-Syndroms?

- ☐ A Bettruhe
- ☐ B Abwarten bis zum Termin
- ☐ C Die Entbindung
- ☐ D Antibiotika

166 Wofür stehen die Kriterien im APGAR-Score?

- ☐ A Aussehen, Puls, Größe, Atmung, Reaktion
- ☐ B Alter, Puls, Gewicht, Atmung, Reflexe
- ☐ C Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen (Hautfarbe), Reflexe
- ☐ D Atmung, Position, Gewicht, Alter, Reflexe

167 Was spricht für eine korrekte Anlegetechnik?

- ☐ A Das Kind saugt nur ganz kurz
- ☐ B Die Mutter hat starke Schmerzen
- ☐ C Das Kind erfasst nur die Brustwarze
- ☐ D Das Kind erfasst Mamille und großen Teil des Warzenhofs, Lippen nach außen gestülpt

168 Wofür steht die Abkürzung HELLP?

● ●

- (A) Hypertonie, Ejektion, Laktat, Leukozyten, Puls
- (B) Hämolyse, erhöhte Leberwerte (Elevated Liver enzymes), niedrige Thrombozyten (Low Platelets)
- (C) Herz-, Leber- und Lungenproblem
- (D) High Energy Low Level Pressure

169 Warum wird bei drohender Frühgeburt Kortison gegeben?

● ●

- (A) Zur Lungenreifeinduktion des Kindes (Surfactant-Bildung)
- (B) Zur Wehenhemmung
- (C) Gegen Schmerzen
- (D) Zur Blutdrucksenkung

170 Welche Hormone steuern die Laktation?

● ●

- (A) Östrogen und Testosteron
- (B) Cortisol und Thyroxin
- (C) Prolaktin (Milchbildung) und Oxytocin (Milchflussreflex)
- (D) Insulin und Adrenalin

171 Wie geht man bei einer beginnenden Mastitis in der Regel vor?

● ●

- (A) Nur kühlen und nicht mehr anlegen
- (B) Sofort komplett abstillen
- (C) Gar nichts unternehmen
- (D) In der Regel weiterstillen/entleeren, kühlen und schonen – bei Bedarf Antibiose

172 Worauf ist nach einer Sectio pflegerisch besonders zu achten?

● ●

- (A) Nur auf die Wunde
- (B) Strikte Bettruhe für zwei Wochen
- (C) Sofortiges Abstillen
- (D) Konsequente Thromboseprophylaxe – das Risiko ist nach OP und im Wochenbett erhöht

173 Wann wird die U1 durchgeführt?

● ●

- (A) Direkt nach der Geburt
- (B) Nach sechs Wochen
- (C) Am 10. Lebenstag
- (D) Nur bei Auffälligkeiten

174 Welche sind sichere Zeichen des Geburtsbeginns?

● ●

- (A) Vermehrter Appetit
- (B) Sodbrennen und Übelkeit
- (C) Regelmäßige, zunehmende Wehen, Blasensprung und Zeichen
- (D) Nur Rückenschmerzen

175 Welches ist ein typisches Leitsymptom des HELLP-Syndroms?

● ●

- (A) Schmerzen im linken Bein
- (B) Ohrenscherzen
- (C) Halsschmerzen
- (D) Rechtsseitiger Oberbauchschmerz (Leberkapselspannung)

176 Wann wird das Screening auf Gestationsdiabetes (oGTT) durchgeführt?

● ●

- ☐ A Immer im ersten Trimenon
- ☐ B In der 6. SSW
- ☐ C In der 24. bis 28. SSW
- ☐ D Erst nach der Geburt

177 Ist Stillen nach einem Kaiserschnitt möglich?

● ●

- ☐ A Nein, grundsätzlich nicht
- ☐ B Erst nach sechs Wochen
- ☐ C Nur mit Medikamenten
- ☐ D Ja – möglich, oft aber anfangs erschwert und mit Unterstützung

178 Was ist eine typische Indikation für eine Not-Section?

● ●

- ☐ A Wunsch nach schnellerer Geburt
- ☐ B Leichte, unregelmäßige Wehen
- ☐ C Akute Gefährdung des Kindes, z. B. pathologisches CTG mit drohender Hypoxie
- ☐ D Alleinige Erschöpfung der Mutter

179 In welcher Reihenfolge verlaufen die Geburtsphasen?

● ●

- ☐ A Nachgeburt – Eröffnung – Austreibung
- ☐ B Austreibung – Eröffnung – Nachgeburt
- ☐ C Es gibt nur eine einzige Phase
- ☐ D Eröffnungsphase – Austreibungsphase – Nachgeburtsphase

180 Ab wann spricht man von einer Frühgeburt?

● ●

- ☐ A Jede Geburt per Sectio
- ☐ B Geburt nach der 42. SSW
- ☐ C Geburt vor der 40. SSW
- ☐ D Geburt vor abgeschlossener 37. SSW (vor 37+0)

10 Psychiatrie

20 Fragen

181 Was ist Demenz und wie unterscheidet sie sich von Depression?

● ● ●

- ☐ A Demenz ist heilbar
- ☐ B Demenz = organischer
- ☐ C Depression ist schwerer
- ☐ D Beide gleich

182 Was ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung?

● ● ●

- ☐ A Eine Form der Schizophrenie
- ☐ B Eine Depression
- ☐ C Instabile Identität
- ☐ D Eine Angststörung

183 Was ist eine Panikattacke und wie reagiert man als Pflegeperson?

● ●

- ☐ A Akuter Angstanfall mit Herzrasen, Atemnot und Schwindel
- ☐ B Grundsätzlich und sofort den Notarzt hinzurufen
- ☐ C Selbst einen Herzinfarkt vortäuschen zur Beruhigung
- ☐ D Den betroffenen Patienten während des Anfalls allein lassen

184 Was ist Schizophrenie und welche Symptome hat sie?

● ●

- ☐ A Eine gesplante Doppelpersönlichkeit mit zwei Identitäten
- ☐ B Psychische Erkrankung mit Positiv- und Negativsymptomen
- ☐ C Eine Aufspaltung der Persönlichkeit in mehrere Anteile
- ☐ D Wiederkehrende, deutliche Schwankungen der Stimmung

185 Was ist De-Eskalation in der Psychiatrie?

● ●

- ☐ A Fixierung sofort
- ☐ B Aggression verstärken
- ☐ C Medikamente zwangsweise
- ☐ D Systematische Deeskalation

186 Was ist Suizidalität und welche Stufen gibt es?

● ● ●

- ☐ A Kommt nur bei Depression vor
- ☐ B Ist meist nur Simulation
- ☐ C Passive Suizidgedanken → konkrete Pläne → Suizidversuch
- ☐ D Nicht ernst nehmen

187 Was bedeutet Einwilligungsfähigkeit im psychiatrischen Kontext?

● ● ●

- ☐ A Sie ist automatisch mit dem Erreichen der Volljährigkeit gegeben
- ☐ B Die Fähigkeit, Art, Bedeutung und Tragweite einer Maßnahme zu verstehen und frei zu entscheiden
- ☐ C Sie ist völlig gleichbedeutend mit der Geschäftsfähigkeit
- ☐ D Sie liegt in der Zustimmung der nächsten Angehörigen

188 Was sind die Pflichteinsatz-Stunden in der Psychiatrie laut GPA?

- ☐ A 500h
 ☐ B 240h
- ☐ C 120h
 ☐ D 60h

189 Was ist therapeutische Kommunikation in der Psychiatrie?

- ☐ A Die gezielte Ablenkung des Patienten von seinen Problemen
 ☐ B Empathische, wertschätzende und nicht-wertende Gesprächsführung
- ☐ C Klare, direktive Anweisungen und Vorgaben an den Patienten
 ☐ D Die reine Verabreichung der verordneten Medikamente

190 Was ist Milieuthherapie in der Psychiatrie?

- ☐ A Therapeutische Gestaltung der gesamten Stationsumgebung
 ☐ B Eine Form der Umwelttherapie mit Aufenthalt in der Natur
- ☐ C Eine ausschließlich im Einzelsetting durchgeführte Therapie
 ☐ D Eine reine Behandlung allein durch die Gabe von Medikamenten

191 Was ist das Ziel einer Krisenintervention?

- ☐ A Die langfristige ambulante Psychotherapie vollständig zu ersetzen
 ☐ B Kurzfristige Stabilisierung und Entlastung in einer akuten seelischen Ausnahmesituation
- ☐ C Die sofortige Fixierung und Ruhigstellung des Betroffenen
 ☐ D Die akute seelische Krise bewusst zu übergehen und abzuwarten

192 Was zählt zur Negativsymptomatik der Schizophrenie?

- ☐ A Ausgeprägter Wahn mit festen, durch Argumente nicht korrigierbaren Überzeugungen
 ☐ B Optische und akustische Halluzinationen ohne einen erkennbaren realen Auslöser
- ☐ C Ich-Störungen mit dem quälenden Gefühl von außen eingegebener fremder Gedanken
 ☐ D Antriebsmangel, sozialer Rückzug und Affektverflachung

193 Was ist ein Alkoholentzugsdelir (Delirium tremens)?

- ☐ A Eine lebensbedrohliche Entzugskomplikation mit Verwirrtheit, Zittern, Halluzinationen und vegetativen Symptomen
 ☐ B Ein vorübergehender, im Grunde harmloser Kater nach Alkoholkonsum
- ☐ C Eine leichte, rasch abklingende Kopfschmerzphase ohne weitere Folgen
 ☐ D Ein völlig normaler und ungefährlicher Schlafzustand während des Entzugs

194 Was ist bei psychiatrischer Zwangsbehandlung rechtlich zu beachten?

- ☐ A Sie ist jederzeit ohne weitere Voraussetzungen möglich
 ☐ B Sie ist in jedem Fall und ohne Einschränkung erlaubt
- ☐ C Nur mit richterlicher Genehmigung bei Eigen-/Fremdgefährdung (PsychKG)
 ☐ D Das Pflegepersonal entscheidet darüber eigenständig allein

195 Welches Risiko besteht bei längerer Einnahme von Benzodiazepinen?

● ●

- ☐ A Die Entwicklung einer Abhängigkeit
- ☐ B Gar keine Nebenwirkungen
- ☐ C Eine sofortige Heilung von Angst
- ☐ D Blutdruckanstieg als Hauptwirkung

196 Was ist das Konzept der Psychoedukation?

● ●

- ☐ A Ergotherapie
- ☐ B Verhaltenstherapie
- ☐ C Psychiatrie-Studium
- ☐ D Strukturierte

197 Welchen therapeutischen Zweck hat eine klare Tagesstrukturierung?

●

- ☐ A Sie dient ausschließlich der organisatorischen Ordnung der Station
- ☐ B Sie gibt Orientierung, Sicherheit und Halt und fördert Aktivierung und Selbstständigkeit
- ☐ C Sie wirkt sich bei einer Depression eher schädlich aus
- ☐ D Sie kann die Gabe von Medikamenten vollständig ersetzen

198 Was unterscheidet ein Delir von einer Demenz?

● ●

- ☐ A Beide Störungsbilder beginnen gleichermaßen langsam und schleichend
- ☐ B Das Delir beginnt akut und ist meist reversibel, die Demenz entwickelt sich langsam und chronisch
- ☐ C Das Delir ist grundsätzlich ein dauerhafter, bleibender Zustand
- ☐ D Die Demenz tritt typischerweise ganz plötzlich über Nacht auf

199 Was sind extrapyramidale Nebenwirkungen (EPS) von Antipsychotika?

● ● ●

- ☐ A Beschwerden im Bereich von Magen und Darm mit Übelkeit und Durchfall
- ☐ B Verschiedene Formen von Hautausschlägen mit Rötung und Juckreiz
- ☐ C Bewegungsstörungen wie Früh dyskinesien, Parkinsonoid oder Akathisie
- ☐ D Ausschließlich vorübergehende Störungen des Sehvermögens

200 Was ist bei einer akuten Intoxikation (z. B. Alkohol, Drogen) pflegerisch vorrangig?

● ●

- ☐ A Vitalzeichen und Bewusstsein überwachen, Aspiration und Atemdepression vorbeugen
- ☐ B Sofort und vorrangig ein ausführliches Deeskalationsgespräch führen
- ☐ C Den betroffenen Patienten aktiv zum Aufstehen und Gehen zwingen
- ☐ D Dem Patienten zur Stärkung zunächst reichlich Nahrung anbieten

11 Psychologie & Kommunikation

20 Fragen

201 Was beschreibt Maslows Bedürfnispyramide? ● ●

- | | |
|---|---|
| <p>☐ A Fünf aufeinander aufbauende Stufen der zwischenmenschlichen Kommunikation im Team</p> <p>☐ C Fünf Stufen der Stressverarbeitung vom auslösenden Reiz bis zur körperlichen Reaktion</p> | <p>☐ B Fünf grundlegende Lerntypen mit jeweils unterschiedlichen Zugangs- und Verarbeitungswegen</p> <p>☐ D Hierarchie: physiologische Bedürfnisse → Sicherheit → Soziales → Wertschätzung → Selbstverwirklichung</p> |
|---|---|

202 Was ist das Grundanliegen der Basalen Stimulation? ● ● ●

- | | |
|---|--|
| <p>☐ A Durch möglichst viele gleichzeitige Sinnesreize eine bewusst anregende Reizüberflutung erzeugen</p> <p>☐ C Die betroffenen Menschen vorrangig medikamentös rhigstellen und äußere Reize gänzlich vermeiden</p> | <p>☐ B Wahrnehmung, Kommunikation und Bewegung über gezielte Sinnesreize fördern (v. a. bei stark eingeschränkten Menschen)</p> <p>☐ D Den direkten körperlichen Kontakt zum betroffenen Menschen möglichst weitgehend gering halten</p> |
|---|--|

203 Was ist motivierende Gesprächsführung (Motivational Interviewing)? ● ● ●

- | | |
|--|---|
| <p>☐ A Eine direktive Beratung mit klaren Vorgaben an den Patienten</p> <p>☐ C Patientenzentriert: Autonomie und eigene Motivation stärken</p> | <p>☐ B Die reine Vermittlung von Informationen und Fakten</p> <p>☐ D Das gezielte Überreden des Patienten zu einer Entscheidung</p> |
|--|---|

204 Was besagt das 4-Ohren-Modell nach Schulz von Thun? ● ●

- | | |
|---|--|
| <p>☐ A 4 Fehler in der Kommunikation</p> <p>☐ C Jede Nachricht hat 4 Seiten</p> | <p>☐ B 4 Phasen der Kommunikation</p> <p>☐ D 4 Kommunikationsstile</p> |
|---|--|

205 Was betont das transaktionale Stressmodell nach Lazarus? ● ● ●

- | | |
|--|--|
| <p>☐ A Der erlebte Stress hängt ausschließlich von der äußeren Situation selbst ab</p> <p>☐ C Entscheidend ist die persönliche Bewertung einer Situation und die verfügbaren Bewältigungsmöglichkeiten</p> | <p>☐ B Stress wirkt sich auf den Menschen grundsätzlich und in jedem Fall schädlich aus</p> <p>☐ D Der erlebte Stress lässt sich durch den Betroffenen selbst überhaupt nicht beeinflussen</p> |
|--|--|

206 Was ist Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Rosenberg? ● ●

- | | |
|---|--|
| <p>☐ A 4 Schritte: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte</p> <p>☐ C Konfliktmanagement-Kurs</p> | <p>☐ B Schweigen bei Konflikten</p> <p>☐ D Kommunikation ohne Schreien</p> |
|---|--|

207 Was sind die 3 Burnout-Kernkomponenten nach Maslach?

● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und reduzierte Leistung | ☐ B Müdigkeit, Kopfschmerz, Rücken |
| ☐ C Stress, Konflikte, Überstunden | ☐ D Depression, Angst, Panik |

208 Was ist eine Ich-Botschaft in der Kommunikation?

● ●

- | | |
|--|---|
| ☐ A Ein deutlicher Vorwurf an den anderen ('Du machst das immer falsch') | ☐ B Eine klare Anweisung oder ein Befehl an das Gegenüber |
| ☐ C Bewusstes Schweigen, um dem anderen keine Angriffsfläche zu bieten | ☐ D Das Ausdrücken eigener Wahrnehmung und Gefühle ('Ich habe den Eindruck, dass...') |

209 Welche drei Grundhaltungen kennzeichnen die personenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers?

● ● ●

- | | |
|---|---|
| ☐ A Autorität, Distanz, Kontrolle | ☐ B Belehrung, Wertung, Ratschlag |
| ☐ C Empathie, Kongruenz (Echtheit) und bedingungslose Wertschätzung | ☐ D Schweigen, Ignorieren, Ablenken |

210 Was ist Supervision in der Pflege?

● ●

- | | |
|---|---|
| ☐ A Professionelle Reflexion | ☐ B Eine Leistungsbeurteilung |
| ☐ C Kontrolle durch Vorgesetzte | ☐ D Ein Ausbildungspraktikum |

211 Was ist das Transtheoretische Modell (TTM)?

● ● ●

- | | |
|--|--|
| ☐ A 5 Stadien der Verhaltensänderung | ☐ B Kommunikationsmodell |
| ☐ C Lernmodell | ☐ D Stressmodell |

212 Wozu dient Biografiearbeit in der Pflege?

● ●

- | | |
|---|---|
| ☐ A Zur reinen Sammlung von Daten ohne weiteren praktischen Nutzen | ☐ B Zur Überwachung und Kontrolle des Verhaltens der Patienten |
| ☐ C Die Lebensgeschichte zu nutzen, um individuell, sinnstiftend und bedürfnisorientiert zu pflegen | ☐ D Um vergangene Ereignisse im Leben zu bewerten und zu beurteilen |

213 Was hilft in der Kommunikation mit hörgeschädigten Menschen?

●

- | | |
|--|--|
| ☐ A Deutlich und zugewandt sprechen, Blickkontakt halten, ruhige Umgebung, ggf. Schrift oder Gebärden nutzen | ☐ B Von hinten sprechen, damit der Schall den Raum besser ausfüllt |
| ☐ C Möglichst schnell und viel sprechen, um alle Informationen zu vermitteln | ☐ D Beim Sprechen den Mund mit der Hand verdecken, um leiser zu wirken |

214 Was besagt das Axiom 'Man kann nicht nicht kommunizieren' (Watzlawick)?

● ●

- ☐ A Nur bewusst gesprochene Worte gelten als echte Kommunikation
- ☐ B Jedes Verhalten hat Mitteilungscharakter – auch Schweigen oder Wegsehen wirkt kommunikativ
- ☐ C Die Kommunikation ist für das Miteinander im Grunde unwichtig
- ☐ D Ausschließlich schriftlich Festgehaltenes zählt als Kommunikation

215 Was ist aktives Zuhören?

●

- ☐ A Verbale und nonverbale Zuwendung mit Paraphrasieren
- ☐ B Den Patienten einfach ungestört ausreden zu lassen
- ☐ C Während des Gesprächs lediglich zustimmend zu nicken
- ☐ D Dem Gegenüber schweigend und ohne Reaktion zuzuhören

216 Was bedeutet Empathie in der Pflege?

●

- ☐ A Ein Mitgefühl, das die Pflegekraft handlungsunfähig macht
- ☐ B Die Fähigkeit, sich in die Gefühle und Sichtweise des anderen einzufühlen
- ☐ C Eine grundsätzliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Patienten
- ☐ D Das konsequente Durchsetzen der eigenen Meinung

217 Was gehört zur nonverbalen Kommunikation?

●

- ☐ A Die Rechtschreibung und die Grammatik des Geschriebenen
- ☐ B Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blickkontakt und Tonfall
- ☐ C Ausschließlich der reine inhaltliche Sinn der gesprochenen Worte
- ☐ D Die verwendete E-Mail-Adresse und Telefonnummer

218 Welche Frühzeichen können auf berufliche Überlastung hinweisen?

● ●

- ☐ A Ein deutlicher Zuwachs an Energie und beruflicher Freude
- ☐ B Eine spürbar verbesserte Konzentration und Leistungsfähigkeit
- ☐ C Anhaltende Erschöpfung, Zynismus, Schlafstörungen und Rückzug
- ☐ D Keinerlei erkennbare Veränderung im Befinden der Person

219 Was ist im Umgang mit sehbehinderten oder blinden Menschen wichtig?

●

- ☐ A Wortlos und ohne jede Ankündigung am Menschen zu handeln
- ☐ B Sich der Person unbemerkt von hinten zu nähern und sie zu erschrecken
- ☐ C Gegenstände unangekündigt aus ihrer Reichweite zu entfernen
- ☐ D Sich mit Namen ansprechen und vorstellen, Handlungen ankündigen und beschreiben

220 Was ist Progressive Muskelrelaxation (PMR)?

● ●

- ☐ A Eine Sportart
- ☐ B Stressbewältigungstechnik
- ☐ C Eine Massagetechnik
- ☐ D Ein Atemkonzept

12 Altenpflege & Geriatrie

20 Fragen

221 Wozu dienen Kurzzeit- und Verhinderungspflege?

● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Zur vorübergehenden Entlastung pflegender Angehöriger bzw. zur Überbrückung | ☐ B Der dauerhaften Unterbringung im Pflegeheim |
| ☐ C Ausschließlich der medizinischen Rehabilitation | ☐ D Der Finanzierung von Umbaumaßnahmen in der Wohnung |

222 Was regelt das Betreuungsrecht und wann greift es?

● ● ●

- | | |
|--|--|
| ☐ A Rechtliche Betreuung für nicht mehr selbst handlungsfähige Volljährige | ☐ B Den Abschluss und die Inhalte eines Heimvertrags |
| ☐ C Die Vormundschaft für noch minderjährige Kinder | ☐ D Die Feststellung und Einstufung des Pflegegrades |

223 Was ist Mangelernährung im Alter und wie wird sie erkannt?

● ●

- | | |
|---|---|
| ☐ A Selten im Alter | ☐ B Unzureichende Nährstoffzufuhr |
| ☐ C Übergewicht | ☐ D Tritt nur bei Bettlägerigen auf |

224 Was ist Biografiearbeit und warum ist sie in der Altenpflege wichtig?

● ●

- | | |
|--|---|
| ☐ A Eine möglichst lückenlose pflegerische Verlaufsdokumentation | ☐ B Die vollständige medizinische Vorgeschichte des Patienten |
| ☐ C Die Erhebung der Erkrankungen innerhalb der Familie | ☐ D Lebensgeschichte, Gewohnheiten und prägende Erlebnisse erfassen |

225 Was ist bei der Hautpflege alter Menschen zu beachten?

●

- | | |
|--|---|
| ☐ A Die Haut ist dünner und trockener, daher schonende Reinigung und rückfettende Pflege | ☐ B Möglichst heiß und lange baden |
| ☐ C Häufiges Waschen mit stark entfettender Seife | ☐ D Die Haut braucht keine besondere Pflege |

226 Was ist das Neue Begutachtungsassessment (NBA)?

● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Begutachtungsinstrument | ☐ B Ein Pflegeplan |
| ☐ C Eine Pflegediagnose | ☐ D Ein Labortest |

227 Was ist Demenz und welche Formen gibt es?

● ●

- | | |
|--|---|
| ☐ A Kurzzeitgedächtnisschwäche | ☐ B Erworbener kognitiver Abbau |
| ☐ C Normales Altern | ☐ D Depression |

228 Wie kann sich eine Depression im Alter von einer Demenz unterscheiden?

● ● ●

- ☐ A Bei der Depression klagen Betroffene oft selbst über die Beschwerden, während sie bei Demenz eher überspielt werden
- ☐ B Depression und Demenz sind in ihrem Erscheinungsbild vollständig identisch
- ☐ C Eine Depression tritt im höheren Lebensalter grundsätzlich nicht mehr auf
- ☐ D Eine Demenz ist bei rechtzeitiger Behandlung in aller Regel vollständig heilbar

229 Was bedeutet Multimorbidität?

●

- ☐ A Eine einzelne akute Erkrankung
- ☐ B Das gleichzeitige Bestehen mehrerer chronischer Erkrankungen
- ☐ C Eine ansteckende Krankheit
- ☐ D Ein einmaliger Sturz

230 Was ist Sterbebegleitung und welche Zeichen des Sterbens sind zu beobachten?

● ●

- ☐ A Aktive Begleitung: Mundpflege
- ☐ B Arzt anrufen und warten
- ☐ C Sofort Reanimation
- ☐ D Nichts tun

231 Was ist das Heimgesetz NRW (WTG) und was regelt es?

● ● ●

- ☐ A Wohn- und Teilhabegesetz
- ☐ B Regelung der Pflegeausbildung
- ☐ C Krankenhaus-Gesetze
- ☐ D Ambulante Pflege

232 Was ist Inkontinenz und welche Formen gibt es?

● ●

- ☐ A Ausschließlich neurologisch bedingt
- ☐ B Ausschließlich unkontrollierter Stuhlabgang
- ☐ C Belastungs-, Drang-, Überlauf- und Reflexinkontinenz
- ☐ D Normales Altern

233 Was ist der Expertenstandard Sturzprophylaxe?

● ●

- ☐ A Die Anordnung von durchgehender und strenger Bettruhe
- ☐ B Die vorbeugende Fixierung der sturzgefährdeten Person
- ☐ C Risikoeinschätzung und individuelle Sturzpräventionsmaßnahmen
- ☐ D Das durchgehende Hochstellen der seitlichen Bettgitter

234 Was ist eine Patientenverfügung?

● ●

- ☐ A Testamentsverfügung
- ☐ B Heimvertrag
- ☐ C Schriftliche Willensbekundung
- ☐ D Krankenversicherungskarte

235 Was ist Kinästhetik und ihre Bedeutung in der Altenpflege?

● ●

- ☐ A Bewegungslehre
- ☐ B Ergotherapie
- ☐ C Physiotherapie
- ☐ D Sporttherapie

236 Was ist Validation nach Naomi Feil in der Altenpflege?

● ●

- | | |
|--|---|
| ☐ A Schmerzmessung | ☐ B Kommunikationsmethode |
| ☐ C Lagerungstechnik | ☐ D Wundbehandlung |

237 Was ist das SGB XI und welche Leistungen gibt es?

● ● ●

- | | |
|--|--|
| ☐ A Arbeitslosenversicherung | ☐ B Rentenversicherung |
| ☐ C Krankenversicherung | ☐ D Soziale Pflegeversicherung |

238 Was kann die Nahrungsaufnahme bei Menschen mit Demenz unterstützen?

● ●

- | | |
|--|--|
| ☐ A Große, komplizierte Menüs | ☐ B Essen unter Zeitdruck |
| ☐ C Ablenkung durch laute Umgebung | ☐ D Fingerfood, vertraute Speisen, Ruhe und ausreichend Zeit |

239 Was ist der Unterschied zwischen ambulanter und stationärer Altenpflege?

● ●

- | | |
|---|--|
| ☐ A Ambulant = Pflege zu Hause durch einen Pflegedienst | ☐ B Beide finden im Pflegeheim statt |
| ☐ C Stationär ist immer besser | ☐ D Ambulant ist teurer |

240 Was ist Dysphagie und welche Pflegemaßnahmen gibt es?

● ● ●

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☐ A Verstopfung | ☐ B Schluckstörung |
| ☐ C Durst | ☐ D Harninkontinenz |

13 Palliativpflege

20 Fragen

241 Was unterscheidet ein stationäres Hospiz von einer Palliativstation?

- ☐ A Hospiz ist Teil des Krankenhauses
- ☐ B Palliativstation ist im Krankenhaus, Hospiz ist eigenständig
- ☐ C Beide sind identisch
- ☐ D Hospiz nur für Kinder

242 Wie geht man mit Hoffnungen und Wünschen eines Sterbenden um?

- ☐ A Sie sofort als unrealistisch abtun
- ☐ B Sie konsequent ignorieren
- ☐ C Sie den Angehörigen ausreden lassen
- ☐ D Sie ernst nehmen und wertschätzend darauf eingehen

243 Was versteht man unter palliativer Sedierung?

- ☐ A Die gezielte Herbeiführung des Todes
- ☐ B Den kompletten Verzicht auf jede Medikation
- ☐ C Das kontrollierte Herabsetzen des Bewusstseins zur Linderung sonst unstillbarer Symptome
- ☐ D Eine Vollnarkose zur Operation

244 Was regelt eine Vorsorgevollmacht?

- ☐ A Sie bevollmächtigt eine benannte Vertrauensperson, im Ernstfall für einen zu entscheiden
- ☐ B Sie legt nur die Bestattungsart fest
- ☐ C Sie ersetzt das Testament
- ☐ D Sie ist nur für Ärzte bindend, nicht für Angehörige

245 Wozu dient eine Betreuungsverfügung?

- ☐ A Zur Festlegung der Erbfolge
- ☐ B Zur Bestimmung des Sterbeortes
- ☐ C Zur Regelung der Organspende
- ☐ D Als Wunsch, wen das Gericht bei Bedarf als Betreuer bestellen soll

246 Wie geht man mit Ernährung und Flüssigkeit in der Sterbephase um?

- ☐ A Nahrung und Flüssigkeit nicht erzwingen, sondern an Bedürfnis und Wohlbefinden ausrichten
- ☐ B Grundsätzlich in jedem Fall eine Magensonde zur Ernährung legen
- ☐ C Zur Flüssigkeitszufuhr immer eine Dauerinfusion anhängen
- ☐ D Die Aufnahme fester Nahrung aktiv einfordern und erzwingen

247 Warum ist es wichtig, Angehörigen Zeit zum Abschied am Verstorbenen zu geben?

- ☐ A Damit die Formalitäten schneller gehen
- ☐ B Aus rein rechtlichen Gründen
- ☐ C Weil ein bewusster Abschied die Trauerverarbeitung unterstützt
- ☐ D Es ist eigentlich unwichtig

248 Welche Maßnahme lindert Atemnot in der Palliativsituation?

● ●

- ☐ A Eine flache Rückenlagerung ganz ohne Erhöhung des Oberkörpers
- ☐ B Eine kurze, kühle Reizdusche zur allgemeinen Kreislaufanregung
- ☐ C Ein konsequentes Bewegungsverbot zur vollständigen Schonung
- ☐ D Oberkörperhochlagerung, Frischluft, ggf. Opiode

249 Was ist bei der Trauerbegleitung von Angehörigen wichtig?

● ●

- ☐ A Trauer zulassen und individuell begleiten
- ☐ B Trauer schnell beenden
- ☐ C Kontakt vermeiden
- ☐ D Ausschließlich mit Medikamenten behandeln

250 Welches ist ein unsicheres Todeszeichen?

● ●

- ☐ A Die eingetretene und deutlich ausgeprägte Totenstarre des Körpers
- ☐ B Die sichtbaren Totenflecken an den tiefliegenden Körperpartien
- ☐ C Die einsetzenden Fäulnis- und Zersetzungserscheinungen
- ☐ D Fehlende Atmung und fehlender Puls

251 Welche Grundhaltung ist in der Sterbebegleitung besonders wichtig?

● ●

- ☐ A Präsenz und Dasein – aushalten, zuhören und nicht alleinlassen
- ☐ B Möglichst viele Maßnahmen durchführen
- ☐ C Sich emotional völlig zurückziehen
- ☐ D Ständig Ratschläge geben

252 Wie sollte man mit einem Sterbenden über seine Situation sprechen?

● ●

- ☐ A Ihn grundsätzlich anlügen, um ihn zu schonen
- ☐ B Jedes Gespräch über das Sterben vermeiden
- ☐ C Nur mit den Angehörigen, nie mit ihm selbst
- ☐ D Ehrlich, einfühlsam und im Tempo des Betroffenen

253 Was regelt eine Patientenverfügung?

● ●

- ☐ A Die Verteilung des Erbes und die Regelung aller offenen Vermögensangelegenheiten
- ☐ B Die Übernahme und die genaue Aufteilung der entstehenden Pflege- und Heimkosten
- ☐ C Die persönlichen Wünsche zur Bestattung und zur Gestaltung der Trauerfeier
- ☐ D Medizinische Behandlungswünsche für den Fall der Einwilligungsunfähigkeit

254 Welche Lagerung erleichtert einem palliativen Patienten mit Atemnot das Atmen?

● ●

- ☐ A Eine flache Rückenlage ganz ohne jede Erhöhung des Oberkörpers
- ☐ B Eine Kopftieflagerung zur Förderung der Durchblutung des Gehirns
- ☐ C Eine durchgehende Bauchlage zur gezielten Entlastung des unteren Rückens
- ☐ D Eine Oberkörperhochlagerung, ggf. mit Armabstützung (atemerleichternde Position)

255 Was lindert das Durstgefühl eines sterbenden Menschen am besten?

●●

- ☐ A Regelmäßige, sorgfältige Mundpflege und Befeuchten der Lippen
 ☐ B Möglichst große Infusionsmengen
 ☐ C Salzige Speisen
 ☐ D Vollständiger Verzicht auf Mundpflege

256 Welche Medikamente werden bei neuropathischen Schmerzen häufig ergänzend (als Ko-Analgetika) eingesetzt?

●●●

- ☐ A Nur klassische Schmerzmittel wie Paracetamol
 ☐ B Ausschließlich Opioide
 ☐ C Bestimmte Antidepressiva und Antikonvulsiva
 ☐ D Reine Vitaminpräparate

257 Womit lindert man Übelkeit und Erbrechen in der Palliativversorgung?

●●

- ☐ A Mit möglichst viel Nahrung auf einmal
 ☐ B Mit Antiemetika nach ärztlicher Anordnung, angepasst an die Ursache
 ☐ C Ausschließlich mit strikter Bettruhe
 ☐ D Durch tagelanges Nüchternlassen

258 Wie geht man mit terminaler Rasselatmung um?

●●

- ☐ A Lagerung, Aufklärung der Angehörigen, ggf. Anticholinergika
 ☐ B Möglichst aggressiv und in kurzen Abständen wiederholt absaugen
 ☐ C Den Patienten dafür durchgehend flach auf dem Rücken lagern
 ☐ D Den Patienten grundsätzlich tief und dauerhaft sedieren

259 Welche Nebenwirkung tritt regelhaft unter Opioiden auf und muss prophylaktisch behandelt werden?

●●

- ☐ A Durchfall
 ☐ B Haarausfall
 ☐ C Obstipation
 ☐ D Fieber

260 Was gehört zur spirituellen Begleitung am Lebensende?

●●

- ☐ A Ausschließlich medikamentöse Therapie
 ☐ B Nur die Regelung finanzieller Fragen
 ☐ C Das Eingehen auf Sinnfragen, Glauben und persönliche Werte, ggf. mit Seelsorge
 ☐ D Das Ignorieren religiöser Bedürfnisse

14 Rehabilitation

20 Fragen

261 Welche Berufsgruppe ist für die Schlucktherapie bei Dysphagie zuständig? ●●

- ☐ A Die Orthopädie
- ☐ B Die Radiologie
- ☐ C Die Logopädie
- ☐ D Die Dermatologie

262 Warum bezieht man Angehörige in die Rehabilitation ein? ●●

- ☐ A Um sie über Kosten zu informieren
- ☐ B Um ihnen alle Aufgaben allein zu übergeben
- ☐ C Angehörige sollten grundsätzlich herausgehalten werden
- ☐ D Um sie anzuleiten und Reha-Erfolge in den Alltag zu übertragen

263 Was ist eine Anschlussrehabilitation (AHB)? ●

- ☐ A Eine dauerhafte ambulante Versorgung im häuslichen Umfeld
- ☐ B Ein Kuraufenthalt ganz ohne medizinische Notwendigkeit
- ☐ C Ein Aufenthalt in einem Hospiz in der letzten Lebensphase
- ☐ D Reha unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt

264 Was kennzeichnet aktivierend-therapeutische Pflege in der Rehabilitation? ●●

- ☐ A Therapeutische Prinzipien in Pflegehandlungen integrieren
- ☐ B Vollständige Übernahme aller Tätigkeiten
- ☐ C Reine Beobachtung ohne Eingreifen
- ☐ D Strikte Bettruhe

265 Was ist das zentrale Ziel von Leistungen zur Teilhabe (SGB IX)? ●●

- ☐ A Selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- ☐ B Klinikaufenthalt verlängern
- ☐ C Pflegegrad erhöhen
- ☐ D Medikamente reduzieren

266 Was bedeutet der Grundsatz der aktivierenden Pflege? ●

- ☐ A Dem Patienten alle Tätigkeiten abnehmen
- ☐ B Den Patienten möglichst schonen und liegen lassen
- ☐ C Hilfe zur Selbsthilfe – nur so viel Unterstützung wie nötig
- ☐ D Alles möglichst schnell für den Patienten erledigen

267 Was erfasst der FIM (Functional Independence Measure)? ●●●

- ☐ A Ausschließlich die maximal mögliche Gehstrecke des Patienten in zurückgelegten Metern
- ☐ B Nur die grobe Kraft der Hände beim festen Greifen von alltäglichen Gegenständen
- ☐ C Die funktionale Selbstständigkeit inklusive motorischer und kognitiver Anteile
- ☐ D Vorrangig die Sehschärfe und das räumliche Sehvermögen des betroffenen Patienten

268 Was ist das Ziel von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA)?

● ●

- ☐ A Die rein medizinische Genesung
- ☐ B Die dauerhafte Wiedereingliederung ins Arbeitsleben
- ☐ C Die häusliche Grundpflege
- ☐ D Die reine Freizeitgestaltung

269 Wer trägt in der Regel die Reha nach einem Arbeitsunfall?

● ●

- ☐ A Die gesetzliche Pflegekasse des betroffenen Patienten
- ☐ B Das örtlich zuständige Sozialamt der Gemeinde
- ☐ C Die private Haftpflichtversicherung des Verunfallten
- ☐ D Die gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)

270 Was gehört zur Stumpfpflege nach einer Amputation?

● ●

- ☐ A Den Stumpf möglichst nicht berühren
- ☐ B Tägliche Hautinspektion, Reinigung und fachgerechtes Wickeln zur Stumpfformung
- ☐ C Nur einmal wöchentlich kontrollieren
- ☐ D Sofort dauerhaft die Prothese tragen

271 Welcher Grundsatz gilt im deutschen Sozialrecht (SGB)?

● ●

- ☐ A Reha vor Pflege
- ☐ B Pflege vor Reha
- ☐ C Reha statt Pflege immer
- ☐ D Pflege schließt Reha aus

272 In welcher Reihenfolge zieht man einen Menschen mit Halbseitenlähmung aus?

● ●

- ☐ A Zuerst die gesunde Seite ausziehen
- ☐ B Zuerst die betroffene Seite ausziehen
- ☐ C Immer beide Arme gleichzeitig
- ☐ D Die Reihenfolge ist unwichtig

273 Was bedeutet Ressourcenorientierung in der rehabilitativen Pflege?

●

- ☐ A Defizite betonen
- ☐ B Vorhandene Fähigkeiten erkennen und fördern
- ☐ C Alle Tätigkeiten abnehmen
- ☐ D Den Pflegeaufwand reduzieren

274 Wer gehört typischerweise zum interprofessionellen Reha-Team?

●

- ☐ A Ausschließlich Pflegekräfte gemeinsam mit dem Reinigungsdienst
- ☐ B Ausschließlich die behandelnden Ärzte und die Klinikverwaltung
- ☐ C Ausschließlich die nahen Angehörigen des Patienten
- ☐ D Pflege, Ärzte, Physio-/Ergotherapie, Logopädie, Sozialdienst

275 Welchen Nutzen hat ein Rollator?

●

- ☐ A Er gibt Gang- und Standsicherheit und entlastet beim Gehen
- ☐ B Er ersetzt vollständig das Gehen
- ☐ C Er dient nur dem Transport von Gegenständen
- ☐ D Er ist bei Gangunsicherheit ungeeignet

276 Wie geht man bei Spastik richtig vor?

● ● ●

- ☐ A Kräftig und ruckartig dehnen
- ☐ B Das betroffene Glied ruhigstellen und nie bewegen
- ☐ C Ausschließlich kalte Reize einsetzen
- ☐ D Langsame, geführte Bewegungen und korrekte Lagerung statt ruckartiger Dehnung

277 Was ist ein Hauptziel der geriatrischen Rehabilitation?

●

- ☐ A Die vollständige Heilung sämtlicher bestehender Erkrankungen
- ☐ B Erhalt von Selbstständigkeit und Vermeidung von Pflegebedürftigkeit
- ☐ C Die dauerhafte Versorgung des Patienten in der Klinik
- ☐ D Die gezielte Reduzierung der sozialen Kontakte

278 Wer trägt medizinische Reha häufig bei erwerbstätigen Versicherten?

● ●

- ☐ A Die gesetzliche Rentenversicherung
- ☐ B Die Pflegekasse
- ☐ C Das Jobcenter
- ☐ D Die Berufsgenossenschaft

279 Was besagt der sozialrechtliche Grundsatz „Reha vor Pflege“?

● ●

- ☐ A Pflege ist immer günstiger als Rehabilitation
- ☐ B Reha ist nur für junge Menschen vorgesehen
- ☐ C Rehabilitation hat Vorrang, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zu mindern
- ☐ D Pflegebedürftige haben keinen Reha-Anspruch

280 Was misst der Barthel-Index?

● ●

- ☐ A Den Blutdruck
- ☐ B Ausschließlich das Sturzrisiko
- ☐ C Die Selbstständigkeit bei Alltagsaktivitäten (ADL)
- ☐ D Die Nahrungsaufnahme in Kalorien

15 Anerkennung & Berufszulassung

20 Fragen

281 Was gilt für die Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“?

● ●

- ☐ A Jede beliebige Person darf sie ohne Voraussetzung führen
- ☐ B Sie ist völlig frei wählbar und an keine Bedingung geknüpft
- ☐ C Sie ist lediglich eine höfliche Anrede ohne rechtliche Bedeutung
- ☐ D Sie ist geschützt und darf nur mit staatlicher Erlaubnis (Urkunde) geführt werden

282 Was ist die Schweigepflicht in der Pflege?

● ●

- ☐ A Schweigepflicht gilt nur für Ärzte
- ☐ B Alle patientenbezogenen Infos vertraulich
- ☐ C Pflege darf nichts sagen
- ☐ D Angehörige dürfen immer informiert werden

283 Was bedeutet Berufserlaubnis auf Zeit?

● ● ●

- ☐ A Befristete Berufserlaubnis bis zur Anerkennung
- ☐ B Probearbeitsvertrag
- ☐ C Urlaubsregelung
- ☐ D Unbefristete Berufsurkunde

284 Was sind Expertenstandards der DNQP?

● ● ●

- ☐ A Wissenschaftlich begründete Handlungsempfehlungen für die Pflege
- ☐ B Die Prüfungsrichtlinien des Medizinischen Dienstes (MDK)
- ☐ C Verbindliche internationale Standards für die Pflege
- ☐ D Fachliche Vorgaben, die ausschließlich für Ärzte gelten

285 Was ist Bezugspflege?

● ●

- ☐ A Feste Pflegeperson für einen Patienten
- ☐ B Pflege nur durch Angehörige
- ☐ C Täglicher Teamwechsel
- ☐ D Jede Pflegekraft pflegt alle Patienten

286 Wer stellt in der Regel den Pflegegrad fest bzw. begutachtet ihn?

● ●

- ☐ A Ausschließlich der behandelnde Hausarzt allein ohne weitere Beteiligung
- ☐ B Der Medizinische Dienst (MD) bzw. bei Privatversicherten Medicproof
- ☐ C Der jeweilige Arbeitgeber der pflegebedürftigen oder erkrankten Person
- ☐ D Die zuständige Pflegeschule im Rahmen der praktischen Ausbildung

287 Worin unterscheidet sich die Anerkennung von EU- und Drittstaatsabschlüssen häufig?

● ●

- ☐ A Zwischen EU- und Drittstaatsabschlüssen besteht kein Unterschied
- ☐ B EU-Pflegeabschlüsse werden oft automatisch anerkannt, Drittstaatsabschlüsse durchlaufen eine Einzelfallprüfung
- ☐ C Abschlüsse aus Drittstaaten werden grundsätzlich nie anerkannt
- ☐ D Abschlüsse aus EU-Staaten werden grundsätzlich nie anerkannt

288 Was ist ein Defizitbescheid?

● ●

- ☐ A Ablehnungsbescheid
- ☐ B Dokument das wesentliche
- ☐ C Sprachzeugnis
- ☐ D Arbeitsvertrag

289 Was bedeutet die pflegerische Sorgfaltspflicht?

● ●

- ☐ A Man muss die Pflege in möglichst kurzer Zeit erledigen
- ☐ B Pflege ist nach anerkanntem fachlichen Standard sorgfältig und gewissenhaft auszuführen
- ☐ C Aufgetretene Fehler sollen möglichst verdeckt und vertuscht werden
- ☐ D Die sorgfältige Ausführung ist letztlich freiwillig und optional

290 Wann wird eine rechtliche Betreuung eingerichtet?

● ●

- ☐ A Wenn ein Mensch seine Angelegenheiten krankheits- oder behinderungsbedingt nicht mehr selbst regeln kann und keine Vollmacht vorliegt
- ☐ B Grundsätzlich automatisch mit der Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres
- ☐ C Regelmäßig bei jeder stationären Aufnahme in ein Krankenhaus oder eine Klinik
- ☐ D Auf ausdrücklichen Wunsch von Nachbarn, Bekannten oder entfernten Verwandten

291 Was sind die Pflegegrade in Deutschland?

●

- ☐ A 1-5
- ☐ B 0-4
- ☐ C A-D
- ☐ D 1-3

292 Was ist das SGB XI?

● ●

- ☐ A Arbeitsschutzgesetz
- ☐ B Berufsrecht der Pflege
- ☐ C Soziale Pflegeversicherung
- ☐ D Krankenversicherungsgesetz

293 Was schreibt das Arbeitszeitgesetz unter anderem vor?

● ●

- ☐ A Beliebige lange Schichten ohne Pause
- ☐ B Gar keine Ruhezeiten
- ☐ C Dass Nachtdienst grundsätzlich verboten ist
- ☐ D Höchstarbeitszeiten, Ruhepausen und Mindestruhezeiten zwischen den Diensten

294 Was ist vor der Anwendung bestimmter Medizingeräte durch das Personal erforderlich?

● ●

- ☐ A Es sind überhaupt keine Voraussetzungen dafür erforderlich
- ☐ B Eine Einweisung in das jeweilige Gerät (nach Medizinproduktegesetz)
- ☐ C Ein kurzer Blick in den Herstellerprospekt genügt völlig
- ☐ D Die Zustimmung der Küche der Einrichtung ist einzuholen

295
Welche Behörde ist seit 01.01.2024 für Fachweiterbildungs-Anerkennungen in NRW zuständig?

● ●

- ☐ A Bundesgesundheitsministerium
- ☐ B Pflegekammer NRW
- ☐ C BIBB
- ☐ D Bezirksregierung Düsseldorf

296
Wozu dient die Datenbank „anabin“?

● ● ●

- ☐ A Zur Bewertung ausländischer Bildungsabschlüsse und Hochschulen
- ☐ B Der Planung und Verwaltung der Dienste des Personals
- ☐ C Der Bestellung und Nachverfolgung benötigter Medikamente
- ☐ D Der Verwaltung und Abstimmung des Jahresurlaubs

297
Auf wie vielen Modulen beruht das Neue Begutachtungsassessment (NBA) zur Pflegegrad-Einstufung?

● ● ●

- ☐ A Auf zwei Modulen, die körperliche und geistige Fähigkeiten zusammenfassend abbilden
- ☐ B Auf vier Modulen, die sich eng an den früheren klassischen Pflegestufen orientieren
- ☐ C Auf 6 Modulen (z. B. Mobilität, Selbstversorgung, kognitive Fähigkeiten)
- ☐ D Auf zwölf Modulen mit jeweils einem eigenen medizinischen Fachbereich pro Modul

298
Was ist das Ziel eines Anpassungslehrgangs?

● ●

- ☐ A Die deutsche Sprache von Grund auf zu lernen
- ☐ B Festgestellte wesentliche Unterschiede zur deutschen Ausbildung praktisch auszugleichen
- ☐ C Ein komplett neues Studium zu absolvieren
- ☐ D Die Approbation als Arzt zu erlangen

299
Welches Sprachniveau ist für den Anpassungslehrgang erforderlich?

●

- ☐ A B1
- ☐ B A2
- ☐ C B2
- ☐ D C1

300
Was ist die Pflegekammer NRW?

● ● ●

- ☐ A Ein Ausbildungsinstitut
- ☐ B Eine Gewerkschaft
- ☐ C Berufsständische Körperschaft
- ☐ D Ein Krankenhaus

Lösungsschlüssel & Erklärungen

Richtige Antwort und kurze Begründung zu jeder Frage.

Generalistische Ausbildung & Recht

- 1 **C** Der Träger der praktischen Ausbildung (z. B. Krankenhaus, Pflegeeinrichtung, ambulanter Dienst) schließt den Ausbildungsvertrag, zahlt die Vergütung und verantwortet die praktische Ausbildung – organisiert über Kooperationsverträge mit der Pflegeschule und weiteren Einsatzstellen.
- 2 **A** Die generalistische Pflegeausbildung dauert in Vollzeit 3 Jahre, in Teilzeit bis zu 5 Jahre. Sie gliedert sich in theoretischen und praktischen Unterricht an der Pflegeschule und praktische Einsätze bei Trägern der praktischen Ausbildung.
- 3 **A** Vorbehaltene Tätigkeiten (§ 4 PflBG) dürfen nur von ausgebildeten Pflegefachpersonen ausgeübt werden – dazu zählen die Erhebung des Pflegebedarfs, die Organisation und Steuerung des Pflegeprozesses sowie die Analyse und Evaluation der Pflegequalität.
- 4 **A** Die Pflichteinsätze umfassen die stationäre Akutpflege (Krankenhaus), die stationäre Langzeitpflege (z. B. Pflegeheim), die ambulante Pflege sowie je einen Einsatz in der pädiatrischen und der psychiatrischen Versorgung – so wird die generalistische Breite abgedeckt.
- 5 **B** 3. Praxisbegleitung (Ende Jahr 3): komplexe Pflegesituationen, Koordination, Evaluation des gesamten Pflegeprozesses. Gesamter Pflegeprozess inkl. Pflegediagnosen.
- 6 **B** Kinaesthetics: Pflegende lernen natürliche Bewegungsmuster nutzen → weniger Kraftaufwand → Eigenaktivität des Patienten fördern. Weniger Rückenschäden beim Personal.
- 7 **D** Der Pflegeprozess beginnt mit der Informationssammlung (Assessment): Daten über den Menschen, seine Ressourcen und Probleme werden erhoben. Darauf bauen Pflegediagnosen, Zielsetzung, Planung, Durchführung und schließlich die Evaluation auf.
- 8 **C** 1. Praxisbegleitung (Ende Jahr 1): Schwerpunkte CE 01-03. Pflegeprozess anwenden, Körperpflege, Lagerung, Vitalzeichen, Grunddokumentation.
- 9 **D** Evaluation: systematisch prüfen ob Ziele erreicht. Wenn nein → Ursachen analysieren, Plan ändern. Evaluation ist kontinuierlich.
- 10 **B** Die Ausbildung umfasst insgesamt rund 4600 Stunden: etwa 2100 Stunden theoretischen und praktischen Unterricht an der Pflegeschule sowie etwa 2500 Stunden praktische Ausbildung in den Einsatzbereichen.
- 11 **D** Nach etwa zwei Dritteln der Ausbildung findet eine Zwischenprüfung statt, die den Ausbildungsstand feststellt. Ein Nichtbestehen führt nicht automatisch zum Ausbildungsende; in einigen Ländern kann auf diesem Stand ein Pflegefachassistenten-Abschluss aufbauen.
- 12 **B** Vertiefungseinsatz: mind. 500h im 3. Ausbildungsdrittel. Hier findet die praktische Abschlussprüfung statt.
- 13 **B** Zugang bietet in der Regel ein mittlerer Schulabschluss oder ein Hauptschulabschluss zusammen mit einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung bzw. einer landesrechtlich geregelten Pflege(fach)assistentenausbildung.
- 14 **A** Pflegeberufegesetz (PflBG) 2020: Zusammenführung GKP + Altenpflege + Kinderkrankenpflege zur generalistischen Ausbildung. Abschluss: Pflegefachmann/-frau.
- 15 **C** Das Selbstpflegemodell von Dorothea Orem betrachtet den Menschen als grundsätzlich zur Selbstpflege fähig. Pflege wird dann nötig, wenn ein Selbstpflegedefizit besteht – sie gleicht dieses Defizit unterstützend, teilweise oder vollständig kompensierend aus.
- 16 **C** NANDA-I: internationales Klassifikationssystem. Aufbau: Problem (P) + Ätiologie/Ursache (Ä/r/t=related to) + Zeichen/Symptome (Z/m/d/s=manifested by). POP = deutschsprachige Alternative.
- 17 **D** 11 Curriculare Einheiten (CE): strukturieren den Theorieunterricht der GPA. Entwickelt von der Fachkommission nach §53 PflBG. CE 01 = Ausbildungsstart bis CE 11 = Koordination/Steuerung.
- 18 **A** PflBG trat 01.01.2020 in Kraft: vereint GKP, Altenpflege und Kinderkrankenpflege.

- 19 **D** Pflichteinsatz Pädiatrie: 120h in Kinder- und Jugendmedizin. Ebenso Pflicht: 120h Psychiatrie und 500h Vertiefungseinsatz.
- 20 **D** CE 06 'In Akutsituationen sicher handeln': Reanimation 30:2, ABCDE-Schema. 2. Ausbildungsjahr.

Pflegeprozess & Pflegeplanung

- 21 **A** Pflegeplanung: 1. Pflegeproblem (aktuell/potenziell), 2. Pflegeziel (SMART), 3. Pflegemaßnahmen (wer, was, wann), 4. Evaluation.
- 22 **B** Dekubitus-Kategorien: I = nicht-wegdrückbare Rötung (Haut intakt), II = Blasen/Erosion (Teilverlust Dermis), III = Vollhautverlust bis Subkutis, IV = Muskeln/Knochen/Sehnen betroffen.
- 23 **B** Ressourcen: körperliche (kann Arm heben), kognitive (versteht Anweisungen), soziale (Familienhilfe). Müssen explizit dokumentiert werden!
- 24 **C** Pflegebericht: nicht dokumentiert = nicht getan (rechtlich). Inhalt: Vitalzeichen, Maßnahmen, besondere Ereignisse (Sturz, Schmerzen), Reaktionen, Gespräche. Zeitnah = sofort oder spätestens am selben Tag.
- 25 **A** Pflegemaßnahmen müssen konkret sein: WER (wer führt durch?), WAS (welche Maßnahme?), WANN/WIE OFT, WIE (Technik), MIT WAS (Hilfsmittel). Keine vagen Formulierungen!
- 26 **D** Ein Pflegestandard legt verbindlich und nachvollziehbar fest, wie eine bestimmte Pflegemaßnahme (z. B. Katheterisierung, Verbandwechsel) nach aktuellem fachlichen Wissen durchzuführen ist. Er sichert einheitliche Qualität und dient als Orientierung und rechtliche Absicherung.
- 27 **B** C. difficile = Sporenbildner! Sporen sind alkoholresistent → mechanisches Waschen mit Wasser und Seife + Einmalhandtuch. Zusätzlich: Einzelzimmer, Einmalschürze, Handschuhe, Flächendesinfektion mit sporozid wirksamen Mitteln. Keine Darmtransitkost!
- 28 **B** Dauerhaftes Tragen ohne Indikation: falsches Sicherheitsgefühl (Desinfektion wird vergessen), Handschuhe werden zum Übertragungsweg, Hautschäden. Handschuhe ersetzen die Händedesinfektion NICHT – auch nach Handschuhwechsel desinfizieren!
- 29 **D** Pflegeüberleitung (Entlassungsmanagement): Pflegeprobleme, Ressourcen, Maßnahmen, Hilfsmittelbedarf, Medikamente, soziale Situation weitergeben. Expertenstandard DNQP.
- 30 **A** WHO 5 Momente: 1. Vor Patientenkontakt 2. Vor aseptischer Tätigkeit (wichtigster Moment!) 3. Nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten 4. Nach Patientenkontakt 5. Nach Kontakt mit Patientenumgebung. Moment 2 schützt den Patienten, alle anderen schützen auch die Pflegenden.
- 31 **B** Pflegevisite: regelmäßige Überprüfung ob Pflegeziele erreicht, Plan aktuell, Patient zufrieden. Bezugspflegekraft + Patient + ggf. Angehörige. Unterschied: keine Arztvisite!
- 32 **C** NRS: Patient bewertet Schmerz 0-10. Ab NRS ≥ 4 = Handlungsbedarf. Vor und nach Schmerzmedikation dokumentieren. Alternativen: VAS, BPS/CPOT (nicht-kommunikativ).
- 33 **C** Ärztlich: Herzinsuffizienz. Pflegediagnose: 'Beeinträchtigte Körperpflege r/t Kurzatmigkeit m/d/s Erschöpfung beim Waschen'. Eigenständige pflegerische Kompetenz!
- 34 **C** Potenzielle Pflegeprobleme = Risiken: z.B. 'Gefahr eines Dekubitus wegen Immobilität'. Erfordern prophylaktische Maßnahmen.
- 35 **B** Sterile Handschuhe: Anlegen mit Non-Touch-Technik. Vor Öffnen: Verpackung auf Unversehrtheit und Ablaufdatum prüfen. Indikationen: OP, sterile Katheterisierung, Wundversorgung bei tiefen/kontaminierten Wunden, Legen von ZVK.
- 36 **D** Wäschesortierung: Roter Sack = Infektionswäsche (MRSA, C. diff., Norovirus, stark blutig/kontaminiert) → direkt verschließen, nicht im Zimmer sortieren, Handschuhe + Kittel. Weißer Sack = normale Wäsche. Wäsche NIE ausschütteln → Aerosolbildung → Keimverbreitung!
- 37 **B** MRSA-Isolierung: Einzelzimmer (eigenes Bad), Schutzkittel, Handschuhe, FFP2-Maske bei engem Kontakt. Beim Verlassen: PSA im Zimmer ablegen → Händedesinfektion. Besuch möglich (Kittel + Handschuhe). Patienten aufklären und einbeziehen! Screening: Nasen-Rachen-Abstrich.

- 38 **C** Pflegeproblem vollständig: P = Problem + Ä = Ursache/Ätiologie (r/t = related to) + Z = Zeichen (m/d/s = manifested by).
Beispiel: Beeinträchtigte Mobilität r/t Schmerzen m/d/s Schonhaltung.
- 39 **B** SMART: Spezifisch (konkrete Handlung: gehen), Messbar (10m), Attraktiv, Realistisch, Terminiert (3. postop. Tag). Vage Ziele sind nicht auswertbar!
- 40 **A** Henderson (1966): 14 Grundbedürfnisse (Atmen, Essen/Trinken, Ausscheiden, Bewegen, Schlafen, Kleiden, Körpertemperatur, Körperpflege, Gefahrenvermeidung, Kommunizieren, Glauben, Beschäftigung, Spielen/Lernen). Pflege: Hilfe zur Selbstständigkeit.

Prävention & Gesundheitsförderung

- 41 **B** Die Ständige Impfkommision (STIKO) am Robert Koch-Institut erstellt die nationalen Impfeempfehlungen.
- 42 **B** Motivational Interviewing stärkt die intrinsische Motivation zur Verhaltensänderung durch empathische, nicht-konfrontative Gesprächsführung.
- 43 **B** BGM zielt darauf, Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich zu gestalten, Belastungen zu reduzieren und Gesundheit sowie Motivation der Beschäftigten langfristig zu erhalten (z. B. Ergonomie, Rückenschule, Pausenkultur).
- 44 **C** Rückenschonendes Arbeiten: in die Knie gehen und aus den Beinen heben, den Rücken gerade halten, die Last körpernah führen, Drehbewegungen vermeiden und Hilfsmittel bzw. Kinaesthetics nutzen. Das beugt Muskel-Skelett-Erkrankungen vor.
- 45 **D** Beim Fingertest wird die Rötung kurz weggedrückt: Bleibt sie bestehen (nicht wegdrückbar), liegt bereits ein Dekubitus Kategorie 1 vor. Eine wegdrückbare Rötung ist eine reversible Hyperämie.
- 46 **C** Patientenedukation (Information, Schulung, Beratung) stärkt die Gesundheitskompetenz und das Selbstmanagement chronisch Kranker.
- 47 **A** Das RKI ist die zentrale Bundeseinrichtung für Krankheitsüberwachung und Prävention; bei ihm ist auch die STIKO angesiedelt. Die Arzneimittelzulassung übernehmen dagegen BfArM und PEI.
- 48 **A** Das Händedesinfektionsmittel wird in ausreichender Menge über mindestens 30 Sekunden in die trockenen Hände eingerieben; alle Flächen müssen benetzt sein und die Hände die ganze Zeit feucht bleiben.
- 49 **A** Die hygienische Händedesinfektion ist die einfachste und wirksamste Einzelmaßnahme zur Verhütung von Krankenhausinfektionen und zur Eindämmung multiresistenter Erreger.
- 50 **A** Salutogenese fragt nach gesundheitserhaltenden Faktoren. Zentral: Kohärenzgefühl (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit).
- 51 **D** Sekundärprävention erkennt Krankheiten früh (Screening/Früherkennung), z.B. Haut- oder Darmkrebscreening, um rechtzeitig behandeln zu können.
- 52 **D** Sorgfältige Mundpflege, Anregung des Speichelflusses (z. B. Kauen) und ausreichende Flüssigkeit beugen Mundsoor (Pilzbefall) und Parotitis (Ohrspeicheldrüsenentzündung) vor, besonders bei Nahrungskarenz.
- 53 **B** Zur Basis-/physikalischen Thromboseprophylaxe gehören Frühmobilisation, Bewegungsübungen, Kompression (MTPS) und ausreichende Flüssigkeit; medikamentös ergänzt niedermolekulares Heparin. Bettruhe fördert Thrombosen.
- 54 **A** Gegen Tröpfchen- bzw. aerogen übertragene Erreger schützt vor allem ein korrekt sitzender Mund-Nasen-Schutz bzw. eine FFP2/FFP3-Maske, ergänzt um Händehygiene und ggf. eine Schutzbrille.
- 55 **B** Modifizierbare Risikofaktoren wie Rauchen, Bewegungsmangel, Fehlernährung, Übergewicht und Bluthochdruck lassen sich durch Prävention beeinflussen. Alter, Geschlecht und Erbanlagen sind nicht veränderbar.
- 56 **C** Quartärprävention zielt darauf, Patienten vor unnötiger oder schädlicher Über-Diagnostik und Über-Therapie zu schützen (Vermeidung von Overtreatment).
- 57 **C** Die WHO definiert 5 Indikationen: vor Patientenkontakt, vor aseptischer Tätigkeit, nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material, nach Patientenkontakt und nach Kontakt mit der Patientenumgebung.

- 58 **D** Wegen des Kontakts mit Blut und Körperflüssigkeiten ist die Hepatitis-B-Impfung für Pflegepersonal Standard (Arbeitsschutz, ArbMedVV).
- 59 **B** Aufrechte Position (ca. 90°), ruhiges Tempo, kleine Bissen, angepasste Konsistenz (z. B. angedickte Flüssigkeit bei Dysphagie) und Konzentration aufs Schlucken senken das Aspirationsrisiko.
- 60 **C** Empowerment befähigt Menschen, mehr Kontrolle über Entscheidungen und Handlungen zu gewinnen, die ihre Gesundheit beeinflussen.

Mobilität & Bewegung

- 61 **A** Der Rollator hat Räder (oft mit Bremse und Sitz) für kontinuierliches Gehen; ein Gehbock wird angehoben und versetzt und gibt sehr viel Standstabilität.
- 62 **D** Bewegung in vollem Bewegungsausmaß und physiologische Gelenkstellung erhalten die Beweglichkeit. Immobilität fördert Kontrakturen.
- 63 **C** Sturzprophylaxe im Umfeld: ausreichende Beleuchtung, rutschfestes Schuhwerk, Haltegriffe und die Beseitigung von Stolperfallen wie Teppichen und Kabeln.
- 64 **D** Ein Bewegungsförderungsplan wird individuell erstellt (Ressourcen, Risiken, Ziele), regelmäßig evaluiert und dokumentiert – gemäß Expertenstandard Mobilität.
- 65 **D** Bei Orthostase-Gefahr stufenweise mobilisieren (Oberkörper hoch, an die Bettkante setzen, Kreislauf anpassen lassen), um Schwindel und Sturz durch Blutdruckabfall zu vermeiden.
- 66 **C** Der DNQP-Expertenstandard fokussiert systematische Risikoeinschätzung (z.B. Braden) und konsequente Druckentlastung/ Bewegungsförderung zur Vermeidung.
- 67 **C** Aktivierende Pflege bezieht vorhandene Fähigkeiten ein und fördert Selbstständigkeit statt vollständiger Übernahme.
- 68 **A** Rückenschonend: Last körpfernah, aus den Beinen heben (Knie beugen), Rücken gerade halten, Drehbewegungen der Wirbelsäule vermeiden und Hilfsmittel nutzen.
- 69 **B** Sturzrisikofaktoren sind u. a. Polypharmazie (v. a. Sedativa und Antihypertensiva), Seh- und Gleichgewichtsstörungen, Orthostase sowie Umgebungsgefahren.
- 70 **C** Das Bobath-Konzept ist ein neurophysiologischer Ansatz zur Förderung von Menschen mit zentralen Bewegungsstörungen (z. B. Hemiplegie nach Schlaganfall).
- 71 **D** Ein Lifter dient dem sicheren Transfer schwer mobiler Patienten und schützt vor Sturz und Rückenschäden. Anwendung nach Einweisung und mit passendem Gurt.
- 72 **B** Frühmobilisation, Bewegungsübungen, ausreichende Hydratation und ggf. MTPS/medikamentöse Prophylaxe senken das Thromboserisiko.
- 73 **B** Bei der 30°-Schräglage wird das Gewicht auf die weniger gefährdete Gesäßmuskulatur verlagert und die Knochenvorsprünge (Kreuzbein, Trochanter major) werden entlastet.
- 74 **D** Mikrolagerung verlagert durch kleine Bewegungen regelmäßig die Druckpunkte, ohne den Patienten stark umzulagern – schonend und dekubitusprophylaktisch wirksam.
- 75 **C** Die Virchow-Trias nennt die drei Hauptfaktoren der Thromboseentstehung: Gefäßwand- bzw. Endothelschaden, Stase (z. B. durch Immobilität) und Hyperkoagulabilität.
- 76 **B** Mobilisation erfolgt stufenweise und ressourcenorientiert: Aufsetzen, an die Bettkante, sicherer Stand, dann erste Schritte – jeweils mit Kreislauf- und Sicherheitskontrolle.
- 77 **B** Ein Rutsch- bzw. Transferbrett überbrückt den Spalt und erleichtert sitzende Transfers, z. B. vom Bett in den Rollstuhl – schonend für Patient und Pflegekraft.
- 78 **D** Vor dem Transfer: Bremsen von Rollstuhl und Bett feststellen, Fußstützen wegklappen, rutschfeste Schuhe, klare Ansage und ggf. Hilfsmittel nutzen – so werden Stürze vermieden.

- 79 **B** In Rückenlage lasten die höchsten Drücke auf Kreuzbein, Fersen, Hinterkopf und Schulterblättern – die typischen Prädilektionsstellen.
- 80 **B** Bei fortgeschrittener pAVK kann Kompression die ohnehin reduzierte arterielle Durchblutung weiter verschlechtern – daher Vorsicht bzw. Kontraindikation und ärztliche Abklärung.

Notfall & Akutsituationen

- 81 **A** Erwachsene: 30 Kompressionen zu 2 Beatmungen.
- 82 **C** Die stabile Seitenlage ist für bewusstlose Personen mit normaler Atmung: Sie hält die Atemwege frei und beugt einer Aspiration vor. Bei fehlender normaler Atmung: Reanimation.
- 83 **C** E = Exposure/Environment: den Patienten situationsgerecht entkleiden und vollständig untersuchen, dabei Auskühlung vermeiden (Wärmeerhalt).
- 84 **C** Typisch: anhaltender Druck/Schmerz hinter dem Brustbein mit möglicher Ausstrahlung in Arm, Kiefer oder Rücken, Luftnot, Kaltschweißigkeit, Übelkeit. Bei Frauen und Diabetikern oft atypisch.
- 85 **C** Bei Asystolie/PEA wird nicht defibrilliert; im Vordergrund stehen ununterbrochene, hochwertige Thoraxkompressionen und frühzeitig Adrenalin (1 mg i.v.).
- 86 **C** A = Airway: zuerst die Atemwege sichern bzw. freimachen (ggf. mit HWS-Schutz).
- 87 **D** 112 ist der europaweite Notruf für Rettungsdienst und Feuerwehr. 110 ist die Polizei, 116117 der ärztliche Bereitschaftsdienst.
- 88 **A** MTS hat 5 Stufen: Rot (sofort), Orange (10 min), Gelb (30 min), Grün (90 min), Blau (120 min).
- 89 **A** 100–120/min, Drucktiefe 5–6 cm, vollständige Entlastung zwischen den Kompressionen.
- 90 **C** Kleinflächige Verbrennungen mit handwarmem/lauwarmem Wasser kühlen (kein Eis – Erfrierungsgefahr), keine Hausmittel, Blasen nicht öffnen, locker keimarm bedecken. Bei großflächigen Verbrennungen kein ausgedehntes Kühlen (Auskühlung).
- 91 **B** C = Circulation: Puls, Blutdruck, Rekapillarierungszeit, Blutung stillen, Zugang und Volumen.
- 92 **A** Drucktiefe 5–6 cm in der Brustmitte (untere Sternumhälfte).
- 93 **D** Grün = normal/Standard, maximal 90 Minuten.
- 94 **C** Effektive Kompressionen: harte Unterlage, Tiefe 5–6 cm, Frequenz 100–120/min, vollständige Entlastung (Recoil) nach jeder Kompression und minimale Unterbrechungen.
- 95 **B** Beim Kind (durch Fachpersonal): 5 initiale Beatmungen, dann Verhältnis 15:2, Drucktiefe etwa ein Drittel des Brustkorbdurchmessers. Laien dürfen 30:2 anwenden.
- 96 **C** Der hypovolämische Schock entsteht durch Volumenmangel (Blutung, Flüssigkeitsverlust). Weitere Formen: kardiogen, septisch, anaphylaktisch, neurogen.
- 97 **A** Schockzeichen: blasse, kühle, feuchte Haut, Tachykardie mit schwachem Puls, Blutdruckabfall, verlängerte Rekapillarierungszeit sowie Unruhe oder Bewusstseinsstörung.
- 98 **D** Bei ineffektivem Husten: bis zu 5 Rückenschläge zwischen die Schulterblätter, dann bis zu 5 Oberbauchkompressionen (Heimlich), im Wechsel – bis der Fremdkörper heraus ist oder Bewusstlosigkeit eintritt (dann Reanimation).
- 99 **B** Orange = sehr dringend, maximal 10 Minuten.
- 100 **A** B = Breathing: Atmung beurteilen – Atemfrequenz, Atemtiefe/-muster, SpO₂, Auskultation, Thoraxbewegungen; ggf. Sauerstoffgabe.

Innere Medizin

- 101 **A** Hypertonie: $\geq 140/90$ mmHg (mehrfach gemessen in Ruhe). Optimaler RR $< 120/80$. Hypertensive Krise: $> 180/120$ mmHg mit Symptomen $\rightarrow$ Notfall!
- 102 **A** Bikarbonat liegt normal bei etwa 22–26 mmol/l. Es ist der metabolische Parameter und sinkt z. B. bei metabolischer Azidose.
- 103 **C** Normal sind etwa 95–99 %. Unter 90 % besteht eine relevante Hypoxämie. Bei COPD können individuell niedrigere Zielwerte gelten (ärztliche Vorgabe).
- 104 **D** Die arterielle BGA wird durch arterielle Punktion (häufig A. radialis, vorher Allen-Test) oder über einen arteriellen Katheter gewonnen. Die kapilläre BGA (Ohrläppchen) ist eine Alternative mit Einschränkungen.
- 105 **C** Dysphagie = Schluckstörung. Stille Aspiration (kein Husten!) besonders gefährlich $\rightarrow$ Aspirationspneumonie. Logopädie, angepasste Kostform (IDDSI), OK-Hochlagerung beim Essen, kein Strohhalm!
- 106 **D** FAST: F=Face (hängt eine Gesichtshälfte?), A=Arms (beide Arme hebbar?), S=Speech (Sprache undeutlich/fehlend?), T=Time (Uhrzeit notieren, sofort 112!).
- 107 **C** Asthma verläuft typischerweise anfallsartig mit weitgehend reversibler Obstruktion (oft allergisch), während die COPD eine chronische, nur teilreversible Obstruktion ist.
- 108 **B** Azidose = pH unter 7,35 (das Blut ist zu sauer), Alkalose = pH über 7,45. Ursachen können respiratorisch ($p\text{CO}_2$) oder metabolisch (HCO_3^-) sein.
- 109 **A** pH-Werte unter etwa 7,0 oder über 7,8 sind akut lebensbedrohlich (Enzym- und Organfunktion). Der Normbereich ist mit 7,35–7,45 eng.
- 110 **D** Bei respiratorischer Azidose staut sich CO_2 (Hypoventilation): $p\text{CO}_2$ steigt, der pH sinkt. Zur Kompensation steigt später das HCO_3^- (renale Kompensation).
- 111 **C** NYHA III = Symptome (Dyspnoe, Erschöpfung) bereits bei leichter körperlicher Belastung wie Treppensteigen. NYHA I = keine Symptome, NYHA IV = Ruhedyspnoe.
- 112 **C** Die Kussmaul-Atmung ist eine tiefe, regelmäßig vertiefte Atmung, mit der bei metabolischer Azidose (z. B. diabetischer Ketoazidose) vermehrt CO_2 abgeatmet wird.
- 113 **D** Bobath: betroffene Seite aktivieren statt kompensieren. Patient von betroffener Seite ansprechen, Lagerung auf beiden Seiten, alle Aktivitäten beidseitig. Fördert Neuroplastizität.
- 114 **D** Das Lungenödem zeigt sich durch schwere Dyspnoe, feuchte/brodelnde Rasselgeräusche und ggf. schaumigen Auswurf. Sofortmaßnahmen: Oberkörper hoch, Beine tief, Sauerstoff, Arzt.
- 115 **C** COPD mit chronischer Hyperkapnie: hypoxischer Atemantrieb. Zu viel O_2 ($\text{SpO}_2 > 92\%$) $\rightarrow$ Atemdepression $\rightarrow$ CO_2 -Narkose. Ziel- SpO_2 : 88–92%!
- 116 **C** Bei Hyperventilation wird zu viel CO_2 abgeatmet: $p\text{CO}_2$ sinkt, der pH steigt (respiratorische Alkalose). Typisch bei Angst/Panik mit Kribbeln und Pfötchenstellung.
- 117 **C** Der $p\text{CO}_2$ spiegelt die Atmung wider (respiratorischer Parameter). HCO_3^- und Base Excess sind die metabolischen Parameter.
- 118 **B** Der normale arterielle pH liegt bei 7,35–7,45. Werte unter 7,35 bedeuten Azidose, über 7,45 Alkalose. Der Bereich ist eng reguliert.
- 119 **D** Der $p\text{CO}_2$ liegt normal bei etwa 35–45 mmHg. Er ist der respiratorische Parameter und steigt z. B. bei Hypoventilation.
- 120 **A** Die Lungenembolie zeigt sich oft mit plötzlicher Atemnot, atemabhängigem Brustschmerz, Tachykardie, ggf. Husten/Hämoptyse; Ursache meist eine tiefe Beinvenenthrombose. Notfall – 112.

Chirurgie

- 121 **C** Frühmobilisation reduziert Thrombose, Pneumonie, Dekubitus und paralytischen Ileus, fördert Kreislauf und Darmtätigkeit und beschleunigt die Genesung – schmerzadaptiert und sicher durchgeführt.

- 122** **C** Klassische Entzündungszeichen: Rötung, Schwellung, Überwärmung, Schmerz und Funktionseinschränkung – bei Wundinfektion oft mit eitrigem Sekret und ggf. Fieber. Arzt informieren.
- 123** **A** Beim Harnverhalt kann die gefüllte Blase nicht spontan entleert werden (z. B. nach Narkose/Regionalanästhesie). Zeichen: Unterbauchschmerz, tastbare Blase, Harndrang ohne Miktions. Ggf. Einmalkatheterisierung.
- 124** **A** Übliche Nüchternheitsgrenzen: klare Flüssigkeiten bis 2 Stunden, leichte/feste Nahrung bis 6 Stunden vor der Narkose – zur Vermeidung einer Aspiration bei der Narkoseeinleitung.
- 125** **D** Der paralytische Ileus ist eine Darmlähmung mit Stillstand der Peristaltik, z. B. nach Bauch-OP. Zeichen: geblähter Bauch, fehlende Darmgeräusche, Übelkeit/Erbrechen, kein Stuhl-/Windabgang. Frühmobilisation beugt vor.
- 126** **D** Falls nötig, wird zeitnah vor der OP mit einem Clipper gekürzt statt mit Klinge rasiert – Mikroverletzungen durch Klingenrasur erhöhen das Wundinfektionsrisiko.
- 127** **B** Drainagen werden nach ärztlicher Anordnung gezogen, meist wenn die Sekretförderung deutlich nachgelassen hat. Vorher Menge/Verlauf dokumentieren; das Ziehen erfolgt aseptisch.
- 128** **B** NRS: 0=kein Schmerz, 10=maximal. Ab NRS ≥ 4 = Handlungsbedarf. Analgetikum nach Anordnung. Wirkungskontrolle nach 30-60 Min. dokumentieren. Nicht erst bei NRS 8 reagieren!
- 129** **A** Die Redon-Drainage ist eine geschlossene Wunddrainage mit Sog (Unterdruck), die Wundsekret/Blut ableitet und die Wundränder anlegt. Sog und Fördermenge werden überwacht und dokumentiert.
- 130** **B** KEINE Wärme bei Appendizitisverdacht! Wärme $\rightarrow$ Vasodilatation $\rightarrow$ Entzündungsförderung $\rightarrow$ erhöhtes Perforationsrisiko.
- 131** **D** Stomapflege: Vitalität/Farbe (rosig-feucht) beurteilen, Peristomahaut schützen, dicht sitzende Versorgung wählen, Ausscheidung beobachten und die Betroffenen schrittweise zur selbstständigen Versorgung anleiten (Psyche beachten).
- 132** **B** PONV = postoperative Übelkeit und Erbrechen, häufig nach Narkosen (Risiko u. a. Frauen, Nichtraucher, Reisekrankheit). Prophylaxe/Therapie mit Antiemetika, Aspiration vermeiden.
- 133** **C** McBurney-Punkt: rechter Unterbauch, Mitte zwischen Nabel und Spina iliaca anterior superior. Typisch für Appendizitis. Blumberg-Zeichen = Loslassschmerz = Peritonitis-Zeichen!
- 134** **B** Bei Drainagen werden Fördermenge und Sekretbeschaffenheit dokumentiert, Sog und Durchgängigkeit kontrolliert, die Eintrittsstelle beobachtet und Zeichen einer Nachblutung (plötzlich viel frisches Blut) erkannt.
- 135** **D** TEP-Thromboseprophylaxe: TVT-Rate ohne Prophylaxe bis 40%! NMH 4-6 Wochen, Kompressionsstrümpfe, Frühmobilisation. NMH wird subkutan gespritzt, Blutungszeichen beachten.
- 136** **B** Die Bilanzierung (Ein-/Ausfuhr inkl. Urin, Drainagen, Erbrochenes) erkennt frühzeitig Flüssigkeitsdefizite, Nachblutungen oder Nierenprobleme und steuert die postoperative Flüssigkeitstherapie.
- 137** **B** Vor einem Eingriff muss der einwilligungsfähige Patient rechtzeitig ärztlich aufgeklärt werden und einwilligen. Ohne wirksame Einwilligung ist der Eingriff (außer im Notfall) rechtswidrig.
- 138** **A** Beim Verbandwechsel werden Wundgröße/-tiefe, Wundgrund, Wundränder und -umgebung, Sekretmenge, -farbe und -geruch sowie Entzündungszeichen beurteilt und dokumentiert (ggf. Fotodokumentation).
- 139** **C** Die Markierung der Eingriffsstelle und das Team-Time-out (OP-Checkliste) dienen der Patientensicherheit und verhindern Seiten- und Eingriffsverwechslungen.
- 140** **A** Komplikationen nach Appendektomie: Wundinfektion (3-5%), intraabdomineller Abszess (bei Perforation), Darmparalyse/Ileus (Blähbauch, kein Darmgeräusch), Nachblutung. Frühmobilisation reduziert Ileus.

Pädiatrie

- 141** **A** Muttermilch ist optimal an den Bedarf des Säuglings angepasst, leicht verdaulich und enthält Antikörper (v. a. IgA), die einen „Nestschutz“ bieten und Infektionen vorbeugen. Stillen fördert zudem die Mutter-Kind-Bindung.

- 142** **D** Scharlach wird durch A-Streptokokken (Bakterien) verursacht und zeigt sich mit Fieber, Halsschmerzen, Himbeerzunge und feinfleckigem Ausschlag. Er wird mit Antibiotika (z. B. Penicillin) behandelt, um Komplikationen und Folgeerkrankungen vorzubeugen.
- 143** **B** Motorische Meilensteine: 3 Mo. = Kopfkontrolle. 5-6 Mo. = Drehen. 7-8 Mo. = freies Sitzen. 8-10 Mo. = Krabbeln. 10-14 Mo. = Stehen, erste Schritte. Variationsbreite beachten! Alarm: kein Sitzen mit 9 Mo., kein Laufen mit 18 Mo.
- 144** **C** GPA-Pflichteinsatz Pädiatrie: 120h in Kinder- und Jugendmedizin. Ziel: altersspezifische Besonderheiten, Entwicklungsstufen, familienorientierte Pflege.
- 145** **C** Im Kindes- und Jugendalter überwiegt der Diabetes Typ 1, eine Autoimmunerkrankung mit absolutem Insulinmangel. Er erfordert eine lebenslange Insulintherapie. Warnzeichen sind starker Durst, häufiges Wasserlassen, Gewichtsverlust und Müdigkeit.
- 146** **B** Neonataler Ikterus: physiologisch (Tag 2-7), durch Abbau fetaler RBC (höhere Hämoglobin-Konzentration). Pathologisch: innerhalb 24h, >2 Wochen, Reifgeborene >17mg/dl → Phototherapie (Blaulicht 420-490nm). Stillen fördern erhöht Ausscheidung.
- 147** **A** Kinderdosierung: immer mg/kg Körpergewicht. Pharmakokinetik unterschiedlich (Reifung Leber/Niere). Wichtig: Kein Aspirin <12 Jahre (Reye-Syndrom-Risiko!). Kindgerechte Darreichungsform (Saft, Zäpfchen). Elternaufklärung über korrekte Dosierung.
- 148** **C** Fieberkrampf: häufigste Krampfform im Kindesalter (2-4%). Meist generalisiert, <5 Min., selbstlimitierend. Maßnahmen: Kind schützen (Stürze), Seitenlagerung, Zeit messen, Notarzt bei >5 Min. Danach: Fieber senken, Ursache suchen, Eltern aufklären.
- 149** **A** Exsikkose (Dehydratation): häufig bei Kinder durch Erbrechen/Durchfall. Zeichen: trockene Schleimhäute, eingesunkene Fontanelle (Säugling), stehende Hautfalte (>2s), Oligurie, dunkler Urin, Tachykardie, Lethargie. Behandlung: orale/i.v. Rehydratation.
- 150** **A** Rooming-in: Eltern bleiben Tag und Nacht beim Kind. Vorteile: Stärkung Eltern-Kind-Bindung, Stillen fördern, Kind fühlt sich sicher, Eltern lernen Pflege, reduziert Hospitalisierungsangst. Gesetzlich verankert (§ 2 Kinderschutz).
- 151** **A** Normwerte AF: Neugeborene 40-60/min, Säuglinge 30-50/min, Kleinkinder 25-35/min, Schulkinder 20-25/min, Erwachsene 12-18/min. Neugeborene atmen periodisch – kurze Atempausen bis 10s normal!
- 152** **B** Normwerte HF: Neugeborene 120-160/min, Säuglinge 100-140/min, Kleinkinder 90-130/min, Schulkinder 70-110/min, Erwachsene 60-100/min. Wichtig: altersgerechte Normwerte kennen!
- 153** **A** Altersgerechte Schmerzeinschätzung: Neugeborene/Säuglinge → KUSS (Kinder-Unbehagen/Schmerzskala, beobachtungsbasiert). Vorschulkinder → FACES-Skala (Smiley-Skala). Schulkinder ab 8J. → NRS 0-10. Selbstauskunft immer bevorzugen!
- 154** **D** Ein Frühgeborenes ist ein Kind, das vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche (SSW) geboren wird. Je unreifer, desto höher das Risiko für Probleme bei Atmung, Temperaturregulation, Ernährung und Infektabwehr.
- 155** **D** Kinder werden altersgerecht, ehrlich und auf Augenhöhe informiert – in einfacher Sprache, ohne Ängste zu bagatellisieren oder falsche Versprechen zu machen. Spielerische Elemente, Vorbereitung auf Maßnahmen und die Nähe einer Bezugsperson geben Sicherheit.
- 156** **A** Pseudokrupp (Laryngotracheitis): meist viral (Parainfluenza). Symptome: bellender Husten, Heiserkeit, inspiratorischer Stridor, besonders nachts. Behandlung: kühle feuchte Luft (Fenster auf), Kortison (Dexamethason/Rectodelt), Kind beruhigen, bei schwerem Anfall Klinik.
- 157** **D** Kindesmisshandlung: körperlich (Hämatome, Knochenbrüche), emotional (Vernachlässigung, psychische Gewalt), sexuell. Schutzauftrag §8a SGB VIII: Hinweise dokumentieren, Kinderarzt einbeziehen, Kinderschutzteam, ggf. Jugendamt. Schweigepflicht kann zurücktreten!
- 158** **B** Kleinkinder sind sehr neugierig und unfallgefährdet. Zur Prävention gehören Treppen- und Herdschutzgitter, Steckdosensicherungen, das sichere Verwahren von Medikamenten, Reinigungsmitteln und Kleinteilen (Verschluckungsgefahr) sowie Aufsicht am und im Wasser.

- 159 **D** Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist eine häufige Ursache von Bronchiolitis und obstruktiver Bronchitis bei Säuglingen, v. a. in den Wintermonaten. Symptome sind Husten, Atemnot, Giemen und Trinkschwäche; Frühgeborene sind besonders gefährdet.
- 160 **C** Windpocken werden durch das Varizella-Zoster-Virus verursacht und sind hochansteckend. Typisch ist ein juckender, schubweiser Ausschlag mit Bläschen in verschiedenen Stadien. Dasselbe Virus kann später als Gürtelrose (Herpes zoster) reaktivieren.

Cynäkologie & Geburtshilfe

- 161 **D** Das CTG zeichnet Wehen und kindliche Herztöne auf. Herzfrequenzabfälle können auf eine fetale Hypoxie hinweisen.
- 162 **C** Wegen relativ großer Körperoberfläche und unreifer Wärmeregulation drohen Auskühlung/Hypothermie – Abtrocknen, Haut-zu-Haut, Mütze beugen vor.
- 163 **A** Das Kind hat vermehrt Insulin gebildet; nach Wegfall des mütterlichen Zuckerangebots droht eine neonatale Hypoglykämie.
- 164 **D** Reichen Ernährung und Bewegung nicht, wird mit Insulin behandelt; orale Antidiabetika werden in der Schwangerschaft i. d. R. nicht eingesetzt.
- 165 **C** Ursächlich beseitigt wird HELLP nur durch die Entbindung; bis dahin RR-Senkung, Magnesium (Krampfprophylaxe), Kortison (Lungenreife).
- 166 **C** APGAR bewertet Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen und Reflexe (je 0–2 Punkte) bei 1, 5 und 10 Minuten. 7–10 gilt als unauffällig.
- 167 **D** Korrektes Anlegen: Kind erfasst Mamille samt großem Teil des Warzenhofs, Lippen nach außen, Kinn an der Brust – beugt wunden Mamillen vor.
- 168 **B** HELLP = Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets – eine schwere Verlaufsform der Präeklampsie.
- 169 **A** Kortison (Betamethason) beschleunigt die kindliche Lungenreife/Surfactant-Bildung und senkt das Risiko eines Atemnotsyndroms.
- 170 **C** Prolaktin bildet die Milch, Oxytocin löst den Let-down-Reflex aus. Häufiges Anlegen fördert über den Saugreiz beide Hormone.
- 171 **D** Bei Mastitis meist weiterstillen/entleeren (Milchstau lösen!), kühlen, schonen; bei Fieber ggf. Antibiotikum. Abstillen ist selten nötig.
- 172 **D** Nach OP und im Wochenbett ist das Thromboserisiko erhöht: LMWH, Kompression, frühe Mobilisation – plus Wochenbett-Kontrollen (Fundus, Lochien).
- 173 **A** Die U1 erfolgt unmittelbar nach der Geburt (inkl. APGAR). Die U2 folgt am 3.–10. Lebenstag mit dem Neugeborenen-Screening.
- 174 **C** Geburtsbeginn: regelmäßige, zunehmende Wehen, Blasensprung (Fruchtwasserabgang) und Zeichnen (Abgang des blutig-schleimigen Schleimpfropfs).
- 175 **D** Der rechtsseitige Oberbauchschmerz entsteht durch Spannung der Leberkapsel – mit Übelkeit, Kopfschmerz und Hypertonie ein Warnzeichen.
- 176 **C** Der oGTT wird in der 24.–28. SSW durchgeführt, da der GDM meist symptomarm verläuft und sonst unentdeckt bliebe.
- 177 **D** Stillen ist nach Sectio möglich, durch Wundschmerz und verzögerten Milcheinschuss oft erschwert – aktive Stillberatung und schmerzarme Positionen helfen.
- 178 **C** Not-Sectio bei akuter Gefahr für Mutter oder Kind: path. CTG, Nabelschnurvorfal, vorzeitige Plazentalösung, Geburtsstillstand.
- 179 **D** Eröffnungsphase (Muttermund bis 10 cm), Austreibungsphase (vollständige Eröffnung bis Geburt des Kindes, Presswehen), Nachgeburtsphase (Geburt der Plazenta).
- 180 **D** Frühgeburt = Geburt vor abgeschlossener 37. SSW. Je unreifer, desto höher das Risiko für Atemprobleme und Infektionen.

Psychiatrie

- 181** **B** Demenz (ICD-10 F00-F03): organischer, fortschreitender kognitiver Abbau. Depression: affektive Störung, behandelbar. Pseudodemenz: Depression die wie Demenz aussieht → Therapieversuch! Unterscheidung wichtig für Behandlungsplanung.
- 182** **C** Borderline (ICD-10 F60.3): instabile Emotionen, Impulsivität, instabile Beziehungen (Idealisierung/Entwertung), Identitätsstörung, Selbstverletzung, Suizidalität, chronische Leere. DBT (Dialektisch-Behaviorale Therapie) als Behandlung.
- 183** **A** Panikattacke: plötzliche intensive Angst, Herzrasen, Atemnot, Schwindel, Entfremdungsgefühl. Pflegerische Reaktion: ruhig bleiben, bei Patient bleiben, ruhige Stimme, Atemübungen (Ein 4-7-8), Umgebung sichern, keine Dramatisierung.
- 184** **B** Schizophrenie (ICD-10 F20): Positivsymptome = Halluzinationen (häufig akustisch), Wahn, Denkstörungen, Ich-Störungen. Negativsymptome = Affektverflachung, Antriebslosigkeit, sozialer Rückzug. Kein 'gespaltenes Gehirn'!
- 185** **D** De-Eskalation: 1. Sicherheit (Abstand, Fluchtwege), 2. Ruhige Haltung/Stimme, 3. Empathie zeigen, 4. Bedürfnisse erfragen, 5. Wahlmöglichkeiten anbieten, 6. Unterstützung holen. Fixierung immer letztes Mittel!
- 186** **C** Suizidalitätsstufen: passive Suizidgedanken ('wäre besser wenn ich nicht da wäre') → konkrete Pläne (Mittel, Zeit, Ort) → Absicht → Versuch. JEDE Erwähnung ernst nehmen! Direkte Frage erlaubt: 'Denken Sie an Suizid?'
- 187** **B** Einwilligungsfähigkeit meint, dass die Person Wesen, Bedeutung und Folgen einer Behandlung erfassen und danach frei entscheiden kann. Sie wird situationsbezogen beurteilt und ist unabhängig von der Geschäftsfähigkeit. Fehlt sie, greifen Betreuungsrecht bzw. Unterbringungsregeln.
- 188** **C** GPA-Pflichteinsatz Psychiatrie: 120h in psychiatrischer Versorgung. Ziel: Grundlagen psychischer Erkrankungen kennen, therapeutische Kommunikation anwenden.
- 189** **B** Therapeutische Kommunikation: aktives Zuhören, Empathie zeigen, offene Fragen stellen, spiegeln, nicht bewerten, Gefühle ansprechen, Schweigen aushalten. Basis jeder psychiatrischen Pflege.
- 190** **A** Milieutherapie: gesamte Stationsumgebung als therapeutisches Instrument. Elemente: klare Tagesstruktur, soziale Regeln, Gruppenangebote (Ergotherapie, Sport, Kochen), therapeutische Gemeinschaft, Patienten übernehmen Verantwortung.
- 191** **B** Krisenintervention ist zeitlich begrenzte, unmittelbare Hilfe zur Stabilisierung. Ein bekanntes Schema ist BELLA: Beziehung aufbauen, Erfassen der Situation, Linderung der Symptome, Leute einbeziehen, Ansatz zur Problembewältigung. Ziel ist Entlastung und Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit.
- 192** **D** Bei der Schizophrenie beschreibt die Positivsymptomatik ein „Zuviel“ (Wahn, Halluzinationen, Ich-Störungen), die Negativsymptomatik ein „Zuwenig“ (Antriebsmangel, sozialer Rückzug, Affektverflachung, Sprachverarmung). Negativsymptome sind oft schwerer behandelbar.
- 193** **A** Das Delirium tremens ist eine lebensbedrohliche Komplikation des Alkoholentzugs mit Bewusstseins- und Orientierungsstörung, Tremor, Halluzinationen, Unruhe sowie vegetativen Zeichen (Schwitzen, Tachykardie, Blutdruckanstieg). Es erfordert engmaschige Überwachung und Behandlung.
- 194** **C** PsychKG NRW: Zwangseinweisung und -behandlung nur bei unmittelbarer Eigen- oder Fremdgefährdung + richterlicher Genehmigung. Verhältnismäßigkeit! Dokumentation Pflicht. Pflegepersonal hat keine eigenständige Zwangsbefugnis.
- 195** **A** Benzodiazepine wirken angstlösend und beruhigend, bergen aber bei längerer Einnahme ein hohes Abhängigkeitsrisiko sowie Sturz-, Sedierungs- und Toleranzrisiken. Sie werden daher möglichst kurzzeitig und kontrolliert eingesetzt.
- 196** **D** Psychoedukation: strukturierte Vermittlung von Wissen über die Erkrankung (Was ist Schizophrenie?), Medikamente (Wirkung/NW), Frühwarnsymptome, Rückfallprävention. Fördert Compliance und Selbstmanagement.
- 197** **B** Ein strukturierter Tagesablauf (feste Zeiten für Mahlzeiten, Aktivitäten, Ruhe) gibt Orientierung und Sicherheit, wirkt Antriebslosigkeit und Grübeln entgegen und fördert Selbstständigkeit. Er ist zentraler Bestandteil der Milieutherapie, besonders bei Depression und Psychosen.
- 198** **B** Ein Delir entsteht akut (Stunden bis Tage), schwankt im Verlauf und ist bei Behandlung der Ursache (z. B. Infektion, Exsikkose, Medikamente) meist reversibel. Eine Demenz entwickelt sich schleichend und chronisch-fortschreitend. Ein Delir kann eine Demenz überlagern.

- 199 **C** Extrapyramidale Nebenwirkungen sind medikamentös bedingte Bewegungsstörungen: z. B. Früh dyskinesien (Muskelkrämpfe), Parkinsonoid (Rigor, Tremor), Akathisie (Bewegungsunruhe) und Spätdyskinesien. Sie treten v. a. unter typischen Antipsychotika auf und müssen erkannt werden.
- 200 **A** Bei Intoxikation steht die vitale Sicherung im Vordergrund: engmaschige Kontrolle von Bewusstsein, Atmung, Kreislauf; Aspirationsschutz (stabile Seitenlage bei Bewusstseinstörung), Schutz vor Auskühlung und Selbstgefährdung. Psychische Begleitung folgt, wenn der Zustand stabil ist.

Psychologie & Kommunikation

- 201 **D** Maslow: erst wenn Grundbedürfnisse erfüllt, strebt Mensch nach oben. Pflegerrelevant: Physiologische Bedürfnisse (Essen, Trinken, Schmerz) zuerst sichern, dann psychosoziale.
- 202 **B** Die Basale Stimulation fördert Wahrnehmung, Kommunikation und Bewegung durch gezielte, angepasste Sinnesreize (z. B. Berührung, Bewegung). Sie richtet sich v. a. an Menschen mit stark eingeschränkter Eigenaktivität.
- 203 **C** MI (Miller & Rollnick): Patient soll eigene Motivation entwickeln. Prinzipien: Empathie, Diskrepanz entwickeln, Widerstand vermeiden, Selbstwirksamkeit stärken. Höhere Nachhaltigkeit als direktive Beratung.
- 204 **C** Schulz von Thun: Sachinhalt (Info), Selbstoffenbarung (über Sender), Beziehungsebene (zum Empfänger), Appell (was soll Empfänger tun?). Missverständnisse: Sender und Empfänger sprechen/hören auf verschiedenen Ebenen.
- 205 **C** Nach Lazarus entsteht Stress aus der subjektiven Bewertung einer Situation (Bedrohung/Herausforderung) und der Einschätzung der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten (Coping). Nicht die Situation allein, sondern ihre Bewertung ist entscheidend.
- 206 **A** GFK: 1. Beobachtung (ohne Bewertung), 2. Gefühl, 3. Bedürfnis, 4. Bitte (keine Forderung). Unterschied: Beobachtung ≠ Bewertung. Reduziert Konflikte im Team und mit Patienten.
- 207 **A** Burnout-Trias: 1. Emotionale Erschöpfung, 2. Depersonalisation (Zynismus), 3. Reduzierte Leistungsfähigkeit. Messung: Maslach Burnout Inventory (MBI).
- 208 **D** Ich-Botschaften beschreiben die eigene Wahrnehmung und das eigene Gefühl, ohne den anderen anzuklagen. Sie wirken weniger angreifend als Du-Botschaften (Vorwürfe) und fördern konstruktive Gespräche.
- 209 **C** Carl Rogers nennt drei Grundhaltungen: Empathie (einführendes Verstehen), Kongruenz (Echtheit) und bedingungslose Wertschätzung (Akzeptanz) – sie schaffen ein hilfreiches Gesprächsklima.
- 210 **A** Supervision: professionelle Begleitung zur Reflexion beruflicher Situationen. Einzel- oder Gruppensupervision. Ziele: Stressbewältigung, Burnout-Prävention, professionelle Weiterentwicklung, Qualitätssicherung. In der Psychiatriepflege oft Pflicht.
- 211 **A** TTM (Prochaska): Interventionen müssen zum Stadium passen. Bei Absichtslosigkeit: Bewusstsein wecken. Bei Vorbereitung: Handlungsplan. Nicht immer sofort Handlung erwarten!
- 212 **C** Biografiearbeit nutzt die Lebensgeschichte, um Gewohnheiten, Vorlieben und Bedürfnisse zu verstehen und die Pflege individuell und sinnstiftend zu gestalten – besonders wertvoll bei Menschen mit Demenz.
- 213 **A** Hilfreich: dem Menschen zugewandt und deutlich (nicht übertrieben) sprechen, Blickkontakt für das Lippenlesen ermöglichen, Störgeräusche reduzieren, ggf. Schrift, einfache Sprache oder Gebärden nutzen.
- 214 **B** Nach Watzlawick hat jedes Verhalten Mitteilungscharakter: Auch Schweigen, Mimik oder Abwenden senden Botschaften. Man kann sich also nicht 'nicht' verhalten und damit nicht 'nicht' kommunizieren.
- 215 **A** Aktives Zuhören: Blickkontakt, zugewandte Haltung, Nicken, Paraphrasieren ('Sie meinen also...'), Verbalisieren von Gefühlen, offene Fragen. Keine vorschnellen Ratschläge!
- 216 **B** Empathie ist das Einfühlen in Gefühle und Sichtweise des anderen, ohne sich darin zu verlieren. Sie ist Grundlage einer vertrauensvollen Pflegebeziehung – abzugrenzen von handlungslähmendem Mitleid.
- 217 **B** Zur nonverbalen Kommunikation zählen Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blickkontakt, Berührung und der Tonfall (paraverbal). Sie transportiert vor allem Beziehungs- und Gefühlsbotschaften.

- 218 **C** Frühzeichen von Überlastung: anhaltende Erschöpfung, Reizbarkeit oder Zynismus, Schlafstörungen, sozialer Rückzug und nachlassende Leistungsfähigkeit. Frühzeitige Selbstfürsorge und Unterstützung beugen einem Burnout vor.
- 219 **D** Bei sehbehinderten Menschen: sich mit Namen ansprechen/vorstellen, Handlungen ankündigen und beschreiben, Orientierung geben und Gegenstände an ihrem Platz belassen bzw. Änderungen mitteilen.
- 220 **B** PMR nach Jacobson: Muskelgruppen 5-10s anspannen → loslassen → Unterschied wahrnehmen. Evidenzbasiert bei Stress, Angst, Schlafstörungen. Von distal nach proximal (Hände → Arme → Schultern → ...).

Altenpflege & Geriatrie

- 221 **A** Kurzzeitpflege (vorübergehende vollstationäre Pflege, z. B. nach einem Klinikaufenthalt) und Verhinderungspflege (Ersatzpflege bei Ausfall der Pflegeperson) entlasten pflegende Angehörige zeitweise und überbrücken Engpässe. Beide sind Leistungen der Pflegeversicherung (SGB XI).
- 222 **A** Betreuungsrecht (§§1814ff BGB seit 2023): wenn Volljähriger aufgrund Krankheit/Behinderung Angelegenheiten nicht selbst regeln kann → Betreuungsgericht bestellt Betreuer. Vorrang: Vorsorgevollmacht! Betreuer handelt im Wohl der betreuten Person.
- 223 **B** Mangelernährung (Malnutrition): häufig im Alter und bei Demenz. Screening: MNA-SF (Mini Nutritional Assessment Short Form) bei Aufnahme. Risikofaktoren: Kaustörungen, Schluckstörungen (Dysphagie), Demenz, Depression, Medikamente. Maßnahmen: Lieblingsspeisen, angereicherte Kost, Trinknahrung, Ernährungsberatung.
- 224 **D** Biografiearbeit: bei Demenz oft einziger Zugang zum Menschen. Lieblingsspeisen, Musikgeschmack, Berufsbiografie, Rituale kennen → personenzentrierte Pflege. Biografiebogen bei Aufnahme ausfüllen, Angehörige einbeziehen.
- 225 **A** Im Alter wird die Haut dünner, trockener und empfindlicher (weniger Talg, geringere Elastizität). Empfehlenswert sind schonende Reinigung, nicht zu heißes Wasser, milde Waschsubstanzen und rückfettende Pflege, um Hautrisse, Juckreiz und Infektionen zu vermeiden.
- 226 **A** NBA: bewertet 6 Module: 1.Mobilität, 2.Kognition/Kommunikation, 3.Verhaltensweisen, 4.Selbstversorgung, 5.Krankheitsbewältigung, 6.Alltagsgestaltung. Geistige/psychische Beeinträchtigungen gleichwertig wie körperliche!
- 227 **B** Demenz: erworbener, fortschreitender Abbau kognitiver Funktionen. Häufigste Form: Alzheimer (60-70%). Weitere: vaskuläre Demenz (Durchblutungsstörungen), Lewy-Körper-Demenz, frontotemporale Demenz. Nicht heilbar, aber behandelbar!
- 228 **A** Bei einer Altersdepression klagen Betroffene häufig selbst über Gedächtnis- und Antriebsprobleme und wirken traurig oder verzweifelt, während Menschen mit beginnender Demenz Defizite oft bagatellisieren. Die Abgrenzung ist wichtig, da eine Depression gut behandelbar ist (Pseudodemenz).
- 229 **B** Multimorbidität bezeichnet das gleichzeitige Vorliegen mehrerer chronischer Erkrankungen bei einem Menschen – im Alter sehr häufig. Sie erhöht die Komplexität von Behandlung und Pflege und begünstigt u. a. Polypharmazie und Wechselwirkungen.
- 230 **A** Sterbezeichen: Rasselatmung (Sekret), Cheyne-Stokes-Atmung (periodisch), Totenflecken (Livores), kühle/blaue Extremitäten, Bewusstlosigkeit, fehlende Reflexe. Pflegerische Maßnahmen: Mundpflege (wichtigste Maßnahme!), Lagerung, Schmerzkontrolle, Familie informieren und einbeziehen, ruhige Atmosphäre.
- 231 **A** WTG NRW (Wohn- und Teilhabegesetz): regelt stationäre Pflegeeinrichtungen, Tages-/Kurzzeitpflege, Wohngemeinschaften. Heimaufsicht prüft: Personalschlüssel, Qualitätsstandards, Bewohnerrechte, Hygiene, Sicherheit. Bewohner haben Recht auf: Selbstbestimmung, Privatsphäre, Besuch.
- 232 **C** Harninkontinenz: Belastung (Husten/Lachen), Dranginkontinenz (plötzlicher Harndrang), Überlaufinkontinenz (volle Blase), Reflexinkontinenz (neurogen). Würdevoller Umgang! Kontinenzförderung (Blasentraining, Beckenbodenübungen) vor Inkontinenzversorgung. Expertenstandard Kontinenzförderung DNQP.
- 233 **C** Expertenstandard Sturzprophylaxe (DNQP): Risikoeinschätzung bei Aufnahme (z.B. STRATIFY). Maßnahmen: rutschfeste Schuhe, Gehhilfen, Rufanlage in Reichweite, Medikamentenreview (Sedativa!), Umgebung sturzfrei gestalten, Toilettenpläne, Bewegungsförderung. Keine FEM als ersten Schritt!

- 234** **C** Patientenverfügung (§1827 BGB): schriftlich, unterschrieben, datiert. Legt fest welche medizinischen Maßnahmen gewünscht/abgelehnt werden (z.B. keine künstliche Ernährung, kein Reanimationsversuch). Bindend wenn konkret und auf aktuelle Situation anwendbar!
- 235** **A** Kinästhetik in der Altenpflege: besonders wichtig bei immobilen, schwer pflegebedürftigen Menschen. Pflegende führen Bewegungen nicht durch sondern begleiten sie. Weniger Rückenschäden beim Personal, mehr Würde für Bewohner, Eigenaktivität auch bei Schwerstpflegebedürftigen fördern.
- 236** **B** Validation: demenzkranker Mensch sagt 'Ich muss nach Hause zu meinen Kindern' → NICHT: 'Ihre Kinder sind erwachsen' → SONDERN: 'Sie vermissen Ihre Kinder sehr.' Gefühle ernst nehmen, nicht in Realität zwingen.
- 237** **D** SGB XI Leistungen: Pflegegeld (für häusliche Pflege durch Angehörige), Sachleistung (ambulanter Pflegedienst), Kombinationsleistung, vollstationäre Pflege, Kurzzeitpflege (bis 8 Wochen/Jahr), Verhinderungspflege (bis 6 Wochen), Entlastungsbetrag 125€/Monat.
- 238** **D** Bei Demenz helfen leicht essbares Fingerfood, vertraute und beliebte Speisen, eine ruhige Essatmosphäre, klare Präsentation, ausreichend Zeit und Anleitung. So bleiben Selbstständigkeit und eine ausreichende Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme möglichst lange erhalten.
- 239** **A** Ambulante Pflege: Patient bleibt zu Hause, ambulanter Dienst kommt. SGB XI: Sachleistung bis PG5 2.200€/Monat. Stationäre Pflege: Umzug ins Pflegeheim, Eigenanteil gestiegen. Zwischenformen: Tagespflege (tagsüber), Kurzzeitpflege (bis 8 Wo.), Nachtpflege, betreutes Wohnen.
- 240** **B** Dysphagie: Schluckstörung häufig nach Schlaganfall, bei Demenz, Parkinson, ALS. Pflegemaßnahmen: 90° Sitzposition, IDDSI-Kostform (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative: püriert, weich-stückig), kein Strohhalm, kein Kopf zurückneigen, Logopädie. Aspirationsgefahr!

Palliativpflege

- 241** **B** Die Palliativstation ist in ein Krankenhaus integriert (Krisenintervention, Symptomkontrolle), das Hospiz ist eine eigenständige Einrichtung für die letzte Lebensphase.
- 242** **D** Hoffnungen und Wünsche Sterbender – auch scheinbar unrealistische – werden ernst genommen und wertschätzend begleitet. Hoffnung kann sich wandeln (z. B. von Heilung hin zu einem friedlichen Abschied) und gibt Halt.
- 243** **C** Palliative Sedierung senkt kontrolliert und in der niedrigst nötigen Dosis das Bewusstsein, um sonst unerträgliche, therapierefraktäre Symptome (z. B. Atemnot, Unruhe) zu lindern. Sie zielt nicht auf den Tod ab und ist von aktiver Sterbehilfe klar abzugrenzen.
- 244** **A** Mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigt man eine Vertrauensperson, im Fall der eigenen Entscheidungsunfähigkeit Angelegenheiten (z. B. Gesundheit, Aufenthalt, Finanzen) zu regeln – so wird oft eine gerichtliche Betreuung vermieden.
- 245** **D** In einer Betreuungsverfügung äußert man im Voraus, wen das Betreuungsgericht – falls eine rechtliche Betreuung nötig wird – als Betreuerin oder Betreuer bestellen (oder gerade nicht bestellen) soll.
- 246** **A** In der Sterbephase steht das Wohlbefinden im Vordergrund. Nahrung und Flüssigkeit werden nicht erzwungen; nachlassender Appetit und Durst sind Teil des Sterbeprozesses. Wichtiger als eine Zwangsernährung sind gute Mundpflege und Zuwendung.
- 247** **C** Ein bewusster, würdevoller Abschied am Verstorbenen hilft Angehörigen, den Verlust zu begreifen, und unterstützt eine gesunde Trauerverarbeitung. Pflegende schaffen dafür einen ruhigen, ungestörten Rahmen.
- 248** **D** Atemnot wird durch Oberkörperhochlagerung, Frischluft/Ventilator, Beruhigung und ggf. niedrig dosierte Opiode gelindert.
- 249** **A** Trauer ist ein individueller Prozess. Begleitung bedeutet Zuhören, Dasein und das Zulassen von Gefühlen ohne Bewertung.
- 250** **D** Unsichere Todeszeichen wie Atem- und Pulsstillstand, Blässe, Areflexie oder weite Pupillen können auch bei Bewusstlosigkeit oder Scheintod auftreten. Erst sichere Zeichen (Totenflecke, Totenstarre, Fäulnis) beweisen den Tod.
- 251** **A** Oft ist nicht das „Machen“, sondern das „Dasein“ entscheidend: Präsenz, Zuhören, das Aushalten von Nähe und Stille sowie das Signal „Ich lasse dich nicht allein“ geben Sterbenden Sicherheit und Würde.

- 252** **D** Gute Kommunikation am Lebensende ist wahrhaftig und zugleich einfühlsam: Man belügt den Betroffenen nicht, drängt ihm aber auch keine Informationen auf, sondern orientiert sich an seinem Tempo und seinen Fragen.
- 253** **D** Die Patientenverfügung legt im Voraus fest, welche medizinischen Maßnahmen gewünscht/abgelehnt werden, falls die Person sich nicht mehr äußern kann (§1827 BGB).
- 254** **D** Eine Oberkörperhochlagerung und atemerleichternde Positionen (z. B. Kutschersitz, Armabstützung) entlasten die Atemmuskulatur und lindern Atemnot. Ergänzend helfen frische Luft/Ventilator, Ruhe und ärztlich angeordnete Medikamente (z. B. Opioide).
- 255** **A** Das Durstgefühl Sterbender entsteht meist durch eine trockene Mundschleimhaut, nicht durch einen Flüssigkeitsmangel im Körper. Häufige, sorgfältige Mundpflege und das Befeuchten der Lippen lindern es besser als Infusionen.
- 256** **C** Neuropathische Schmerzen sprechen oft nur begrenzt auf klassische Analgetika an. Als Ko-Analgetika werden u. a. bestimmte Antidepressiva (z. B. Amitriptylin, Duloxetin) und Antikonvulsiva (z. B. Gabapentin, Pregabalin) eingesetzt.
- 257** **B** Übelkeit und Erbrechen werden ursachenorientiert mit Antiemetika (z. B. Metoclopramid, Haloperidol, Dimenhydrinat) behandelt; ergänzend helfen kleine Portionen, frische Luft, Mundpflege und eine ruhige Umgebung.
- 258** **A** Das Sekretrasseln belastet meist die Angehörigen mehr als den Sterbenden. Maßnahmen: Lagerung, Aufklärung, zurückhaltendes Absaugen, ggf. Anticholinergika.
- 259** **C** Opioide verursachen fast immer Obstipation. Eine Laxanzien-Prophylaxe gehört daher zur Standardbegleitung der Opioidtherapie.
- 260** **C** Spirituelle Begleitung nimmt Sinn-, Glaubens- und Wertefragen ernst, unabhängig von einer bestimmten Religion. Sie kann Gespräche, Rituale oder die Einbindung von Seelsorge umfassen und ist Teil des ganzheitlichen Palliativansatzes.

Rehabilitation

- 261** **C** Bei einer Schluckstörung (Dysphagie) ist die Logopädie für Diagnostik und Schlucktraining zuständig; die Pflege setzt Empfehlungen (Kostkonsistenz, Positionierung) im Alltag um.
- 262** **D** Das Einbeziehen und Anleiten von Angehörigen sichert die Übertragung von Reha-Erfolgen in den Alltag, stärkt die Selbstständigkeit des Betroffenen und beugt zugleich einer Überforderung der Angehörigen vor.
- 263** **D** Die AHB schließt sich direkt an eine Akutbehandlung (z.B. OP, Schlaganfall) an, um den Behandlungserfolg zu sichern.
- 264** **A** Aktivierend-therapeutische Pflege integriert therapeutische Konzepte (z.B. Bobath, Kinästhetik) in den pflegerischen Alltag und fördert Reha-Ziele rund um die Uhr.
- 265** **A** Das SGB IX zielt auf Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung.
- 266** **C** Aktivierende (rehabilitative) Pflege folgt dem Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“: Der Mensch wird angeleitet und ermutigt, vorhandene Fähigkeiten selbst einzusetzen; unterstützt wird nur dort, wo es nötig ist.
- 267** **C** Der FIM misst die funktionale Selbstständigkeit und berücksichtigt neben motorischen auch kognitive Bereiche (z. B. Kommunikation, soziale Kognition, Problemlösung).
- 268** **B** Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA, berufliche Reha) zielen auf die dauerhafte Wiedereingliederung ins Erwerbsleben – z. B. Umschulung, Qualifizierung oder behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung.
- 269** **D** Für die Rehabilitation nach einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit ist die gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) zuständig und leistet „mit allen geeigneten Mitteln“.
- 270** **B** Nach einer Amputation gehören tägliche Hautinspektion, sorgfältige Reinigung und fachgerechtes Wickeln (Kompression) zur Ödemreduktion und Formung des Stumpfes zur Vorbereitung der Prothesenversorgung.
- 271** **A** Der Grundsatz 'Reha vor Pflege' (SGB) bedeutet: Rehabilitationsmaßnahmen sollen Pflegebedürftigkeit vermeiden oder mindern, bevor Pflege greift.
- 272** **A** Beim Ausziehen wird die gesunde Seite zuerst befreit, sodass der weniger bewegliche betroffene Arm anschließend leichter aus dem Kleidungsstück geführt werden kann („gesund zuerst aus, betroffen zuerst an“).

- 273 **B** Ressourcenorientierung knüpft an vorhandene Fähigkeiten an und stärkt Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit.
- 274 **D** Interprofessionelle Rehabilitation verbindet u.a. Pflege, Medizin, Physio-, Ergotherapie, Logopädie und Sozialdienst.
- 275 **A** Ein Rollator ist ein Gehhilfsmittel, das Stand- und Gangsicherheit erhöht, das Gehen entlastet und mit Sitzfläche Pausen ermöglicht – er fördert Mobilität und Selbstständigkeit.
- 276 **D** Bei Spastik werden ruckartige Reize und schnelle Dehnungen vermieden, da sie den Muskeltonus steigern. Hilfreich sind langsame geführte Bewegungen, physiologische Lagerung und Physiotherapie (z. B. nach Bobath).
- 277 **B** Geriatrische Reha will Alltagskompetenz und Selbstständigkeit erhalten bzw. wiederherstellen - Grundsatz 'Reha vor Pflege'.
- 278 **A** Bei Erwerbstätigen trägt medizinische Rehabilitation häufig die gesetzliche Rentenversicherung, um die Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen (Grundsatz „Reha vor Rente“).
- 279 **C** Nach dem Grundsatz „Reha vor Pflege“ soll durch rechtzeitige Rehabilitation Pflegebedürftigkeit vermieden, überwunden oder gemindert werden – Reha hat also Vorrang vor reinen Pflegeleistungen.
- 280 **C** Der Barthel-Index erfasst den Grad der Selbstständigkeit bei Aktivitäten des täglichen Lebens (z. B. Essen, Waschen, Ankleiden, Mobilität) und dient als Verlaufsmaß in der Rehabilitation.

Anerkennung & Berufszulassung

- 281 **D** Die Berufsbezeichnung ist gesetzlich geschützt und darf nur führen, wer die staatliche Erlaubnis (Berufsurkunde) besitzt – nach bestandener deutscher Ausbildung oder erfolgreicher Anerkennung. Das unbefugte Führen ist nicht zulässig.
- 282 **B** Schweigepflicht §203 StGB: alle Heilberufsangehörigen. Verletzung = Straftat. Ausnahme: Kindeswohlgefährdung.
- 283 **A** Berufserlaubnis auf Zeit (§64 PflBG): ermöglicht Berufsausübung während laufendem Anerkennungsverfahren. Befristet, widerrufbar.
- 284 **A** DNQP-Expertenstandards: Dekubitusprophylaxe, Sturzprophylaxe, Schmerzmanagement, Ernährungsmanagement, Kontinenzförderung. Maßstab guter Pflege.
- 285 **A** Bezugspflege (Primary Nursing): eine PK kontinuierlich für bestimmte Patienten zuständig. Vorteile: Beziehungskontinuität, bessere Patientenkenntnis.
- 286 **B** Für die Feststellung des Pflegegrades begutachtet der Medizinische Dienst (MD) – bei Privatversicherten Medicproof – die Pflegebedürftigkeit im Auftrag der Pflegekasse. Grundlage ist das Neue Begutachtungsassessment (NBA).
- 287 **B** Pflegeabschlüsse aus EU-/EWR-Staaten werden aufgrund EU-rechtlicher Regelungen häufig automatisch anerkannt. Abschlüsse aus Drittstaaten durchlaufen dagegen meist eine individuelle Gleichwertigkeitsprüfung mit ggf. Anpassungslehrgang oder Kenntnisprüfung.
- 288 **B** Defizitbescheid: dokumentiert konkret Abweichungen der ausländischen Ausbildung von der deutschen. Grundlage für Anpassungslehrgang oder Kenntnisprüfung.
- 289 **B** Die Sorgfaltspflicht verpflichtet Pflegende, ihre Tätigkeit nach dem aktuellen anerkannten Stand des Wissens und gewissenhaft auszuführen. Ein Verstoß (z. B. grobe Nachlässigkeit mit Schaden) kann zivil-, arbeits- und strafrechtliche Folgen haben.
- 290 **A** Eine rechtliche Betreuung wird vom Betreuungsgericht eingerichtet, wenn ein volljähriger Mensch seine Angelegenheiten krankheits- oder behinderungsbedingt nicht mehr selbst besorgen kann und keine wirksame Vorsorgevollmacht besteht. Sie ist auf die nötigen Aufgabenbereiche begrenzt.
- 291 **A** Pflegegrade 1-5 nach SGB XI seit 2017. PG1 = geringe Beeinträchtigung, PG5 = schwerste Beeinträchtigung. Einstufung durch MDK.
- 292 **C** SGB XI = Sozialgesetzbuch XI = Soziale Pflegeversicherung seit 1995. Regelt Leistungen bei Pflegebedürftigkeit.
- 293 **D**

Das Arbeitszeitgesetz regelt u. a. die werktägliche Höchstarbeitszeit, vorgeschriebene Ruhepausen und die Mindestruhezeit (in der Regel 11 Stunden) zwischen zwei Diensten. Es schützt die Gesundheit der Beschäftigten – gerade im Schichtdienst der Pflege.

- 294 **B** Nach dem Medizinproduktegesetz (z. B. MPBetreibV) dürfen aktive Medizinprodukte nur von eingewiesenem Personal betrieben werden. Die Einweisung in Funktion und sichere Handhabung (z. B. Infusionspumpe, Beatmungsgerät) wird dokumentiert.
- 295 **B** Seit 01.01.2024 Pflegekammer NRW für Fachweiterbildungs-Anerkennungen. Grundausbildungen: Bezirksregierungen NRW.
- 296 **A** anabin ist eine Informationsdatenbank zur Bewertung und Einordnung ausländischer Bildungsabschlüsse und Hochschulen. Sie unterstützt Behörden und Antragstellende bei der Einschätzung, wie ein ausländischer Abschluss eingeordnet wird.
- 297 **C** Das NBA erfasst die Selbstständigkeit in sechs Modulen: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen/psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen sowie Gestaltung des Alltagslebens. Daraus ergibt sich der Pflegegrad.
- 298 **B** Der Anpassungslehrgang gleicht die im Defizitbescheid festgestellten wesentlichen Unterschiede aus. Er findet überwiegend in der Praxis (mit theoretischen Anteilen) statt und schließt mit einem Abschlussgespräch bzw. einer Bewertung ab.
- 299 **C** B2-Deutschkenntnisse Pflicht – nötig für Fachunterricht und Patientenkommunikation.
- 300 **C** Pflegekammer NRW: Körperschaft des öffentlichen Rechts. Mitgliedschaft für exam. Pflegefachkräfte Pflicht. Aufgaben: Berufsregister, Weiterbildungsanerkennung (seit 2024), Berufsordnung.



Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de

Mündliche Prüfungssimulation



20 Fallbeispiele im echten Prüfungsdialog – Prüferfrage, Musterantwort und komplette Pflegeplanung nach PESR und SMART.

Bestehen ist planbar.

Innere

Chirurgie

Neurologie

Onkologie

Urologie

Gynäkologie

HNO

Psychologie

20

Fallbeispiele

8

Fachbereiche

PESR

Pflegeplanung

INHALT

1

So übst du mit diesem Heft

2

Fallbeispiele nach Fachbereich

△ Lernhilfe zur Prüfungsvorbereitung. Musterantworten zeigen einen möglichen Lösungsweg – maßgeblich sind deine Lehrinhalte und die Anforderungen deiner Prüfer.

So übst du mit diesem Heft

Die mündliche Prüfung läuft fast immer gleich ab: Krankheitsbild, Symptome, Diagnostik und Therapie, Pflegeplanung.

1 · ZU ZWEIT ÜBEN

Eine Person liest die Prüferfrage vor, die andere antwortet frei. Danach mit der Musterantwort vergleichen.

2 · LAUT SPRECHEN

Antworte immer laut und in ganzen Sätzen. So trainierst du genau das, was in der Prüfung zählt.

3 · STRUKTUR NUTZEN

Definition → Symptome → Diagnostik/Therapie → Pflege. Diese Reihenfolge gibt dir Sicherheit.

4 · PESR ANWENDEN

Pflegeproblem: P = Problem · E = Einflussfaktoren · S = Symptome. Ressourcen immer mitnennen!

FALLBEISPIELE

01 Herzinsuffizienz · Innere Medizin

02 COPD · Innere Medizin

03 Diabetes mellitus Typ 2 · Innere Medizin

04 Hypertonie · Innere Medizin

05 Postoperative Pflege · Chirurgie & Orthopädie

06 Hüft-TEP / Knie-TEP · Chirurgie & Orthopädie

07 Appendizitis · Chirurgie & Orthopädie

08 Schlaganfall (Apoplex) · Neurologie

09 Epilepsie · Neurologie

10 Onkologische Pflegegrundlagen · Onkologie

11 Palliativpflege · Onkologie

12 Harnwegsinfekt (HWI) · Urologie

13 Benignes Prostataadenom (BPH) · Urologie

14 Mammakarzinom · Gynäkologie

15 Präeklampsie / Eklampsie · Gynäkologie

16 Tracheotomie-Pflege · HNO

17 Otitis media (Mittelohrentzündung) · HNO

18 Kommunikationsmodelle · Psychologie für Pflege

19 Stressbewältigung & Burnout · Psychologie für Pflege

20 Motivationstheorien · Psychologie für Pflege

INNERE MEDIZIN

1 Herzinsuffizienz ICD I50

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Herzinsuffizienz. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Unfähigkeit des Herzens, ausreichend Blut/Sauerstoff zu pumpen. Einteilung: Links-, Rechts- oder Globalinsuffizienz. NYHA-Stadien I–IV.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Dyspnoe (Belastung → Ruhe)
- Orthopnoe (flach liegen nicht möglich)
- Ödeme (Knöchel, Unterschenkel)
- Nykturie
- Müdigkeit, Leistungsminderung
- Zyanose
- Gewichtszunahme durch Wassereinlagerung
- Tachykardie

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Echo (EF < 40% = systolische HI)
- BNP/NT-proBNP erhöht
- Röntgen Thorax (Kardiomegalie, Lungenödem)
- EKG
- Labor: Kreatinin, Elektrolyte

THERAPIE

- ACE-Hemmer/Sartane
- Betablocker
- Diuretika (Furosemid)
- Aldosteronantagonisten
- Digoxin
- ICD/Resynchronisation

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Beeinträchtigte kardiopulmonale Gewebepерfusion · E: verminderter Herzleistung · S: Dyspnoe, Zyanose, SpO ₂ < 94%
RESSOURCEN	Kooperativ, Versteht Anweisungen, Angehörige unterstützend
PFLEGEZIEL	Patient atmet in Ruhe ohne Dyspnoe (NRS Atemnot 0-2) innerhalb von 48h
MASSNAHMEN	• Oberkörperhochlagerung 30-45° kontinuierlich • O₂-Gabe nach Anordnung, SpO₂ ≥ 94% sichern • Vitalzeichen 4stündlich: RR, HF, AF, SpO₂ • Flüssigkeitsbilanz (Ein-/Ausfuhr täglich) • Tägliche Gewichtskontrolle (gleiche Zeit, Waage) • Ödeme dokumentieren (Umfang messen) • Aktivität schrittweise steigern nach Befinden
EVALUATION	Täglich: Dyspnoe-NRS, SpO ₂ , Gewicht, Ödeme

PFLEGEPROBLEM	P: Überschuss an Körperflüssigkeit · E: Herzpumpversagen · S: Ödeme, Gewichtszunahme 3kg/Woche
RESSOURCEN	Versteht Bedeutung der Trinkmengenbeschränkung
PFLEGEZIEL	Gewichtsreduktion um 0,5-1kg/Tag durch Diurese, Ödeme rückläufig nach 3 Tagen
MASSNAHMEN	• Trinkmengenbeschränkung nach Anordnung (meist 1,5-2L/Tag) • Diuretika pünktlich verabreichen, Wirkung dokumentieren • Natriumarme Ernährung besprechen • Hautpflege ödematöser Extremitäten (Druckgefahr!) • Hochlagerung der Beine • Patient über Selbstkontrolle schulen (Tagesgewicht)
EVALUATION	Täglich Gewicht, Bilanz, Ödemstatus

INNERE MEDIZIN
2 COPD ICD J44

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit COPD. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Nicht vollständig reversible Atemwegsobstruktion durch chronische Bronchitis + Lungenemphysem. Hauptursache: Rauchen. GOLD-Stadien I–IV.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Chronischer Husten (Raucherhusten)
- Auswurf (morgens besonders)
- Belastungsdyspnoe (progredient)
- Giemen/Brummen
- Fassthorax (Emphysem)
- Lippenzyanose
- Uhrglasnägel
- Trommelschlägelfinger

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Spirometrie (FEV1/FVC < 0,7)
- Blutgasanalyse (BGA)
- Röntgen/CT Thorax
- 6-Minuten-Gehtest
- COPD-Assessment-Test (CAT)

THERAPIE

- Raucherentwöhnung (!)
- Bronchodilatoren (LABA, LAMA)
- Inhalatoren-Schulung
- Kortikosteroide inhalativ
- Atemphysiotherapie
- Langzeit-O₂ bei PaO₂ < 55mmHg

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Ineffektives Atemmuster · E: bronchialer Obstruktion · S: Dyspnoe NRS 6, AF 26/min, SpO ₂ 88%
RESSOURCEN	Kann Lippenbremse anwenden, Motiviert zur Mitarbeit
PFLEGEZIEL	SpO ₂ stabil bei 88–92 % (COPD-Zielbereich), Dyspnoe NRS ≤ 3 nach 24 h
MASSNAHMEN	• O₂-Gabe VORSICHTIG: Ziel SpO₂ 88–92% (nicht höher! Atemantriebreduktion!) • Kutschersitz anleiten (sitzend, Arme aufgestützt → Atemhilfsmuskulatur) • Lippenbremse üben und anwenden • Bronchodilatator-Inhalation nach Anordnung, Technik kontrollieren • Sekretmobilisation: atemunterstützende Lagerung, PEP-Geräte • Atemgymnastik 3x täglich • Körperliche Schonung, Aktivität nach Befinden
EVALUATION	4-stündlich SpO ₂ , AF, Dyspnoe-NRS

INNERE MEDIZIN

3 Diabetes mellitus Typ 2 ICD E11

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Chronische Stoffwechselerkrankung mit Insulinresistenz und relativem Insulinmangel. Häufigste Diabetesform (90%). Risikofaktoren: Adipositas, Bewegungsmangel, genetische Disposition.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Polyurie, Polydipsie (bei Entgleisung)
- Müdigkeit, Leistungsminderung
- Wundheilungsstörungen
- Häufige Infektionen
- Sehstörungen (Retinopathie)
- Kribbeln/Taubheit Füße (Neuropathie)
- Oft lange symptomlos!

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Nüchtern-BZ ≥ 126 mg/dl
- HbA1c $\geq 6,5\%$
- OGTT
- Urin: Mikroalbuminurie
- Augenhintergrund, Fußstatus

THERAPIE

- Basistherapie: Ernährung + Bewegung
- Metformin (First-Line)
- SGLT2-Inhibitoren, GLP-1-RA
- Insulin (bei Versagen oraler Antidiabetika)
- HbA1c-Ziel individuell (meist $< 7\%$)

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko für Hypoglykämie · E: Insulintherapie und unregelmäßiger Nahrungsaufnahme
RESSOURCEN	Erkennt Hypoglykämie-Zeichen, Kann BZ selbst messen
PFLEGEZIEL	Keine Hypoglykämie-Episode (BZ > 70 mg/dl) während des stationären Aufenthalts
MASSNAHMEN	• BZ-Kontrolle nach Anordnung (nüchtern, vor/nach Mahlzeiten) • Mahlzeiten pünktlich, Insulin zeitgerecht verabreichen (6-R-Regel!) • Hypoglykämie-Schema beachten: BZ $< 70 \rightarrow 20$g KH oral (Traubenzucker) • BZ < 50 oder bewusstlos $\rightarrow$ Glukose 40% i.v. nach Anordnung • Notfallset: Glukose immer griffbereit • Schulung: Symptome Hypoglykämie (Zittern, Schwitzen, Herzrasen, Verwirrtheit)
EVALUATION	BZ-Profil täglich, Hypoglykämie-Ereignisse dokumentieren

PFLEGEPROBLEM	P: Beeinträchtigte Gewebeintegrität · E: Wundheilungsstörung bei diabetischer Polyneuropathie · S: Ulcus plantare rechts
RESSOURCEN	Kooperativ, Familie unterstützt Verbandswechsel
PFLEGEZIEL	Wunde zeigt nach 7 Tagen Granulationsgewebe, keine Infektzeichen
MASSNAHMEN	• Tägliche Wundinspektion und Dokumentation (Foto, Maße, Exsudat, Geruch) • Verbandswechsel nach Wundexpertenstandard (feuchte Wundversorgung) • Druckentlastung: kein Druck auf Ulcus (Spezialschuhe, Bettung) • BZ-Einstellung optimieren (schlechte BZ → schlechte Wundheilung) • Fußpflege täglich: Inspektion alle Zehenzwischenräume • Fußwärme nicht mit Wärmflasche/Heizkissen! (Neuropathie = kein Temperaturempfinden)
EVALUATION	Täglich: Wunddokumentation, BZ-Verlauf

INNERE MEDIZIN
4 Hypertonie ICD I10

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Hypertonie. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Chronisch erhöhter Blutdruck $\geq 140/90$ mmHg. Häufigste Herz-Kreislauf-Erkrankung. Meist primär (essentiell, 90%). Stiller Killer – oft jahrelang symptomlos.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Oft symptomlos!
- Kopfschmerzen (okzipital, morgens)
- Schwindel
- Ohrensausen
- Sehstörungen
- Hypertensive Krise: RR $> 180/120$ + Symptome

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Blutdruckmessung (mehrfach, beide Arme)
- 24h-Langzeit-RR
- EKG (LVH)
- Echo
- Labor: Kreatinin, Elektrolyte, Urin

THERAPIE

- Lebensstiländerung: Gewicht, Salz, Alkohol, Bewegung
- ACE-Hemmer/Sartane
- Kalziumantagonisten
- Betablocker
- Diuretika
- Ziel: $< 130/80$ mmHg

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Unzureichendes Selbstmanagement · E: Wissensmangel über Hypertonie · S: RR 175/105 trotz Medikation, unregelmäßige Einnahme
RESSOURCEN	Lernbereit, Möchte RR senken, Ehefrau unterstützt
PFLEGEZIEL	Patient nennt nach 3 Tagen 5 Maßnahmen zur RR-Senkung und nimmt Medikamente regelmäßig
MASSNAHMEN	• RR-Messung 2x täglich (morgens/abends, protokollieren) • Patientenedukation: Ursachen, Folgen, Therapieziel • Medikamenteneinnahme erklären: warum täglich, nicht absetzen! • Ernährungsberatung: Salzarm $< 6g/Tag$, Alkohol reduzieren • Gewichtskontrolle täglich • Bewegung: 30 Min./Tag moderate Aktivität • Stressreduktion besprechen
EVALUATION	Täglich RR-Protokoll, nach 3 Tagen Wissenstest Chirurgie & Orthopädie

CHIRURGIE & ORTHOPÄDIE
5 Postoperative Pflege ICD Z48

Prüfer: „Erklären Sie kurz: Postoperative Pflege.“

Pflegerische Versorgung nach operativen Eingriffen. Ziel: Komplikationen verhindern, Erholung fördern, Selbstständigkeit wiederherstellen. ABCDE-Schema im AWR.

Prüfer: „Worauf achten Sie, welche Probleme können auftreten?“

- Schmerzen (NRS beachten!)
- Übelkeit/Erbrechen (PONV)
- Hypothermie
- Nachblutung
- Wundinfektion (ab Tag 3-5)
- Thrombose (ab Tag 1)
- Pneumonie (ab Tag 2-3)

Prüfer: „Welche Maßnahmen und Instrumente kennen Sie?“
INSTRUMENTE

- Vitalzeichen-Monitoring
- Wundinspektion
- Drainageoutput
- Labor (BB, CRP, Gerinnung)
- Schmerzassessment NRS

MASSNAHMEN

- Schmerztherapie nach WHO-Schema
- Frühmobilisation!
- Thromboseprophylaxe
- Wundversorgung
- Ernährungsmanagement

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Akuter Schmerz · E: operativem Gewebetrauma · S: NRS 7/10, Patient schont sich, vermeidet Bewegung
RESSOURCEN	Kooperativ, Kann NRS-Skala anwenden, Versteht Bedeutung von Mobilisation trotz Schmerz
PFLEGEZIEL	Schmerzreduktion auf NRS ≤ 3 in Ruhe und NRS ≤ 5 bei Bewegung innerhalb von 2h nach Schmerzmedikation
MASSNAHMEN	• Schmerzerfassung NRS alle 4h + bei Bedarf • Analgetika nach Anordnung pünktlich (nicht erst bei NRS 8!) • Wirkung nach 30-60 Min. kontrollieren, dokumentieren • Lagerung: schmerzarme Position, Kissen zur Abstützung • Nicht-pharmakologisch: Kühlung, Ablenkung, Entspannung • Patienten zur Beurteilung von Schmerz vor Mobilisation einbeziehen • Arzt informieren bei NRS > 6 trotz Analgetikum
EVALUATION	NRS 30-60 Min. nach Medikation, täglich Schmerztagebuch

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko einer Wundinfektion · E: operativem Eingriff und Immunsuppression
RESSOURCEN	Versteht Hygienemaßnahmen, Kooperiert bei Verbandswechsel
PFLEGEZIEL	Keine Infektzeichen (Rötung, Schwellung, Eiter, Fieber > 38°C) bis zur Entlassung
MASSNAHMEN	• Verbandswechsel nach Standard, aseptisch • Wunddokumentation: Größe, Rand, Exsudat, Geruch, Temperatur • Vitalzeichen 2x täglich: Temperatur als Infektmarker • Labor: CRP, Leukozyten beachten • Drainagen: Menge, Farbe, Konsistenz täglich • Händehygiene bei jedem Wundkontakt • Patient: Wundzeichen erkennen, Selbstbeobachtung
EVALUATION	Täglich Wundinspektion, Temperatur, Labor

CHIRURGIE & ORTHOPÄDIE
6 Hüft-TEP / Knie-TEP ICD Z96.6

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Hüft-TEP / Knie-TEP. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Totalendoprothese der Hüfte (Hüft-TEP) oder des Knies (Knie-TEP). Häufigste elektive Orthopädie-Operation. Ziel: Schmerzfreiheit und Beweglichkeit wiederherstellen.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Postoperativ: Schmerzen, Schwellung
- Bewegungseinschränkung
- Luxationsgefahr (Hüft-TEP!)
- Thrombosegefahr

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Röntgen postoperativ
- Laborkontrollen
- Doppler bei TVT-Verdacht

THERAPIE

- Frühfunktionelle Behandlung
- Physiotherapie ab Tag 1
- Analgesie (PDA, Regionalanästhesie)
- Thromboseprophylaxe (NMH + Strümpfe)

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko der Hüft-TEP-Luxation · E: postoperativer Instabilität · S: Erstmobilisation Tag 1
RESSOURCEN	Versteht Luxationsprophylaxe, Kooperativ
PFLEGEZIEL	Keine Luxation während des stationären Aufenthalts, Patient kennt Verbotsspositionen nach Entlassung
MASSNAHMEN	• Verbotsspositionen einhalten: kein Beugen > 90°, kein Überkreuzen der Beine, kein Drehen des Fußes nach innen • Lagerungskeil zwischen die Beine (Abduktionskeil) • Transfer immer auf operierte Seite, Anleitung bei jedem Transfer • Toilettenerhöhung, erhöhte Sitzmöbel (Beugewinkel < 90°) • Patient und Angehörige in Verbotsspositionen schulen • Physio: Gangschulung mit Gehstützen
EVALUATION	Täglich Transfer kontrollieren, Patientenwissen überprüfen

CHIRURGIE & ORTHOPÄDIE
7 Appendizitis ICD K35

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Appendizitis. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Entzündung des Wurmfortsatzes (Appendix vermiformis). Häufigste chirurgische Notfallkrankung. Therapie: Appendektomie (laparoskopisch oder offen). Komplikation: Perforation!

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Schmerz: periumbilikal → rechter Unterbauch
- Übelkeit, Erbrechen
- McBurney-Punkt druckschmerzhaft
- Fieber 37,5-38,5°C
- Loslassschmerz (Blumberg-Zeichen)
- Abwehrspannung bei Perforation

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Klinische Untersuchung (Alvarado-Score)
- Labor: Leukozyten, CRP
- Sonographie
- CT bei Unklarheit

THERAPIE

- Appendektomie laparoskopisch (Standard)
- Antibiose perioperativ
- Bei Perforation: Drainage, Lavage

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Akuter Schmerz · E: entzündlichem Prozess/OP · S: NRS 8, Schonhaltung
RESSOURCEN	Jung, sonst gesund, Kooperativ
PFLEGEZIEL	NRS ≤ 3 in Ruhe nach 2h, NRS ≤ 5 bei Bewegung
MASSNAHMEN	• Analgetika nach Anordnung (kein Wärmepflaster auf Bauch!) • Schonlagerung: Knie leicht angewinkelt (Bauchdecke entspannt) • NRS alle 4h erheben • Kühlung auf Wunde wenn hilfreich • Bei Übelkeit: Antiemetikum nach Anordnung, Lagerung • Frühmobilisation nach OP trotz Schmerz anstreben
EVALUATION	NRS 30-60 Min. nach Analgetikum Neurologie

NEUROLOGIE

8 Schlaganfall (Apoplex) ICD I63 / I61

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Schlaganfall (Apoplex). Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Plötzliche fokale Hirnschädigung durch Ischämie (85%, I63) oder Blutung (15%, I61). Time is Brain: jede Minute = 1,9 Mio. Neuronenverluste. Thrombolyse-Fenster: 4,5h (ischämisch).

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Plötzliche einseitige Lähmung (Hemiparese/-plegie)
- Gesichtslähmung (faziale Parese)
- Sprach-/Sprechstörung (Aphasie/Dysarthrie)
- Schluckstörung (Dysphagie)
- Sehstörungen (Hemianopsie)
- Schwindel, Gangstörung
- Starke Kopfschmerzen (bei Blutung)
- Bewusstlosigkeit

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- FAST-Test (Prehospital)
- CT Schädel sofort (Blutung ausschließen!)
- MRT Schädel (diffusionsgewichtet)
- CT-/MR-Angiographie
- EKG (Vorhofflimmern?)
- Labor: Gerinnung, BZ

THERAPIE

- Stroke Unit!
- Ischämisch: Lyse rtPA i.v. (bis 4,5h) oder Thrombektomie (bis 24h)
- Blutung: neurochirurgisch ggf.
- Sekundärprophylaxe: ASS, Antikoagulation
- Frührehabilitation: Physio, Ergo, Logo ab Tag 1
- Dysphagie-Screening vor erstem Schluck!

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko Aspiration · E: Schluckstörung (Dysphagie) nach Schlaganfall · S: positives Dysphagie-Screening
RESSOURCEN	Patient kooperiert trotz Aphasie, Logopädie verfügbar
PFLEGEZIEL	Patient aspiriert nicht – sichere Nahrungsaufnahme durch angepasste Konsistenz nach logopädischer Freigabe
MASSNAHMEN	• Vor ERSTEM Schluck: standardisiertes Dysphagie-Screening (z.B. 3-Unzen-Wassertest) • Bis Screening-Ergebnis: NICHTS per oral, Mund feucht halten • Nach Logo-Freigabe: angepasste Kost (Andickungsmittel, weiche Kost) • Beim Essen: aufrechte Position 90°, betroffene Seite unterstützen • Essen nie überstürzen, genug Zeit lassen • Absauggerät bereithalten • Nach Essen 30 Min. aufrecht bleiben • Angehörige in sicheres Füttern schulen
EVALUATION	Täglich Schluckfähigkeit beobachten, Aspirationszeichen (Husten, Stimmveränderung)

PFLEGEPROBLEM	P: Beeinträchtigte körperliche Mobilität · E: Hemiparese links · S: Patient kann linken Arm/Bein nicht heben
RESSOURCEN	Hohe Motivation, Vorhandenes Pflegebett mit Hilfsmitteln
PFLEGEZIEL	Patient dreht sich mit geringer Hilfe auf betroffene Seite nach 3 Tagen Frührehabilitation
MASSNAHMEN	• Bobath-Lagerung: betroffene Seite einbeziehen, nicht kompensieren • Stundenlageplan: alle 2h Umlagerung • Patient von betroffener Seite ansprechen (Förderung Aufmerksamkeit zur Seite) • Frührehabilitation: Physiotherapie ab Tag 1 nach Anordnung • Transfertraining (Bett → Stuhl) mit PT • Hilfsmittel: Rollator, Handschiene nach Ergotherapie • Antispastik-Lagerung beachten (Armschiene)
EVALUATION	Täglich Motorik, Tonus, Lagerungstoleranz

NEUROLOGIE
9 Epilepsie ICD G40

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Epilepsie. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Chronische Erkrankung mit rezidivierenden epileptischen Anfällen durch unkontrollierte synchrone Entladungen von Neuronenverbänden. Prävalenz: 0,5-1%. Fokal oder generalisiert. Status epilepticus: Anfall > 5 Min. = Notfall.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Tonisch-klonischer Anfall (grand mal)
- Absence (kurze Bewusstseinsunterbrechung)
- Aura (subjektive Vorboten)
- Myoklonien
- Postiktale Phase: Verwirrtheit, Erschöpfung
- Status epilepticus: Anfall > 5 Min.

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- EEG (interiktal/iktal)
- MRT Schädel
- Labor: BZ, Elektrolyte, Antiepileptika-Spiegel
- Provokationsfaktoren erfragen

THERAPIE

- Antiepileptika: Valproat, Lamotrigin, Levetiracetam, Carbamazepin
- Status epilepticus: Lorazepam i.v. → Phenytoin → Narkose
- Anfallsauslöser vermeiden (Schlafentzug, Alkohol, Flackerlicht)
- Führerschein: 12 Monate anfallsfrei

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko sturzbedingte Verletzung · E: unkontrollierten Krampfanfällen · S: Epilepsie, letzter Anfall vor 3 Tagen
RESSOURCEN	Versteht Sicherheitsmaßnahmen, Kooperativ
PFLEGEZIEL	Patient verletzt sich bei möglichem Anfall nicht durch konsequente Sturzprophylaxe
MASSNAHMEN	• Bettgitter tagsüber nur nach Risiko-Assessment – nicht pauschal! • Scharfe Gegenstände aus Griffweite entfernen • Bett auf niedrigste Position • Bei Anfall: NIEMALS festhalten, Atemweg freihalten, Zeit stoppen • Kein Beißkeil! (Verletzungsgefahr, Aspiration) • Patienten NICHT alleine lassen während Anfall • Nach Anfall: stabile Seitenlage, Sauerstoff, Vitalzeichen • Anfall dokumentieren: Beginn, Dauer, Verlauf, postiktale Phase
EVALUATION	Bei jedem Anfall: Dauer, Art, Verlauf dokumentieren Onkologie

ONKOLOGIE
10 Onkologische Pflegegrundlagen ICD C00-C97

Prüfer: „Erklären Sie kurz: Onkologische Pflegegrundlagen.“

Onkologische Pflege umfasst alle pflegerischen Maßnahmen bei Krebserkrankungen: Prävention, Therapiebegleitung (OP, Chemo, Bestrahlung, Immuntherapie), Symptommanagement und Palliativpflege. Besondere Anforderungen an Kommunikation und Psychoonkologie.

Prüfer: „Worauf achten Sie, welche Probleme können auftreten?“

- B-Symptome: Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust
- Fatigue (tumorbedingte Erschöpfung)
- Schmerzen (akut/chronisch)
- Nausea/Emesis (CINV)
- Mukositis (Schleimhautentzündung)
- Neutropenie (Infektionsgefahr)
- Thrombozytopenie (Blutungsrisiko)
- Alopecie (Haarausfall)

Prüfer: „Welche Maßnahmen und Instrumente kennen Sie?“
INSTRUMENTE

- Staging: TNM-Klassifikation
- PET-CT, CT, MRT
- Tumormarker
- Biopsie
- Labor: Blutbild, Leber/Niere vor Chemo

MASSNAHMEN

- Chirurgie
- Chemotherapie (Zytostatika)
- Strahlentherapie
- Immuntherapie (Checkpoint-Inhibitoren)
- Targeted Therapy (Tyrosinkinasehemmer)
- Palliativtherapie

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Übelkeit und Erbrechen · E: Chemotherapie (CINV) · S: Patient erbricht 5x täglich, Nahrungsablehnung
RESSOURCEN	Antiemetika vorhanden, Familie unterstützend, Motivation trotz Erschöpfung
PFLEGEZIEL	CINV auf max. 2 Erbrechen/Tag reduziert, ausreichende Flüssigkeitszufuhr gesichert nach 48h
MASSNAHMEN	• Antiemetika nach Schema: prophylaktisch VOR Chemo-Gabe! • 5-HT3-Antagonisten (Ondansetron) + Dexamethason + NK1-Antagonisten (Aprepitant) je nach Emetogenität • Kalte/kühle Speisen bevorzugen (weniger Geruch) • Kleine, häufige Mahlzeiten (5-6/Tag statt 3 große) • Stark riechende Speisen vermeiden • Frische Luft, Fenster öffnen • Ingwer-Tee, Pfefferminze • Flüssigkeitsbilanz führen, bei > 1L Defizit: i.v.-Hydratation • Mundpflege nach Erbrechen (Mundspülung)
EVALUATION	Emesis-Tagebuch: Häufigkeit, Schwere (NCI-Skala)

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko Infektion · E: Neutropenie durch Chemotherapie · S: Leukozyten 0,8 G/L, Fieber 38,5°C
RESSOURCEN	Patient kennt Infektionszeichen, Isolierungsmöglichkeit vorhanden
PFLEGEZIEL	Keine lebensbedrohliche Infektion durch konsequente Schutzmaßnahmen; bei febriler Neutropenie: Antibiose innerhalb 1h
MASSNAHMEN	• Febrile Neutropenie = Notfall: Fieber $\geq 38,3^{\circ}\text{C}$ bei Neutrophilen $< 500/\mu\text{l}$ → sofort Arzt! • Blutkultur (2 Paare) VOR Antibiose (nicht verzögern!) • Breitband-Antibiose innerhalb 1h nach Anordnung • Umkehrisolation (protektive Isolation): Besucher mit MNS • Händehygiene: strikt WHO 5 Momente • Keine frischen Blumen/Topfpflanzen im Zimmer (Schimmel!) • Keine Rohkost, kein Rohmilchkäse (Low-Microbial-Diät nach Standard) • Täglich: Mundpflege Chlorhexidin, Körperpflege • GCSF nach Anordnung (Wachstumsfaktor für Neutrophile)
EVALUATION	4-stündlich Temperatur, täglich Leukozyten/Neutrophile

ONKOLOGIE
11 Palliativpflege ICD Z51.5

Prüfer: „Erklären Sie kurz: Palliativpflege.“

Palliativpflege = aktive Gesamtbehandlung von Patienten mit unheilbarer, fortgeschrittener Erkrankung. Ziel: Lebensqualität, nicht Lebenszeit. WHO-Definition: weder Lebensverkürzung noch -verlängerung. Umfasst Schmerztherapie, Symptomkontrolle, psychosoziale/spirituelle Unterstützung.

Prüfer: „Worauf achten Sie, welche Probleme können auftreten?“

- Schmerzen (häufig unzureichend behandelt)
- Mundtrockenheit
- Dyspnoe
- Angst, Depression
- Übelkeit
- Delir (terminal)
- Obstipation (durch Opioide)
- Rasselatmung (Sterbephase)

Prüfer: „Welche Maßnahmen und Instrumente kennen Sie?“
INSTRUMENTE

- ECOG/KPS (Performance Status)
- ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale)
- Schmerzassessment: NRS, BPI
- Spirituelle Bedürfnisse: SPIR-Interview

MASSNAHMEN

- Analgesie WHO-Stufenschema
- Opioide: Morphin, Oxycodon, Fentanyl transdermal
- Symptomkontrolle: Antiemetika, Laxanzien obligat zu Opioiden!
- Psychosoziale Unterstützung
- Seelsorge
- Angehörigenbegleitung

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Chronischer Schmerz · E: Tumorprogress · S: NRS 7 in Ruhe, Patient schläft nicht
RESSOURCEN	Offen für Opioidtherapie, Angehörige unterstützen Pflege
PFLEGEZIEL	Dauerschmerz NRS ≤ 3, Nachtschlaf ≥ 5h nach Opioideinstellung innerhalb 48h
MASSNAHMEN	• Schmerzassessment: NRS, Lokalisation, Qualität, Verstärker/Linderung • Retardiertes Opioid nach Anordnung zur festen Zeit (nicht nach Bedarf!) • Schnellwirkendes Opioid als Reserve bei Durchbruchschmerz bereithalten • Laxans immer gleichzeitig zu Opioid verordnen lassen (keine Obstipation!) • Schmerztagebuch führen (Patient einbeziehen) • Komplementäre Maßnahmen: Lagerung, Wärme/Kälte, TENS, Entspannung • Nichts erzwingen: Patient darf Therapie ablehnen • Angehörige in Schmerzbeobachtung schulen
EVALUATION	NRS 4-stündlich, Schlafqualität täglich, Nebenwirkungen (Obstipation, Übelkeit, Sedierung) Urologie

UROLOGIE

12 Harnwegsinfekt (HWI) ICD N39.0

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Harnwegsinfekt (HWI). Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Häufigste bakterielle Infektion. Unkompliziert: Zystitis (Blase). Kompliziert: Pyelonephritis (Niere), katheterassoziiert (CAUTI). Häufigster Erreger: E. coli (80%). Frauen 10× häufiger betroffen.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Dysurie (Brennen beim Wasserlassen)
- Pollakisurie (häufiger Harndrang)
- Hämaturie
- Übelriechender/trüber Urin
- Unterbauchschmerzen/-druck
- Bei Pyelonephritis: Fieber, Flanken-/Klopfschmerz
- Verwirrtheit (bei alten Menschen oft einziges Zeichen!)

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Urinstreifentest (Nitrit, Leukozyten)
- Urinstatus + Kultur (Mittelstrahlurin!)
- Blutbild, CRP
- Sonographie Nieren bei Pyelonephritis
- Blutkultur bei Sepsisverdacht

THERAPIE

- Unkompliziert: Nitrofurantoin, Fosfomycin, Trimethoprim
- Pyelonephritis: Fluorochinolone, Cephalosporine i.v.
- Katheter-HWI: Antibiose + Katheterwechsel
- Viel trinken (2-3L/Tag)
- Wärme (Wärmflasche Unterbauch)

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko katheterassoziiierter Harnwegsinfektion · E: liegendem DK · S: Immunsuppression
RESSOURCEN	Kooperativer Patient, Pflegepersonal geschult
PFLEGEZIEL	Patient entwickelt keine Katheterinfektion (kein Fieber, kein Urin-Befund) über Liegedauer
MASSNAHMEN	• Tägliche Indikationsprüfung: DK wirklich nötig? → frühzeitig entfernen! • Sterile Anlage, geschlossenes System immer erhalten • Intimhygiene 2x täglich mit Wasser (kein Desinfektionsmittel!) • Beutel immer unter Blasenniveau, niemals auf Boden • Kein Abklemmen des Katheters • Auf Katheterstau/Knick achten • Flüssigkeitszufuhr 1,5-2L/Tag sichern • Täglich: Urin beurteilen (Trübung, Geruch, Farbe)
EVALUATION	Täglich Urinbeschaffenheit, Temperatur, Befinden

UROLOGIE

13 Benignes Prostataadenom (BPH) ICD N40

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Benignes Prostataadenom (BPH). Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Gutartige Vergrößerung der Prostata. Betrifft 50% der Männer >50J, 90% der >80-Jährigen. Führt zu Blasausflussobstruktion mit LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms). Kein Krebsrisiko per se.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Abschwächung des Harnstrahls
- Harnstottern (intermittierender Strahl)
- Restharngefühl
- Nykturie (nächtliches Wasserlassen)
- Pollakisurie
- Harndrang
- Harnverhalt (akut)

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- IPSS-Score (International Prostate Symptom Score)
- PSA-Wert
- Sonographie (Prostatavolumen, Restharn)
- Urodynamik
- Uroflowmetrie
- Rektale Untersuchung

THERAPIE

- Medikamentös: Alpha-1-Blocker (Tamsulosin), 5-Alpha-Reduktasehemmer
- Operative Entfernung: TURP (transurethrale Resektion)
- Laser-Verfahren
- Notfall Harnverhalt: transurethraler Katheter

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Akuter Harnverhalt · E: BPH · S: Restharn 600ml, starker Harndrang, Unterbauchschmerzen
RESSOURCEN	Kooperativer Patient, Schmerzmittel vorhanden
PFLEGEZIEL	Blasenentlastung durch Katheteranlage innerhalb 30 Min., Schmerzfreiheit
MASSNAHMEN	• Transurethralen Katheter nach ärztl. Anordnung anlegen (aseptisch!) • Urin langsam ablassen: nicht mehr als 500ml auf einmal (Hypotension, Hämaturie vermeiden) • Urinmenge, -farbe, -geruch dokumentieren • Schmerzerfassung (NRS) vor und nach Katheteranlage • Wärme auf Unterbauch (prä-/periinterventionell) • Aufklärung über TURP wenn geplant • Sturzprophylaxe: Drang → Stürze bei Eile
EVALUATION	Restharnkontrolle nach Miktion (Sonographie), Schmerz-NRS Gynäkologie

GYNÄKOLOGIE

14 Mammakarzinom ICD C50

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Mammakarzinom. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Häufigste Krebserkrankung der Frau (30% aller Karzinome). Invasives duktales oder lobuläres Karzinom. Risikofaktoren: BRCA1/2, Alter, Hormone, Adipositas. 5-Jahres-Überleben Stad. I: >95%.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Schmerzlose Verhärtung der Brust
- Axilläre Lymphknotenschwellung
- Hautveränderungen (Orangenhaut, Einziehungen)
- Asymmetrie der Brust
- Brustwarzeneinziehung oder -ausfluss
- Hautrötung/Überwärmung (inflammatorisch)

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Mammographie (Screening ab 50)
- Sonographie
- MRT Mamma
- Stanzbiopsie (Histologie)
- Sentinel-Lymphknoten-Biopsie
- Staging: CT, Knochenszintigraphie

THERAPIE

- Operation: BET (brusterhaltend) oder Mastektomie
- Sentinel-LK-Biopsie / Axilladisektion
- Strahlentherapie nach BET
- Chemotherapie (neo-/adjuvant)
- Antihormontherapie (Tamoxifen, Aromatasehemmer)
- Herceptin bei HER2-positiv

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Beeinträchtigt Körperbild · E: Mastektomie/Narbe · S: Patientin betrachtet Wunde nicht, äußert Scham
RESSOURCEN	Vertrauensvolle Beziehung zur Pflegekraft, Unterstützender Partner, Offenheit für Gespräche
PFLEGEZIEL	Patientin betrachtet Wundbereich und benennt 2 positive Aspekte ihres Körpers bis zur Entlassung
MASSNAHMEN	• Einfühlsame Wundpflege: Patientin einbeziehen, nicht drängen • Aktives Zuhören: Gefühle ernst nehmen, nicht bagatellisieren • Informationen über Brustprothesen, Rekonstruktion anbieten • Kontakt zu Selbsthilfegruppe (z.B. Frauenselbsthilfe nach Krebs) • Sexualberatung bei Bedarf ansprechen • Psychoonkologischen Dienst einbeziehen
EVALUATION	Täglich Gesprächsbereitschaft beobachten, Körperbildwahrnehmung erfragen

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko Lymphödem · E: Axilladisektion · S: Einschränkung Lymphabfluss rechter Arm
RESSOURCEN	Versteht Prophylaxemaßnahmen, Kooperativ
PFLEGEZIEL	Patientin benennt Lymphödem-Prophylaxemaßnahmen korrekt vor Entlassung
MASSNAHMEN	• Keine Blutdruck-Messungen, Injektionen, Blutabnahmen am betroffenen Arm • Armlymphödem-Prophylaxe schulen: kein enger Schmuck, keine Hitze • Manuelle Lymphdrainage nach Anordnung • Kompressionshandschuh/ärmel anpassen • Auf Infektionszeichen achten (Rötung, Schwellung, Wärme) • Arm bei Ruhe hochlagern
EVALUATION	Armumfang täglich messen, Ödem dokumentieren

GYNÄKOLOGIE
15 Präeklampsie / Eklampsie ICD O14

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Präeklampsie / Eklampsie. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Hypertensive Schwangerschaftserkrankung ab 20. SSW. Präeklampsie: RR $\geq 140/90$ + Proteinurie. Schwere Form: HELLP-Syndrom. Eklampsie: zerebrale Krampfanfälle. Lebensbedrohlich für Mutter und Kind.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- RR $\geq 140/90$ mmHg nach 20. SSW
- Proteinurie $> 0,3\text{g}/24\text{h}$
- Ödeme (Gesicht, Hände)
- Kopfschmerzen
- Sehstörungen, Flimmern
- Oberbauchschmerzen (HELLP)
- Übelkeit, Erbrechen
- Hyperreflexie

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- RR-Messung (mehrfach)
- Proteinurie (Streifentest, 24h-Urin)
- Labor: Thrombozyten, Transaminasen, LDH, Harnsäure
- CTG, Doppler-Sonographie
- Augenhintergrund

THERAPIE

- Stationäre Überwachung
- Antihypertensiva: Methyldopa, Nifedipin, Labetalol
- Magnesium i.v. (Eklampsie-Prophylaxe!)
- Bei Eklampsie: Diazepam, Sicherung Atemweg
- Entbindung = einzige Heilung
- Frühgeburt einkalkulieren

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko mütterlicher Verletzung · E: möglichem Eklampsie-Anfall · S: RR 160/100, Hyperreflexie
RESSOURCEN	Hospitalisiert, CTG-Monitoring vorhanden, Kooperative Patientin
PFLEGEZIEL	Patientin erleidet keinen Krampfanfall durch konsequente Prophylaxe und Überwachung
MASSNAHMEN	• RR alle 15-30 Min. messen und dokumentieren • Magnesium i.v. nach Anordnung: Laufrate kontrollieren • Patellarsehnenreflex stündlich prüfen (Mg-Toxizität!) • Atemfrequenz überwachen ($> 12/\text{Min.}$!) • Antidot Calciumgluconat griffbereit halten • Reizarme Umgebung: Licht dimmen, Ruhe • Sturzprophylaxe: Bettgitter hochstellen • Krampfbereitschaft: Beißkeil, Sauger, O₂ bereit
EVALUATION	Kontinuierliches Monitoring, sofort Arzt bei RR $> 160/110$ oder Reflexveränderungen HNO

HNO
16 Tracheotomie-Pflege ICD Z93.0

Prüfer: „Erklären Sie kurz: Tracheotomie-Pflege.“

Tracheotomie = operativer Zugang zur Trachea. Temporär (PDT: perkutane Dilatationstracheotomie bei Langzeitbeatmung) oder dauerhaft (Laryngektomie). Sichert Atemweg, erleichtert Weaning. Tracheostomaversorgung ist Kernkompetenz der Intensivpflege und HNO.

Prüfer: „Worauf achten Sie, welche Probleme können auftreten?“

- Atemnot bei Verlegung der Kanüle
- Sekretansammlung
- Hautreizung um Stoma
- Granulationen
- Kanülenobstruktion

Prüfer: „Welche Maßnahmen und Instrumente kennen Sie?“
INSTRUMENTE

- Klinische Beurteilung (Atemgeräusche, Sekret)
- Laryngoskopie bei Komplikationen
- Bronchoskopie bei Verdacht Sekretpfropf

MASSNAHMEN

- Regelmäßige Kanülenpflege
- Absaugung (steril/aseptisch nach Standard)
- Innenkanüle wechseln
- Feuchtigkeitserhalt (HME-Filter, Befeuchtung)
- Stoma-Hautpflege
- Sprechen: Sprechkanüle, Passy-Muir-Ventil

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Ineffektive Atemwegsclearance · E: Tracheotomie und eingeschränktem Hustenmechanismus · S: zähes Sekret, Absaugbedarf
RESSOURCEN	Patient kann bei Absaugung mitarbeiten, Absaugeinheit vorhanden
PFLEGEZIEL	Atemwege bleiben frei, SpO ₂ ≥ 94%, Absaugintervall > 2h ohne Atemnot
MASSNAHMEN	• Absaugung: NUR bei Bedarf (nicht nach Schema!), sterile Technik • Vor Absaugen: präoxygenieren (FiO₂ erhöhen, bei Beatmung) • Einführtiefe: max. 0,5cm über Kanülenspitze – nicht tiefer! • Sog max. 150-200 cmH₂O, max. 15 Sek. pro Absaugvorgang • Innenkanüle alle 8h wechseln/reinigen • HME-Filter 24h-Wechsel (Befeuchtung, Bakterienfilter) • Ausreichend Flüssigkeit sichern (Sekretverflüssigung) • Raumluftbefeuchtung • Stoma täglich reinigen: sterile NaCl-Kompressen
EVALUATION	Atemgeräusche, SpO ₂ , Sekretmenge/-beschaffenheit, Hautbefund

HNO

17 Otitis media (Mittelohrentzündung) ICD H66

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Otitis media (Mittelohrentzündung). Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Häufigste bakterielle Infektion im Kindesalter (70% aller Kinder bis 3J. mindestens einmal). Akut: meist viral/ bakteriell (Pneumokokken, H. influenzae). Chronisch: Gefahr Komplikationen. Wichtig für GPA-PädiatrieEinsatz.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Starke Ohrenscherzen (Otalgie)
- Ohrziehen (Kinder)
- Fieber
- Druckgefühl im Ohr
- Hörverlust (Schallleitungsschwerhörigkeit)
- Eitrige Sekretion bei Perforation (dann Schmerzlinderung!)
- Reizbarkeit (Säuglinge)

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Otoskopie: gerötet, vorgewölbt, Lichtreflex fehlt
- Tympanometrie
- Audiometrie bei chronischer Form
- Abstrich bei Sekretion

THERAPIE

- Schmerztherapie: Ibuprofen, Paracetamol
- Abschwellende Nasentropfen
- Abwartend bei unkomplizierter akuter Otitis (7 Tage)
- Antibiotika: Amoxicillin bei Komplikationen/ Risikogruppen
- Parazentese (Einschnitt Trommelfell) bei starken Schmerzen
- Paukenröhrchen bei rezidivierender Otitis

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Akuter Schmerz · E: Mittelohrentzündung · S: Kind weint, NRS-Kinderskala 7, Ohrziehen
RESSOURCEN	Eltern kooperativ, Kind ablenkbar
PFLEGEZIEL	Schmerz auf NRS-Kinderskala ≤ 3 innerhalb von 1h nach Analgesie
MASSNAHMEN	• Analgetikum nach Anordnung: Ibuprofen (bevorzugt, auch antiinflammatorisch) oder Paracetamol gewichtsadaptiert • Wärme auf Ohr (Kirschkernsäckchen, wenn kein Abszess!) • Abschwellende Nasentropfen nach Anordnung • Ablenkung: Spielzeug, Eltern einbeziehen • Keine Wattepfropfen ins Ohr! • Lagerung: betroffene Seite oben → erleichtert Drainage • Fiebersenkung nach Anordnung
EVALUATION	NRS-Kinderskala 30 Min. nach Analgesie Psychologie für Pflege

PSYCHOLOGIE FÜR PFLEGE

18 Kommunikationsmodelle

Prüfer: „Erklären Sie kurz: Kommunikationsmodelle.“

Theoretische Modelle zur Erklärung von Kommunikationsprozessen. In der Pflege grundlegend für therapeutische Kommunikation, Patientenedukation und Teamarbeit.

Prüfer: „Worauf achten Sie, welche Probleme können auftreten?“

- Kommunikationsprobleme
- Konflikte im Team
- Missverständnisse
- Non-Compliance des Patienten

Prüfer: „Welche Maßnahmen und Instrumente kennen Sie?“

INSTRUMENTE

- Gesprächsanalyse
- Selbstreflexion
- Supervision

MASSNAHMEN

- Aktives Zuhören
- Gewaltfreie Kommunikation (GFK)
- Ich-Botschaften
- Feedback-Kultur

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Beeinträchtigte verbale Kommunikation · E: sprachlicher Barriere/Aphasie · S: Patient kann Bedürfnisse nicht äußern
RESSOURCEN	Gestik vorhanden, Familie als Dolmetscher, Bildkarten verfügbar
PFLEGEZIEL	Patient kommuniziert 3 Grundbedürfnisse (Schmerz, Hunger, Toilette) mit Hilfsmitteln nach 48h
MASSNAHMEN	• Kommunikationsboard einsetzen (Bilder/Symbole) • Ja/Nein-Fragen stellen • Einfache kurze Sätze, langsam sprechen • Geduld: Patient nicht unterbrechen • Logopädie einbeziehen • Nonverbale Kommunikation bewusst einsetzen (Mimik, Gestik) • Angehörige als Kommunikationshelfer schulen
EVALUATION	Täglich Kommunikationserfolge dokumentieren

PSYCHOLOGIE FÜR PFLEGE
19 Stressbewältigung & Burnout ICD Z73

Prüfer: „Erklären Sie kurz: Stressbewältigung & Burnout.“

Pflegeberufe haben hohes Burnout-Risiko. Burnout = emotionale Erschöpfung + Depersonalisation + reduzierte Leistungsfähigkeit. Prävention ist Kernaufgabe des Selbstmanagements.

Prüfer: „Worauf achten Sie, welche Probleme können auftreten?“

- Emotionale Erschöpfung
- Zynismus, Distanzierung
- Leistungsabfall
- Schlafstörungen
- Psychosomatische Beschwerden
- Innere Kündigung

Prüfer: „Welche Maßnahmen und Instrumente kennen Sie?“
INSTRUMENTE

- Maslach Burnout Inventory (MBI)
- Selbstreflexion
- Supervision
- Betriebsärztliche Beratung

MASSNAHMEN

- Ressourcenaktivierung
- Work-Life-Balance
- Supervision
- Psychotherapie
- Stressmanagement-Techniken

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko Burnout · E: chronischer Arbeitsbelastung und unzureichender Erholung · S: MBI-Score erhöht
RESSOURCEN	Hohe Berufsmotivation, Kollegiales Team, Sport als Ausgleich
PFLEGEZIEL	Mitarbeiter benennt 3 persönliche Stressbewältigungsstrategien und nutzt sie regelmäßig
MASSNAHMEN	• Supervision regelmäßig anbieten • Dienstplanung: ausreichend Erholungszeiten • Ressourcen stärken: was gibt Energie? • Grenzen setzen: Nein sagen lernen • Progressive Muskelrelaxation (PMR) anleiten • Kollegiale Fallberatung etablieren
EVALUATION	Nach 4 Wochen: MBI-Score, subjektives Wohlbefinden

PSYCHOLOGIE FÜR PFLEGE

20 Motivationstheorien

Prüfer: „Erklären Sie kurz: Motivationstheorien.“

Theorien zur Erklärung menschlichen Verhaltens und Antriebe. In der Pflege relevant für Patientenedukation, Compliance-Förderung und Teamführung.

Prüfer: „Worauf achten Sie, welche Probleme können auftreten?“

- Mangelnde Compliance
- Non-Adhärenz
- Motivationsprobleme im Team

Prüfer: „Welche Maßnahmen und Instrumente kennen Sie?“

INSTRUMENTE

- Motivationsanalyse
- Gespräch
- Zielvereinbarung

MASSNAHMEN

- Motivierende Gesprächsführung
- Ressourcenorientierung
- Zielvereinbarung

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Unwirksames Gesundheitsverhalten · E: geringe Motivation, fehlendes Krankheitsverständnis · S: unregelmäßige Medikamenteneinnahme, Termine werden nicht wahrgenommen
RESSOURCEN	Gesprächsbereit, Wunsch nach mehr Selbstständigkeit, Partnerin unterstützt
PFLEGEZIEL	Patient nennt bis zur Entlassung zwei persönliche Gründe für die Therapie und nimmt seine Medikamente an 7 von 7 Tagen selbstständig ein
MASSNAHMEN	• Motivierende Gesprächsführung (offene Fragen, aktives Zuhören, Zusammenfassen) • Ziele gemeinsam vereinbaren, kleine Schritte • Fortschritte positiv verstärken • Wochendosett und Einnahmeplan einführen • Angehörige einbeziehen
EVALUATION	Täglich Einnahme kontrollieren, Gespräch zur Motivation alle 2 Tage



Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de

KITTELTASCHEN-WISSEN · ZUM AUSSCHNEIDEN



Taschenkarten-Set

40 Karten mit dem wichtigsten Praxis- und Prüfungswissen – ausdrucken, entlang der gestrichelten Linie ausschneiden, laminieren und in die Kitteltasche stecken.

Bestehen ist planbar.

Hygiene

Prophylaxen

Notfall

Scores

Intensiv

Recht

40

Karten

2

pro Zeile

A4

druckfertig

⚠ Lernhilfe für Ausbildung und Praxis. Es gelten die Standards deiner Einrichtung und die ärztliche Anordnung.

Inhalt

Tipp: Auf festeres Papier (160 g/m²) drucken und laminieren – dann halten die Karten die ganze Ausbildung.

01 Hygienische Händedesinfektion

02 Handschuhe – Wann ja/nein?

03 Dekubitusprophylaxe

04 Sturzprophylaxe

05 Thromboseprophylaxe

06 Pneumonieprophylaxe

07 Wundversorgung Kurzref.

08 Notfallmedikamente

09 BLS – Basic Life Support

10 ATL-Pflegeplanung Kurzref.

11 Isolationsmaßnahmen

12 Vitalzeichen Normalwerte

13 Kinästhetik Grundprinzipien

14 Innere Medizin Kurzref.

15 Schmerzerfassung

16 ABCDE-Schema Notfall

17 Glasgow Coma Scale (GCS)

18 SBAR-Übergabe

19 Sepsis-Erkennung (qSOFA)

20 Anaphylaxie Notfall

21 Hypoglykämie & Hyperglykämie

22 EKG-Grundlagen

23 Blasenkatheter-Pflege

24 Magensonde (NGS)

25 NEWS2-Score

26 Delir-Erkennung (CAM-ICU)

27 Fixierung/FEM – Rechtliches

28 Drainagen-Pflege

29 Bluttransfusion

30 Kinderreanimation (PBLs)

31 WHO-Schmerztherapie

32 Beatmung Grundlagen

33 Flüssigkeitsbilanz

34 Nach einem Sturz

35 Tracheostoma Pflege

36 Schutzausrüstung PSA

37 SAMPLE-Anamnese Notfall

38 Intensiv-Medikamente

39 Manchester Triage (MTS)

40 Pädiatrie Notfälle

01 Hygienische Händedesinfektion

5 WHO-MOMENTE

- 1. Vor Patientenkontakt
- 2. Vor aseptischen Tätigkeiten
- 3. Nach Körperflüssigkeiten
- 4. Nach Patientenkontakt
- 5. Nach Patientenumgebung

TECHNIK

- 3–5 ml · 30 Sekunden (EN 1500)
- 6 Schritte: Flächen · Rücken · Finger · Außen · Daumen · Kuppen
- Nicht abwischen – trocknen lassen!

MERKE!

- C. difficile → Waschen statt Alkohol!
- Handschuhe ersetzen HD NICHT

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

02 Handschuhe – Wann ja/nein?

JA BEI:

- Blut · Körperflüssigkeiten · Schleimhäute
- Wundversorgung · Katheter · Zugänge
- Isolationspatienten · Desinfektionsmittel

NEIN BEI:

- Blutdruck messen · Begrüßung
- Medikamente richten (ohne Kontamin.)
- Dauerhaftem Tragen ohne Grund!

MERKE!

- Nach jedem Wechsel: Hände desinfizieren!
- Handschuhe ≠ Ersatz für Händedesinfektion

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

03 Dekubitusprophylaxe

RISIKO-ASSESSMENT

- Braden-Skala (6–23 Punkte)
- ≤18 = erhöhtes Risiko
- ≤9 = sehr hohes Risiko

MASSNAHMEN

- Umlagerung 2–4h (Risikopatient)
- Druckentlastende Hilfsmittel (W/H-Matratze)
- Hautinspektion bei jeder Pflege
- Mikrolagerung (30°) · KEINE Ringkissen!

STADIEN

- Kat. I: Rötung · II: Blase/Abtragung
- Kat. III: Vollhautverlust · IV: Knochen sichtbar

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

04 Sturzprophylaxe

RISIKOFAKTOREN

- Sturzanamnese · Gangschwäche · Orthostase
- Polypharmazie · Sehstörung · Kognition
- Nykturie · Schmerz · Hilfsmittel

MASSNAHMEN

- Bewegungsmelder · rutschfeste Schuhe
- Nachts: Licht an · Bett niedrig
- Hüftprotektoren · Mobilitätstraining
- Toilettenstuhl bereitstellen

DOKUMENTATION

- Sturzprotokoll nach jedem Sturz
- Maßnahmenplan schriftlich festhalten

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

05 Thromboseprophylaxe

RISIKO-ASSESSMENT

- Caprini-Score (chir.) / Padua (intern.)
- Immobilität · OP · Thrombose-Vorgeschichte
- Adipositas · Malignome · Pille/HRT

MASSNAHMEN

- Frühmobilisation (1. postop. Tag!)
- Thrombosestrümpfe ATS Kl. I/II
- Heparin s.c. nach ärztl. AO
- Ausreichend trinken: ≥1,5–2 l/Tag
- Wadenpumpe aktivieren · Fußgymnastik

TVT-ZEICHEN

- Homans-Zeichen · Wadendruckschmerz
- Schwellung · Überwärmung · Rötung → Arzt!

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

06 Pneumonieprophylaxe

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität · Schluckstörung · Bewusstlosigkeit
- Beatmung (VAP!) · COPD · Rauchen
- Flachlagerung · Sekretretention

MASSNAHMEN

- Oberkörper 30–45° hochlagern
- Atemübungen (10x/h) · Atemtraining
- Sekretmobilisation · Inhalation
- Ausreichend trinken · Mundpflege
- Frühmobilisation · Beatmungsentwöhnung

VAP-BÜNDEL

- Cuff-Druck 20–30 cmH₂O
- Mundhygiene Chlorhexidin
- Tägliche Extubationsprüfung

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

07 Wundversorgung Kurzref.



WUNDBEURTEILUNG

- Größe (L×B×T in cm)
- Wundgrund: Granulation Fibrin Nekrose
- Exsudat: serös · hämorrhagisch · purulent
- Wundrand: scharf · mazeriert · unterminiert

NERDS (LOKAL)

- Non-healing · Exudate↑ · Red tissue
- Debris · Smell → ≥3: Abstrich!

WUNDAUFLAGEN

- Foam: stark exsudierend
- Hydrokolloid: wenig Exsudat
- Alginat: Hohlräume · stark blutend
- Silber-Auflage: Infektion/NERDS≥3

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

08 Notfallmedikamente



REANIMATION ACLS

- Adrenalin 1mg i.v. alle 3–5 Min.
- Amiodaron 300mg i.v. (1. Dosis)
- Amiodaron 150mg i.v. (2. Dosis)
- Atropin 0,5mg i.v. (Bradykardie)

ANALGESIE/SEDIERUNG

- Morphin 2–5mg i.v. titrieren
- Midazolam 1–2mg i.v. (Anxiolyse)
- Propofol 1–2,5mg/kg i.v. (Einleitung)

MERKE!

- 6R-Regel vor jeder Gabe!
- Richtiges Medikament · Dosis · Patient
- Zeit · Applikation · Dokumentation

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

09 BLS – Basic Life Support



ABLAUF

1. Sicher? Ansprechen + Schulter schütteln
2. Keine Reaktion → Hilfe rufen!
3. Atemwege frei? Kopf überstrecken
4. Atemkontrolle max. 10 Sek.
5. Keine Atmung → 112 + Defi holen!

CPR

- 30 Kompressionen : 2 Beatmungen
- Frequenz: 100–120/Min.
- Tiefe: 5–6 cm · Vollständige Entlastung
- Druckpunkt: Sternummitte · Handballen

DEFIBRILLATION

- So früh wie möglich!
- EIN Schock → sofort CPR weiter
- AED: Anweisungen befolgen

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

10 ATL-Pflegeplanung Kurzref.



10 ATLS (JUCHLI)

1. Kommunizieren · 2. Sich bewegen
3. Vitale Fkt. · 4. Körperpflege
5. Essen & Trinken · 6. Ausscheiden
7. Schlafen · 8. Beschäftigen
9. Sinn finden · 10. Soziale Sicherung

PFLEGEPLAN-SCHEMA

- P: Problem (individuell formulieren)
- Ä: Ätiologie (Ursache)
- S: Symptom
- Z: Pflegeziel (SMART!)
- M: Maßnahmen (konkret, messbar)
- E: Evaluation (Datum festlegen)

MERKE!

- Ressourcen immer dokumentieren!
- Patient einbeziehen → aktivierende Pflege

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

11 Isolationsmaßnahmen



MRSA

- Einzelzimmer · Kittel · Handschuhe · FFP2
- Screening: Nasen-Rachen-Abstrich
- Sanierung: Mupirocin + Ganzkörperwäsche

C. DIFFICILE / NOROVIRUS

- Einzelzimmer · Kittel · Handschuhe
- WASCHEN statt Alkohol (Sporen!)
- Sporozide Flächendesinfektion

TBC

- Einzelzimmer mit Unterdruck!
- FFP3-Maske (kein MNS!)
- Meldepflicht §6 IfSG

PSA REIHENFOLGE

- An: Kittel→Maske→Brille→Handschuhe
- Ab: Handschuhe→Kittel→Brille→Maske→HD

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

12 Vitalzeichen Normalwerte



NORMALWERTE ERWACHSENER

- RR: 120/80 mmHg (optimal)
- Puls: 60–100/Min. (regelmäßig)
- AF: 12–18/Min.
- SpO₂: ≥95% (COPD: ≥88%)
- Temp: 36,5–37,4°C (rektal +0,5°C)
- BZ: 70–100 mg/dl (nüchtern)

KRITISCHE WERTE → ARZT!

- RR syst. <90 oder >180 mmHg
- Puls <40 oder >150/Min.
- SpO₂ <90% trotz O₂
- Temp >40°C oder <35°C

SCHMERZ-NRS

- 0=kein · 1–3=leicht · 4–6=mittel
- 7–10=stark → Analgesie dokumentieren

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

13 Kinästhetik Grundprinzipien



6 KONZEPTE

- 1. Interaktion · 2. Funktionale Anatomie
- 3. Menschliche Bewegung
- 4. Anstrengung · 5. Menschliche Funktion
- 6. Umgebung

TRANSFERS – GRUNDREGELN

- Eigenbewegung des Pat. nutzen!
- Körper nah am Pat. halten
- Aus eigener Körpermitte bewegen
- Kein Heben – Schieben und Gleiten
- Bett in Arbeitshöhe (Nabelhöhe)

SELBSTSCHUTZ

- Rücken gerade halten · Knie beugen
- Gewicht auf Vorderfuß verlagern
- Hilfsmittel nutzen (Gleitmatte, Lifter)

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

14 Innere Medizin Kurzref.



HERZINSUFFIZIENZ NYHA

- I: Keine Beschwerden bei Belastung
- II: Leichte Beschwerden (Treppensteigen)
- III: Beschwerden bei leichter Belastung
- IV: Beschwerden in Ruhe

ACS – LEITSYMPTOME

- Vernichtungsschmerz · Ausstrahlung (Arm/Kiefer)
- Kaltschweißigkeit · Übelkeit
- Atemnot · SOFORT EKG + Arzt!

DIABETES NOTFÄLLE

- Hypo (<70 mg/dl): Traubenzucker · bewusstlos → Glukagon
- Hyper (>300+Keton): Insulin + Flüssigkeit → Arzt!

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

15 Schmerzerfassung



SKALEN

- NRS 0–10 (Numeric Rating Scale)
- VAS: Visuelle Analogskala
- BESD: Demenzkranke (Beobachtung)
- KUSS: Kinder (0–5 Punkte)
- BPS: Beatmete/Sedierter (3–12 Punkte)

OPQRST-ANALYSE

- O: Onset (wann begonnen?)
- P: Provocation (was verstärkt/lindert?)
- Q: Quality (wie? stechend/drückend?)
- R: Radiation (Ausstrahlung?)
- S: Severity (Stärke 0–10)
- T: Time (wie lange?)

MERKE!

- Schmerz ist immer subjektiv!
- Vor VW: Analgesie prüfen (30 Min. vorher)

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

16 ABCDE-Schema Notfall



A – AIRWAY (ATEMWEG)

- Atemweg frei? → Kopf überstrecken / Jaw-thrust
- Fremdkörper? → entfernen
- Obstruktion? → Guedel-/Wendl-Tubus

B – BREATHING (ATMUNG)

- SpO₂, Atemfrequenz, Atemtiefe
- O₂-Gabe: Ziel SpO₂ ≥94% (COPD: 88-92%)
- Beutel-Maske-Beatmung wenn nötig

C – CIRCULATION (KREISLAUF)

- RR, HF, Rekapillarisation (< 2s)
- 2 großlumige Zugänge, Volumen
- Blutungsquelle komprimieren

D + E

- D: GCS, Pupillen (Größe/Reaktion/Seitengleich)
- E: Entkleiden, Temp, Verletzungen
- SAMPLE-Anamnese starten

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

17 Glasgow Coma Scale (GCS)

AUGEN ÖFFNEN (1-4)

- 4 = Spontan
- 3 = auf Ansprache
- 2 = auf Schmerzreiz
- 1 = kein Öffnen

VERBAL (1-5)

- 5 = orientiert
- 4 = verwirrt
- 3 = unzusammenhängende Worte
- 2 = unverständliche Laute
- 1 = keine Reaktion

MOTORIK (1-6)

- 6 = befolgt Aufforderungen
- 5 = gezielte Schmerzabwehr
- 4 = ungezielte Abwehr
- 3 = Beugesynergismen
- 2 = Streckesynergismen
- 1 = keine Reaktion
- ⚠ GCS ≤ 8 = Intubation!

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

18 SBAR-Übergabe

S – SITUATION

- Wer bin ich? Welche Station?
- Patient: Name, Zimmer, Diagnose
- Aktuelles Problem in 1 Satz

B – BACKGROUND

- Relevante Vorerkrankungen
- Aktuelle Medikamente
- Letzte Vitalzeichen, BZ, Labor

A – ASSESSMENT

- Meine Einschätzung: Was glaube ich?
- Dringlichkeit einschätzen
- „Ich mache mir Sorgen weil...“

R – RECOMMENDATION

- Was brauche ich von Ihnen?
- Konkrete Bitte: Visitenkommen? Anordnung? Rückruf?
- Zeitrahmen nennen

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

19 Sepsis-Erkennung (qSOFA)

QSOFA – JE 1 PUNKT

- RR systolisch ≤ 100 mmHg
- Atemfrequenz ≥ 22/min
- Bewusstseinsveränderung (GCS < 15)
- ⚠ qSOFA ≥ 2 → Sepsisverdacht!

SOFORTMASSNAHMEN (1H-BUNDLE)

- Blutkultur (2 Paare) VOR Antibiose!
- Laktat-Messung (> 2 = kritisch)
- Breitband-Antibiotikum i.v.
- 500ml Kristalloid-Bolus (bei Hypotonie)
- Arzt sofort informieren!

SIRS-KRITERIEN

- Temp > 38°C oder < 36°C
- HF > 90/min
- AF > 20/min oder pCO₂ < 32
- Leuko > 12.000 oder < 4.000

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

20 Anaphylaxie Notfall

SCHWEREGRADE (I-IV)

- I: Haut (Urtikaria, Flush, Juckreiz)
- II: Haut + Kreislauf/Abdomen
- III: Bronchospasmus, Schock
- IV: Herz-Kreislauf-Stillstand

SOFORTMASSNAHMEN

- Auslöser SOFORT stoppen!
- Adrenalin 0,5mg i.m. Oberschenkel (immer!)
- O₂ 10-15 l/min
- Venenzugang, 500-1000ml Kristalloid
- Flachlagerung + Beine hoch (Schock)

FOLGEMEDIKATION

- H1: Dimetinden (Fenistil) i.v.
- H2-Blocker optional nach Klinikstandard
- Kortison: Prednisolon 250-1000mg i.v.
- Bei Bronchospasmus: Salbutamol inhalativ
- Notarzt rufen!

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

21 Hypoglykämie & Hyperglykämie



HYPOGLYKÄMIE (BZ < 70 MG/DL)

- Wach: 20g KH oral (4x Traubenzucker)
- Bewusstlos: Glukose 40% i.v. 20-40ml
- Oder: Glukagon 1mg i.m./s.c.
- BZ-Kontrolle nach 15 Min.
- Ursache klären!

HYPERGLYKÄMIE (BZ > 300 + KETON)

- DKA: Kussmaul-Atmung, Acetongeruch
- Flüssigkeit 0,9% NaCl (Arzt-AO)
- Insulin i.v. nach Anordnung
- Elektrolyte: K+ engmaschig!
- Arzt sofort informieren

NORMWERTE

- Nüchtern: 70-100 mg/dl
- 2h postprandial: < 140 mg/dl
- HbA1c-Ziel: < 7%
- ⚠ < 50 mg/dl = Notfall!

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

22 EKG-Grundlagen



NORMALER SINUSRHYTHMUS

- HF 60-100/min, regelmäßig
- P-Welle vor jedem QRS
- PQ-Zeit: 120-200ms
- QRS-Breite: < 120ms
- QT-Zeit: < 440ms (Männer)

ALARMZEICHEN – SOFORT ARZT!

- VF/VT: Defibrillation!
- Asystolie: CPR sofort
- STEMI: ST-Hebung ≥ 2mm
- AV-Block III°: kein P→QRS
- Schrittmacher-Versagen

HÄUFIGE ARRHYTHMIEN

- VHF: unregelmäßig, kein P
- VES: breiter QRS, kompensatorische Pause
- LBBB/RBBB: QRS > 120ms
- WPW: kurzes PQ, Delta-Welle
- Torsade de pointes: Drehbewegung

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

23 Blasenkatheter-Pflege



KATHETERANLAGE – ASEPTISCH!

- Sterile Handschuhe + Kittel
- Desinfektion Meatus 3x (außen→innen)
- Charrière: Frauen 12-14 Ch, Männer 14-18 Ch
- Blockung: 5-10ml steriles Aqua dest.
- Fixierung: Schenkel innen (Frauen), Bauch (Männer)

CAUTI-PROPHYLAXE

- Tägliche Indikationsprüfung! (= wichtigste Maßnahme!)
- Geschlossenes System IMMER erhalten
- Beutel IMMER unter Blaseniveau
- Intimhygiene 2x täglich (Wasser, kein Desinfektionsmittel)
- Kein Abklemmen!

WARNSYMPTOME

- Trüber/übelriechender Urin
- Fieber + Flanken-/Bauchschmerz
- Blut im Urin → Arzt
- Beutel voll oder kein Urin (Stau?)
- Urinmenge < 0,5ml/kg/h

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

24 Magensonde (NGS)



ANLAGE

- Größe: Erwachsene 12-16 Ch
- Länge messen: Nase-Ohr-Nabel (ca. 50-60cm)
- Kopf leicht vorbeugen beim Einführen
- Lagekontrolle: Aspiration (pH ≤ 5.5) + Röntgen!
- Fixierung: Nasenpflaster, täglich wechseln

ERNÄHRUNGSMANAGEMENT

- 30-45° Oberkörperhochlagerung IMMER
- Sondenkost-Temperatur: Zimmertemperatur
- Spülung: 20-50ml Wasser vor/nach Gabe
- Restvolumen-Check alle 4h (> 200ml = Arzt!)
- Schlauch alle 24h wechseln

MEDIKAMENTENGABE

- Nur flüssige/lösliche Medikamente!
- Tabletten mörsern + auflösen (Rückfrage Apotheke)
- Interaktionen beachten (pH-abhängig)
- Spülung VOR und NACH Medikament
- Retard-Tabletten NIEMALS mörsern!

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

25 NEWS2-Score

PARAMETER (JE 0-3 PUNKTE)

- Atemfrequenz: 12-20 = 0, < 8 = 3
- SpO₂ (Skala 1): ≥ 96 = 0, ≤ 91 = 3
- SpO₂ (Skala 2, COPD): 88-92 = 0
- Systol. RR: 111-219 = 0, ≤ 90 = 3
- Puls: 51-90 = 0, ≤ 40 = 3
- Temperatur: 36.1-38.0 = 0
- Bewusstsein: alert = 0, CVPU = 3

AUSWERTUNG + REAKTION

- 0 = niedrig, min. 12h-Monitoring
- 1-4 = gering, mind. 4-6h
- 5-6 = mittel → Arzt sofort, mind. 1h
- ≥ 7 = HOCH → Notfallteam!
- Neu: O₂-Gabe = automatisch +2 Punkte

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

26 Delir-Erkennung (CAM-ICU)

CAM-ICU – 4 KRITERIEN

- 1. Akuter Beginn/Fluktuierender Verlauf
- 2. Unaufmerksamkeit (Buchstaben-Test: SAVEAHAART)
- 3. Desorganisiertes Denken
- 4. Veränderte Bewusstseinslage (RASS ≠ 0)
- ⚠ Delir = Kriterien 1+2 + (3 ODER 4)!

NICHT-PHARMAKOLOGISCHE THERAPIE

- Tag-Nacht-Rhythmus (Licht, Uhren, Kalender)
- Frühmobilisation täglich
- Orientierungshilfen: Brille, Hörgerät!
- Schlaf fördern: Lärm/Licht reduzieren
- Familie einbeziehen, vertraute Stimmen

RASS-SKALA

- +4 Streift lustig, +3 Sehr agitiert
- 0 = Alert/wach (Ziel)
- -1 Schläfrig, -2 Leichte Sedierung
- -3 Moderate, -4 Tiefe Sedierung
- -5 Nicht erweckbar

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

27 Fixierung/FEM – Rechtliches

GRUNDSATZ

- FEM = Letztes Mittel!
- Erst: alle Alternativen ausschöpfen
- Sensormatten, Hüftprotektoren, Bettrandschutz
- Stuhlalarm, Betreuung intensivieren
- Pflegebett absenken

RECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN

- Richterliche Genehmigung (§1906 BGB) ODER
- Betreuungsrechtliche Einwilligung
- Notfall: ohne Genehmigung max. bis Richterentscheid
- Dokumentation: Grund, Zeit, Art, Kontrollen
- 1:1-Betreuung Pflicht!

ÜBERWACHUNG BEI FIXIERUNG

- Vitalzeichen alle 30 Min.
- Durchblutung, Atmung prüfen
- Toilettengang anbieten!
- Ablösen sobald möglich
- Nachgespräch führen
- PsychKG NRW beachten

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

28 Drainagen-Pflege

ALLGEMEINE REGELN

- Immer geschlossenes System!
- Niemals höher als Ableitstelle platzieren
- Drainagevolumen täglich dokumentieren
- Farbe, Konsistenz, Geruch beurteilen
- Eintrittsstelle täglich inspizieren

THORAXDRAINAGE

- Drainageflasche: 2/3 Wasser (Wasserventil!)
- Luft/Blut in Kammer = Komplikation → Arzt!
- Patient: keine tiefen Atemzüge vermeiden
- Klemmen NUR auf ärztliche Anordnung
- Milksysteme nach Standard

ABDOMINALDRAINAGE (JP, REDON)

- Redon: Unterdruck täglich prüfen
- JP-Drain: Kammer komprimieren nach Entleerung
- Auslitern, Dokumentation, Kultur bei Infektion
- Zug-Test täglich (zieht → fest verankert)
- Entfernung nach ärztl. AO: Asepsis!

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

29 Bluttransfusion

VOR DER TRANSFUSION

- Aufklärung + Einwilligung (schriftlich)!
- Blutgruppe + Kreuzprobe liegt vor?
- Produktidentifikation: Konserve ≠ Patient → STOPP
- Bettseitige Kontrolle: 2-Personen-Prinzip
- Venenzugang 16-18 G, nur NaCl 0,9%

WÄHREND DER TRANSFUSION

- Erste 15 Min.: langsam! (ca. 20-30 Tr./min)
- Patient nicht allein lassen!
- Vitalzeichen: vorher, nach 15 Min., nach Abschluss
- EK: max. 4h, TK: max. 30 Min., FFP: max. 6h

TRANSFUSIONSREAKTION → STOPP!

- Sofort stoppen, Zugang OFFEN halten
- Arzt sofort!
- Fieber, Schüttelfrost, Juckreiz, RR-Abfall
- Blut + Konserve aufbewahren
- Transfusionsreaktion meldepflichtig

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

30 Kinderreanimation (PBLs)

WICHTIGSTE UNTERSCHIEDE (VS. BLS)

- ZUERST 5 initiale Beatmungen!
- Dann: 15:2 (nicht 30:2!)
- Drucktiefe: 1/3 Thoraxtiefe (4-5cm)
- Säugling: 2 Finger, Kind: 1-2 Handballen
- Frequenz: 100-120/min (wie Erwachsene)

BESONDERHEITEN

- Kopf neutral (Säugling) / leicht überstreckt
- Mund-zu-Mund-Nase (Säugling!)
- AED: ab 1. Lebensjahr, Kinderpads ≤ 25kg
- Adrenalin: 0,01mg/kg i.v. (= 0,1ml/kg 1:10.000)
- IO-Nadel wenn kein i.v.-Zugang in 2 Versuchen

ATEMWEGE KIND

- Säugling atmet nasal → Nase freihalten!
- Pseudokrupp: kühle Luft + Kortison
- Epiglottitis: Kind ruhig halten, kein Spatel!
- Fremdkörper: Rückenschläge + Heimlich ab 1J.

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

31 WHO-Schmerztherapie

STUFE 1: NICHT-OPIOIDE

- Paracetamol 500-1000mg alle 4-6h (max. 4g/d)
- Ibuprofen 400-800mg alle 6-8h (mit Mahlzeit!)
- Metamizol 500-1000mg alle 6h (langsam i.v.!)
- Diclofenac 50-100mg alle 8-12h
- ± Adjuvantien (Antikonvulsiva, Antidepressiva)

STUFE 2: SCHWACHE OPIOIDE

- Tramadol 50-100mg alle 6-8h
- Tilidin/Naloxon 50/4-100/8mg
- Cave: Übelkeit, Schwindel!
- Immer mit Laxans!
- Kombination mit Stufe-1 möglich

STUFE 3: STARKE OPIOIDE

- Morphin retardiert alle 8-12h
- Oxycodon alle 12h, Fentanyl-Pflaster 72h
- IMMER Laxans von Anfang an (Macrogol)!
- Antiemetikum für die ersten Tage
- NRS-Kontrolle vor/nach Gabe dokumentieren

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

32 Beatmung Grundlagen

STARTPARAMETER (ERWACHSENER)

- Tidalvolumen: 6-8ml/kg Idealgewicht
- Frequenz: 12-16/min
- PEEP: 5-8 cmH₂O (Standard)
- FiO₂: Start 1,0 → titrieren auf SpO₂ ≥94%
- Plateaudruck: < 30 cmH₂O (Lungenprotektion)

ALARME → URSACHEN

- Hoher Druck: Husten, Sekret, Tubusabknick, PNX
- Niedriges TV: Leck, Cuff-Druckverlust
- Apnoe: Tubusverlegung/-dislokation → sofort!
- Niedrige SpO₂: Tubuslage, Absaugen, FiO₂ ↑
- Kapno ↑: Hypoventilation, ↓: Fehlage/PE

VAP-PROPHYLAXE (BUNDLE)

- OK 30-45° hochlagern IMMER
- Cuff-Druck 20-30 cmH₂O halten
- Mundpflege Chlorhexidin 2x täglich
- Subglottische Absaugung (falls Tubus)
- Tägliche Extubationsprüfung!

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

33 Flüssigkeitsbilanz



EINFUHR DOKUMENTIEREN

- Trinkmenge (Becher abmessen!)
- Infusionen + Medikamente i.v.
- Enterale/parenterale Ernährung
- Blutprodukte, Spülungen
- Ziel: exakte ml-Angaben

AUSFUHR DOKUMENTIEREN

- Urin (Dauerkatheter: exakt; ohne: schätzen)
- Erbrechen, Drainagen, Wundexsudat
- Stuhl (schätzen: gering/mittel/viel)
- Perspiratio: ca. 500-700ml/24h (unsichtbar)
- Fieber: +200ml/°C über 37°C

AUSWERTUNG

- Ausgeglichene Bilanz = Einfuhr ≈ Ausfuhr
- + Bilanz: Ödemgefahr, Herzinsuffizienz
- – Bilanz: Dehydratation, Nierenversagen
- Tägliche Gewichtskontrolle! (1kg ≈ 1L)
- > +1kg/Tag → Arzt informieren

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

34 Nach einem Sturz



SOFORTMASSNAHMEN

- Patient NICHT sofort aufheben!
- Ersteinschätzung: Bewusstsein, Atmung, Puls
- Verletzungen prüfen: Kopf, Hüfte, Handgelenk
- Bei Verdacht Fraktur: ruhig lagern, Notarzt
- Vitalzeichen, Schmerz-NRS, Pupillen

DOKUMENTATION (SOFORT!)

- Zeitpunkt, Ort, Sturzhergangsbeschreibung
- Wer war dabei? Zeugen?
- Vorgefundene Situation
- Durchgeführte Maßnahmen
- Arztinfo + Angehörigeninfo

NACHBEARBEITUNG

- Sturzprotokoll ausfüllen
- CIRS-Meldung erwägen
- Sturzrisiko neu bewerten (Morse/STRATIFY)
- Maßnahmenplan anpassen
- Patientengespräch + Edukation

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

35 Tracheostoma Pflege



ABSAUGUNG (NUR BEI BEDARF!)

- Präoxygenieren: FiO₂ ↑ für 2 Min.
- Steriler Katheter: max. Kanülendurchmesser
- Einführtiefe: max. 0,5cm über Kanülenspitze
- Sog: max. 150-200 cmH₂O
- Max. 15 Sekunden pro Absaugvorgang!

INNENKANÜLE & HME-FILTER

- Innenkanüle alle 8h reinigen/wechseln
- HME-Filter alle 24h wechseln (Befeuchtung!)
- Stoma täglich mit NaCl-Kompressen reinigen
- Cuff-Druck: 20-25 cmH₂O (Manometer!)
- Sprechventil: nur bei bewusstem, stabilen Pat.

NOTFALL – KANÜLE VERLEGT/HERAUSGEFALLEN

- Ruhe! Sauerstoff sofort anlegen
- Absaugen versuchen
- Kanüle wechseln (immer bereit haben!)
- Notfallset am Bett: Kanülen (gleiche + eine Nr. kleiner)
- Notarzt wenn keine Ventilation möglich

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

36 Schutzausrüstung PSA



ANLEGEN (IN DIESER REIHENFOLGE)

1. Kittel (hinten binden)
 2. Maske/FFP2 (Nasenbügel anformen!)
 3. Schutzbrille
 4. Handschuhe (über Kittelärmel ziehen)
- Vor Anlegen: Händedesinfektion!

ABLEGEN (IN DIESER REIHENFOLGE)

1. Handschuhe (nach innen stülpen)
 2. Kittel (nach innen rollen)
 3. Schutzbrille (an Bügeln absetzen)
 4. Maske (Bänder lösen, nicht vorne anfassen)
- Nach jedem Schritt: Händedesinfektion!

MASKEN-ÜBERSICHT

- MNS/OP-Maske: Tröpfcheninfektionen
- FFP2: MRSA, COVID, Influenza
- FFP3: Offene TBC, SARS
- Wechsel: MNS nach 3-4h, FFP2 nach 8h
- Feuchte Masken SOFORT wechseln!

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

37 SAMPLE-Anamnese Notfall

S – SYMPTOME

- Hauptbeschwerde in eigenen Worten
- Lokalisation, Charakter, Intensität (NRS)
- Beginn, Verlauf, auslösende Faktoren
- Begleitsymptome

A – ALLERGIEN / M – MEDIKAMENTE

- A: Allergien auf Medikamente, Latex, Lebensmittel
- M: Aktuelle Dauermedikation (auch freiverkäuflich!)
- Letzte Einnahme, Dosierung
- Blutgerinnungshemmer besonders wichtig!

P – PROBLEME / L – LETZTE MAHLZEIT / E – EREIGNIS

- P: Bekannte Erkrankungen, Operationen, Krankenhausaufenthalte
- L: Letzte Nahrungsaufnahme (Narkose-relevant!)
- E: Was ist passiert? Hergang, Unfallmechanismus
- Immer bei Trauma: ATLS-Schema

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

38 Intensiv-Medikamente

VASOPRESSOREN/KATECHOLAMINE

- Noradrenalin: 0,01-1,0 µg/kg/min (First-Line Sepsis)
- Adrenalin: 0,01-0,5 µg/kg/min
- Dobutamin: 2-20 µg/kg/min (Kardiogen. Schock)
- Vasopressin: 0,03-0,04 E/min (Add-on)
- NIEMALS unterbrechen → Backup-Perfusor!

SEDIERUNG/ANALGESIE (PADIS)

- Analgesie ZUERST! (Pain before sedation)
- Propofol: 0,3-4 mg/kg/h (max. 48h!)
- Midazolam: 0,03-0,2 mg/kg/h
- Dexmedetomidin: 0,2-1,4 µg/kg/h (kooperativ!)
- Ziel: RASS -1 bis 0 (leicht sediert)

HÄUFIGE I.V.-PERFUSOREN

- Heparin: nach aPTT 60-80s
- Insulin: BZ-Protokoll, Ziel 140-180 mg/dl
- Furosemid: 5-40mg/h (Diurese-Protokoll)
- Amiodaron: 900mg/24h Erhalt nach Bolus
- Kalium: max. 20 mmol/h über ZVK!

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

39 Manchester Triage (MTS)

5 DRINGLICHKEITSSTUFEN

- Rot · sofort · 0 min
- Orange · sehr dringend · 10 min
- Gelb · dringend · 30 min
- Grün · normal · 90 min
- Blau · nicht dringend · 120 min

PRINZIP

- Präsentationsdiagramme + Indikatoren
- Höchste zutreffende Stufe zählt
- Legt Wartezeit fest, nicht Reihenfolge

ROT – BEISPIELE

- Kreislaufstillstand · Schock
- Verlegte Atemwege
- Nicht ansprechbar / schwerste Atemnot

MERKE

- 0-10-30-90-120 min (Rot→Blau)
- Ersteinschätzung, keine Diagnose

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

40 Pädiatrie Notfälle

ATEMNOT BEIM KIND

- Pseudokrupp: Ruhe, Steroid, schwerer Stridor → Adrenalin-Inhalation
- Bronchiolitis (RSV): absaugen, O₂ titrieren, Apnoen beachten
- Asthma: SABA inhalativ + ggf. Steroid

FIEBERKRAMPF

- Schützen, nichts in den Mund
- Dauer messen, > 5 min durchbrechen
- Meningitis ausschließen (Petechien/Nackensteife)

EXSIKKOSE (GASTROENTERITIS)

- ORS in kleinen Mengen häufig
- i.v. bei Schock
- keine Motilitätshemmer

FREMDKÖRPERASPIRATION

- Effektiver Husten → ermutigen
- Säugling: 5 Rückenschläge + 5 Thoraxkompressionen
- Nie blind auswaschen; bewusstlos → CPR

WARNZEICHEN

- Leiser werdender Stridor + Erschöpfung
- Apnoen beim Säugling
- Nicht wegdrückbare Petechien = Notfall

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.


Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de

Notfallmedikamente

19 Medikamente aus Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin mit Dosierung, Wirkung, Nebenwirkungen, Kontraindikationen und Pflegehinweisen.



Bestehen ist planbar.

Anästhesie

Intensivmedizin

Notfallmedizin

Pflegehinweise

19

Medikamente

3

Fachbereiche

A4

druckfertig

INHALT

1

Anästhesie (7 Medikamente)

2

Intensivmedizin (6 Medikamente)

3

Notfallmedizin (6 Medikamente)

△ Nur zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken. Ersetzt keine Fachinformation, keinen Klinikstandard und keine ärztliche Anordnung. Dosierungen immer gegen die aktuellen Standards deiner Einrichtung prüfen.

Anästhesie

7 Medikamente

Propofol Hypnotikum

DOSIS	1-2,5 mg/kg i.v. Einleitung; 4-12 mg/kg/h TIVA
WIRKUNG	Bewusstseinsverlust, Sedierung, leichte Analgesie, antiemetisch
NEBENWIRKUNGEN	Blutdruckabfall, Atemdepression, Injektionsschmerz, Lipidinfusion
KONTRAINDIKATIONEN	Sojaallergie, Eiweißallergie, Propofol-Infusions-Syndrom bei >48h
PFLEGE & PRAXIS	Blutdruck überwachen, Apnoe-Bereitschaft, nicht >48h auf ICU, Emulsion kühl lagern

Remifentanyl Opioid (ultrakurz)

DOSIS	0,05-2 µg/kg/min i.v. (TIVA)
WIRKUNG	Starke Analgesie, Atemdepression, Bradykardie, Hustendämpfung
NEBENWIRKUNGEN	Atemdepression, Bradykardie, Rigidität (hohe Dosen), Hyperalgesie nach Absetzen
KONTRAINDIKATIONEN	Relative KI: Spontanatmung ohne Monitoring
PFLEGE & PRAXIS	NUR unter Beatmung! Sofort antagonisieren mit Naloxon bei Überdosierung, nie als Bolus

Fentanyl Opioid

DOSIS	1-3 µg/kg i.v.; Pflaster 12-200 µg/h
WIRKUNG	Starke Analgesie, Sedierung, Hustendämpfung
NEBENWIRKUNGEN	Atemdepression, Übelkeit, Obstipation, Suchtpotenzial
KONTRAINDIKATIONEN	MAO-Hemmer (Kombination!), schwere Ateminsuffizienz
PFLEGE & PRAXIS	Naloxon bereithalten, Atemfrequenz überwachen, Pflaster: Hautreaktion prüfen

Midazolam Benzodiazepin

DOSIS	0,03-0,3 mg/kg/h i.v. Sedierung; 1-2,5 mg Anxiolyse
WIRKUNG	Anxiolyse, Sedierung, Amnesie, Muskelrelaxation, antikonvulsiv
NEBENWIRKUNGEN	Atemdepression, Blutdruckabfall, paradoxe Reaktionen (Kinder/Ältere), Abhängigkeit
KONTRAINDIKATIONEN	Myasthenia gravis, schwere Leberinsuffizienz
PFLEGE & PRAXIS	Antagonist: Flumazenil! Atemüberwachung, bei Agitation paradoxe Reaktion bedenken

Rocuronium Nicht-depolarisierendes Muskelrelaxans

DOSIS	0,6 mg/kg Intubation; 0,1-0,2 mg/kg Erhalt
WIRKUNG	Neuromuskuläre Blockade → Muskellähmung, Intubationsbedingungen
NEBENWIRKUNGEN	Anaphylaxie möglich · Relaxansüberhang (Restblockade) · wirkt weder sedierend noch analgetisch
KONTRAINDIKATIONEN	Myasthenia gravis (relativ)
PFLEGE & PRAXIS	Immer mit Hypnotikum und Analgetikum kombinieren – sonst ist der Patient gelähmt, aber wach! Relaxometrie, Antagonist: Sugammadex

Succinylcholin Depolarisierendes Muskelrelaxans

DOSIS	1-1,5 mg/kg i.v. RSI
WIRKUNG	Schnelle vollständige Muskelrelaxation (60s), kurze Wirkdauer 10-15 Min.
NEBENWIRKUNGEN	Faszikulationen, Hyperkaliämie, Bradykardie, MH-Trigger!, Histaminfreisetzung
KONTRAINDIKATIONEN	Verbrennungen, Querschnitt, MH-Disposition, Hyperkaliämie, Pseudocholinesterasemangel
PFLEGE & PRAXIS	MH-Notfallset bereit! Dantrolen griffbereit! Nur RSI-Indikation

Ketamin (S-Ketamin) Dissoziatives Anästhetikum

DOSIS	1-2 mg/kg i.v. Anästhesie; 0,1-0,5 mg/kg Analgesie
WIRKUNG	Dissoziation, Analgesie, Bronchodilatation, Kreislaufstimulation, erhält Schutzreflexe
NEBENWIRKUNGEN	Halluzinationen, Alpträume, Tachykardie, RR-Anstieg, Hypersalivation
KONTRAINDIKATIONEN	Hypertensive Krise, erhöhter Hirndruck (relativ), Psychosen
PFLEGE & PRAXIS	Kombination mit Midazolam (Halluzinationen!), Licht dimmen, ruhige Umgebung, Absaugbereitschaft (Hypersalivation)

Intensivmedizin

6 Medikamente

Noradrenalin Vasopressor (α_1 -Agonist)

DOSIS	0,01-1,0 $\mu\text{g/kg/min}$ i.v. Perfusor
WIRKUNG	Vasokonstriktion $\rightarrow$ MAP $\uparrow$, wenig Herzfrequenzeffekt
NEBENWIRKUNGEN	Periphere Ischämie, Tachykardie, Hypertonie bei Überdosierung
KONTRAINDIKATIONEN	Hypovolämie ohne Volumenersatz (relativ)
PFLEGE & PRAXIS	Nur ZVK oder sichere Kanüle! Backup-Perfusor! NIE unterbrechen! 4-Augen-Prinzip bei Zubereitung

Adrenalin Katecholamin ($\alpha+\beta$ -Agonist)

DOSIS	0,01-1 $\mu\text{g/kg/min}$ Perfusor; 1mg i.v. Reanimation
WIRKUNG	Herzfrequenz $\uparrow$, Kontraktilität $\uparrow$, Vasokonstriktion, Bronchodilatation
NEBENWIRKUNGEN	Tachykardie, Arrhythmien, Hypertonie, Myokardischämie
KONTRAINDIKATIONEN	Relative KI: schwere KHK, Tachyarrhythmien
PFLEGE & PRAXIS	Bei Anaphylaxie: 0,5mg i.m.! Bei Reanimation: 1mg i.v. alle 3-5 Min.

Dobutamin Positiv-inotrop (β_1 -Agonist)

DOSIS	2-20 $\mu\text{g/kg/min}$ i.v. Perfusor
WIRKUNG	Herzfrequenz $\uparrow$, Kontraktilität $\uparrow$ (inotrop), Vasodilatation (β_2)
NEBENWIRKUNGEN	Tachykardie, Arrhythmien, RR-Abfall möglich
KONTRAINDIKATIONEN	Obstruktive Kardiomyopathie, schwere Aortenklappenstenose
PFLEGE & PRAXIS	Häufig kombiniert mit Noradrenalin, HF-Monitoring, EKG

Heparin (unfraktioniert) Antikoagulans

DOSIS	Initial 5000 IE i.v.; Erhalt nach aPTT (Ziel 60-80s)
WIRKUNG	Hemmung der Gerinnungskaskade (IIa, Xa), schnell wirksam, kurze HWZ
NEBENWIRKUNGEN	Blutungen, HIT (Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II!), Hyperkaliämie
KONTRAINDIKATIONEN	Aktive Blutung, HIT Vorgeschichte, schwere Thrombozytopenie
PFLEGE & PRAXIS	Thrombozyten täglich! HIT-Verdacht: Heparin sofort stoppen, Alternativantikoagulation. Antagonist: Protamin

Propofol (ICU-Sedierung) Hypnotikum/Sedativum

DOSIS	0,3-4 mg/kg/h Sedierung ICU
WIRKUNG	Sedierung, Anxiolyse, antiemetisch
NEBENWIRKUNGEN	Propofol-Infusions-Syndrom (>48h, >4mg/kg/h): Azidose, Rhabdomyolyse, Herzversagen!
KONTRAINDIKATIONEN	>48h Dauerinfusion auf ICU vermeiden, Triglyzeride überwachen
PFLEGE & PRAXIS	Triglyzeride kontrollieren, max. 4mg/kg/h, RASS-Score dokumentieren, Analgesie zuerst (PADIS)!

Dexmedetomidin α_2 -Agonist/Sedativum

DOSIS	0,2-1,4 μ g/kg/h i.v.
WIRKUNG	Sedierung ohne Atemdepression, analgetisch, anxiolytisch, sympatholytisch
NEBENWIRKUNGEN	Bradykardie, Hypotonie, Mundtrockenheit
KONTRAINDIKATIONEN	AV-Block Grad II/III, schwere Herzinsuffizienz
PFLEGE & PRAXIS	Patient erweckbar! Weniger Delir als Benzodiazepine. HF und RR überwachen

Notfallmedizin

6 Medikamente

Adrenalin (Reanimation) Katecholamin

DOSIS	1mg i.v./i.o. alle 3-5 Min. (ERC-Leitlinie)
WIRKUNG	Koronarperfusion↑, zerebrale Perfusion↑, Vasokonstriktion
NEBENWIRKUNGEN	Tachykardie, Arrhythmien, Hypertonie nach ROSC
KONTRAINDIKATIONEN	Keine absoluten KI bei Reanimation
PFLEGE & PRAXIS	Während CPR! Nach ROSC: RR, HF, Temperatur überwachen, Zieltemperaturmanagement

Amiodaron Antiarrhythmikum (Klasse III)

DOSIS	300mg i.v. Bolus VF/pVT; 150mg bei Wiederholung
WIRKUNG	Verlängert Repolarisation, antiarrhythmisch bei VF/pVT nach 3. Defibrillation
NEBENWIRKUNGEN	Hypotonie, Bradykardie, Phlebitis, Schilddrüsenprobleme (Langzeit)
KONTRAINDIKATIONEN	Jodallergie (Kurzzeit relativ), Sinusbradykardie
PFLEGE & PRAXIS	Nur über ZVK langfristig, Lichtschutz, Schilddrüsenwerte Langzeit kontrollieren

Atropin Anticholinergikum

DOSIS	0,5-1mg i.v. Bradykardie; max. 3mg
WIRKUNG	Herzfrequenz↑ (vagolytisch), Bronchodilatation, Speichelsekretion↓
NEBENWIRKUNGEN	Tachykardie, Mundtrockenheit, Harnverhalt, Mydriasis, Hyperthermie
KONTRAINDIKATIONEN	Glaukom (relativ), Prostatahyperplasie
PFLEGE & PRAXIS	Bei Asystolie/PEA in der Reanimation nicht mehr empfohlen! EKG-Monitoring, Harnblase kontrollieren

Naloxon Opioid-Antagonist

DOSIS	0,4-2mg i.v./i.m./nasal; titrieren 0,04mg Schritte
WIRKUNG	Kompetitive Verdrängung der Opioiden vom Rezeptor → Aufhebung Atemdepression
NEBENWIRKUNGEN	Akutes Entzugssyndrom, Tachykardie, Hypertonie, Lungenödem
KONTRAINDIKATIONEN	Keine absoluten KI bei Atemdepression
PFLEGE & PRAXIS	Kurze HWZ (30-90 Min.)! Opioid wirkt länger → Rebound-Atemdepression! Engmaschiges Monitoring, ggf. wiederholen

Dantrolen Muskelrelaxans (Spezifisch MH)

DOSIS	2,5 mg/kg i.v. Bolus, bis 10mg/kg
WIRKUNG	Hemmung der Kalziumfreisetzung aus sarkoplasmatischem Retikulum → MH-Therapie
NEBENWIRKUNGEN	Muskelschwäche, Phlebitis, Übelkeit
KONTRAINDIKATIONEN	Keine bei MH-Notfall
PFLEGE & PRAXIS	MH-Notfall: sofort Trigger stoppen, 100% O ₂ , Dantrolen, aktive Kühlung. Immer vorrätig im OP!

Glukose 40-50% Antihypoglykämikum

DOSIS	20-40ml G40% i.v. bei Hypoglykämie
WIRKUNG	Sofortiger BZ-Anstieg
NEBENWIRKUNGEN	Venenwandreizung (hyperosmolar!), Hyperglykämie bei Überdosierung
KONTRAINDIKATIONEN	Hyperglykämie
PFLEGE & PRAXIS	Nur über guten Venenzugang! BZ-Kontrolle nach 15 Min., Ursache der Hypoglykämie klären


Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de

Prophylaxen-Kompodium



Alle examensrelevanten Prophylaxen mit Risikofaktoren, Assessment-Skalen, Maßnahmen und Expertenstandards – übersichtlich zum Lernen und Nachschlagen.

Bestehen ist planbar.

Expertenstandards

Assessment-Skalen

Hygiene

Examen

16

Themen

DNQP

Standards

A4

druckfertig

⚠ Lernhilfe für Ausbildung und Prüfung. Es gelten die Standards und Verfahrensanweisungen deiner Einrichtung.

Inhalt

Jedes Thema auf einer eigenen Seite – ideal zum Ausdrucken und Abheften.

01 Dekubitusprophylaxe

02 Sturzprophylaxe

03 Thromboseprophylaxe

04 Pneumonieprophylaxe

05 Aspirationsprophylaxe

06 Kontrakturprophylaxe

07 Intertrigoprophyllaxe

08 Obstipationsprophylaxe

09 Dehydrationsprophylaxe

10 Mangelernährungsprophylaxe

11 Infektionsprophylaxe / Hygiene

12 Stomatitisprophylaxe

13 Parotitisprophylaxe

14 Hygienische Händedesinfektion

15 Handschuhe – Wann ja, wann nein?

16 Allgemeine Krankenhaushygiene

1 Dekubitusprophylaxe

Maßnahmen zur Verhütung von Druckgeschwüren durch Druckentlastung, Hautpflege und Mobilisation.

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität / Bettlägerigkeit
- Mangelernährung & Dehydration
- Inkontinenz / Feuchtigkeit
- Sensibilitätsstörungen
- Durchblutungsstörungen
- Hohes Alter

ASSESSMENT-SKALA

Braden-Skala

≤18 Punkte = Risiko · ≤12 = hohes Risiko · ≤9 = sehr hohes Risiko

- Sensorisches Empfindungsvermögen
- Feuchtigkeit
- Aktivität
- Mobilität
- Ernährung
- Reibung & Scherkräfte

KATEGORIEN / STADIEN

- Kat. I: Nicht wegdrückbare Rötung, Haut intakt
- Kat. II: Teilverlust der Haut (Blase/Abschürfung)
- Kat. III: Vollständiger Hautverlust, Subkutis sichtbar
- Kat. IV: Vollständiger Gewebeverlust, Knochen/ Sehnen sichtbar

MASSNAHMEN

- Lagerungswechsel alle 2 Stunden (oder individueller Plan)
- Antidekubitusmatratze / Wechseldruckmatratze
- Druckentlastung: Fersen, Steißbein, Schulterblätter
- Hautbeobachtung bei jeder Pflege (Rötung = Kategorie I)
- Hautpflege: pH-neutral, keine Massage bei Rötung
- Flüssigkeit mind. 1,5–2 l/Tag
- Proteinreiche Ernährung
- Inkontinenzversorgung optimieren
- Dokumentation nach Kategorien I–IV (EPUAP)

Standard / Grundlage: DNQP Expertenstandard Dekubitusprophylaxe (2017)

2 Sturzprophylaxe

Maßnahmen zur Verhinderung von Stürzen, besonders bei älteren und kognitiv eingeschränkten Patienten.

RISIKOFAKTOREN

- Gangstörungen, Gangunsicherheit
- Schwindel, orthostatische Hypotonie
- Seheinschränkungen
- Kognitive Beeinträchtigung / Demenz
- Polymedikation (Sedativa, Diuretika, Antihypertensiva)
- Frühere Stürze
- Inkontinenz (Dranggefühl)
- Unbekannte Umgebung

ASSESSMENT-SKALA

Morse-Sturzskala

0–24 = kein Risiko • 25–44 = mittleres Risiko • ≥45 = hohes Risiko

- Sturzvorgeschichte
- Sekundärdiagnose
- Gehhilfe
- IV-Zugang
- Gang
- Geistiger Zustand

MASSNAHMEN

- Rufanlage in Reichweite, Funktion erklären
- Bett auf niedrigste Position
- Orientierungslicht nachts
- Rutschfeste Schuhe / Socken
- Haltegriffe im Bad und WC
- Gehhilfen griffbereit
- Medikamente prüfen (Sedativa reduzieren?)
- Regelmäßiges Toilettenanbieten
- Sturzprotokoll nach Sturzereignis

Standard / Grundlage: DNQP Expertenstandard Sturzprophylaxe (2013/2019)

3 Thromboseprophylaxe

Vorbeugung tiefer Venenthrombosen durch physikalische und medikamentöse Maßnahmen.

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität / Bettruhe
- Postoperativer Zustand
- Übergewicht (BMI >30)
- Dehydration
- Herzinsuffizienz
- Malignom
- Frühere TVT / LE
- Hormontherapie

WARNZEICHEN

- Wadenschmerz
- Schwellung
- Überwärmung
- Rötung
- Homans-Zeichen

MASSNAHMEN

- Frühmobilisation so früh wie möglich
- Kompressionsstrümpfe (ATS Kl. I/II) korrekt anlegen
- Intermittierende pneumatische Kompression (IPK)
- Beinübungen im Bett (Pumpen, Kreisen)
- Ausreichend Flüssigkeit
- NMH s.c. nach Anordnung (Clexane, Fragmin)
- Bei oraler Antikoagulation: INR / Anti-Xa überwachen

NOTFALLMASSNAHMEN

Lungenembolie: Dyspnoe + Tachykardie + Thoraxschmerz → SOFORT Arzt!

Standard / Grundlage: S3-Leitlinie Prophylaxe der venösen Thromboembolie (AWMF)

4 Pneumonieprophylaxe

Vorbeugung einer Lungenentzündung durch Sekretmobilisation, Atemübungen und Frühmobilisation.

RISIKOFAKTOREN

- Bettlägerigkeit
- Beatmung / Intubation
- Schluckstörungen
- Rauchen
- COPD, Asthma
- Immunsuppression
- Hohes Alter
- Schmerzen (verhindert tiefes Atmen)

MASSNAHMEN

- Atemgymnastik: tiefes Ein-/Ausatmen, Lippenbremse
- Atemstimulierende Einreibung (ASE) nach Bienstein
- Inzentiv-Spirometer (Flutter, Triflow)
- Sekretmobilisation: Abklopfen, Vibrationsmassage
- Oberkörperhochlagerung 30° (besonders bei Beatmung)
- Frühmobilisation: Sitzen → Stehen → Gehen
- Ausreichend Flüssigkeit (Sekret verflüssigen)
- Mundpflege (Keimreduktion)
- Schmerzmanagement

ATEMSTIMULIERENDE EINREIBUNG (ASE)

ASE: Kreisende Bewegungen am Rücken im Atemrhythmus des Patienten, 5–10 Min., fördert reflektorisch die Atemtiefe

5 Aspirationsprophylaxe

Verhütung des Eindringens von Speichel, Nahrung oder Mageninhalt in die Atemwege.

RISIKOFAKTOREN

- Schluckstörungen (Dysphagie)
- Bewusstseinsstörungen
- PEG / nasogastrale Sonde
- Erbrechen / Reflux
- Neurologische Erkrankungen
- Demenz
- Sedierung

MASSNAHMEN

- Oberkörper beim Essen 30–90° hochlagern
- Position 30 min nach Essen beibehalten
- Schlucktestung vor erster Mahlzeit
- Angedickte Kost / Flüssigkeiten
- Kein Strohhalm bei Schluckstörung
- Kleine Bissen, langsames Essen
- Absauggerät bereithalten
- Logopädie einbeziehen

6 Kontrakturprophylaxe

Verhütung von Gelenkversteifungen durch regelmäßige Bewegung und korrekte Lagerung.

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität / Lähmungen
- Spastik (z.B. nach Schlaganfall)
- Schmerzen (Schonhaltung)
- Bewusstlosigkeit
- Frakturen / Verbände

MASSNAHMEN

- Passive Bewegungsübungen aller Gelenke (2× täglich)
- Korrekte Lagerung in Funktionsstellung
- Keine Spitzfußlage: Antispitzfußschiene / Fußstütze
- Handrolle bei Faustbildungstendenz
- Frühmobilisation
- Physiotherapie einbeziehen
- Schmerzen behandeln

LAGERUNGSTECHNIKEN

- Funktionsstellung: Gelenke in physiologischer Mittelstellung lagern
- Lagerung regelmäßig wechseln (Rücken-, Seiten-, 30°-Lagerung)
- Bei Hemiplegie: Lagerung nach Bobath-Konzept, betroffene Seite einbeziehen
- Füße: Fußsohle abgestützt, Bettdecke nicht auf die Zehen drücken lassen
- Lagerungshilfsmittel gezielt einsetzen, keine starren Dauerlagerungen

Standard / Grundlage: Kein eigener DNQP-Expertenstandard – Orientierung an Physiotherapie- und Bobath-Konzept

7 Intertrigoprophylaxe

Verhütung von Hautreizungen in Hautfalten durch Feuchtigkeit, Reibung und Wärme.

RISIKOFAKTOREN

- Übergewicht
- Diabetes
- Schwitzen
- Inkontinenz
- Immobilität

MASSNAHMEN

- Hautfalten täglich inspizieren (Achseln, Leisten, Bauch, Brust)
- Sorgfältig trocknen (Föhn auf niedrigster Stufe)
- Zinksalbe oder Cavilon-Spray
- Baumwolltücher zwischen Hautfalten
- Atmungsaktive Kleidung
- Bei Candidose: Nystatin-Puder

8 Obstipationsprophylaxe

Verhütung von Verstopfung durch Flüssigkeit, ballaststoffreiche Kost und Bewegung.

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität
- Geringe Flüssigkeitszufuhr
- Ballaststoffarme Ernährung
- Opioide / Anticholinergika
- Schilddrüsenunterfunktion
- Demenz

MASSNAHMEN

- Flüssigkeit mind. 1,5–2 l/Tag
- Ballaststoffreiche Kost: Vollkorn, Obst, Gemüse
- Körperliche Aktivität
- Bauchmassage im Uhrzeigersinn
- Warmes Getränk morgens (Gastrokolischer Reflex)
- Stuhlprotokoll führen
- Laxanzien nach AO: Macrogol, Lactulose, Bisacodyl
- Bei Opioidtherapie: prophylaktisch Laxans!

9 Dehydrationsprophylaxe

Verhütung von Flüssigkeitsmangel durch ausreichende Zufuhr und frühzeitige Erkennung.

RISIKOFAKTOREN

- Hohes Alter (Durstgefühl ↓)
- Demenz
- Schluckstörungen
- Fieber / Erbrechen / Durchfall
- Diuretika
- Hitze

WARNZEICHEN

- Trockene Schleimhäute
- Stehende Hautfalten
- Konzentrierter Urin (dunkelgelb)
- Tachykardie
- Hypotonie
- Verwirrtheit

MASSNAHMEN

- Trinkprotokoll führen (Ziel 1,5–2 l/Tag)
- Getränke in Reichweite stellen
- Alle 2h Trinken anbieten
- Lieblingsgetränke erfragen
- Ein-/Ausfuhr bilanzieren bei Risiko
- Suppe, Joghurt, Obst als Flüssigkeitsquellen
- Bei Dysphagie: angedickte Flüssigkeiten

10 Mangelernährungsprophylaxe

Verhütung von Unterernährung durch Ernährungsassessment und gezielte Maßnahmen.

ASSESSMENT-SKALA

MNA (Mini Nutritional Assessment)

≥ 24 = gut · $17-23,5$ = Risiko · < 17 =

Mangelernährung

MASSNAHMEN

- Gewicht wöchentlich kontrollieren
- Ernährungsprotokoll führen
- Appetitfördernde Maßnahmen: Lieblingsessen, Atmosphäre
- Kleine häufige Mahlzeiten
- Hochkalorische Trinknahrung (Fresubin, Ensure)
- Essen assistieren bei Bedarf
- Mundpflege (Schmerzen beim Essen?)
- Ernährungsberatung
- PEG bei dauerhafter oraler Unfähigkeit

11 Infektionsprophylaxe / Hygiene

Verhütung nosokomialer Infektionen durch konsequente Hygienemaßnahmen.

MASSNAHMEN

- Händehygiene: 5 Momente der WHO
- Hygienische HD: 30 Sekunden · Chirurgische HD: 3 Minuten
- Schutzausrüstung situationsgerecht: Handschuhe, Kittel, Maske
- Aseptisches Arbeiten bei Wundversorgung, Katheter, Infusionen
- Katheter: täglich Notwendigkeit prüfen (CAUTI-Prävention)
- Isolationsmaßnahmen bei MRSA, VRE, ESBL
- Reinigungs- und Desinfektionsplan einhalten

5 MOMENTE DER HÄNDEHYGIENE

1. Vor Patientenkontakt
2. Vor aseptischen Tätigkeiten
3. Nach Kontakt mit infektiösem Material
4. Nach Patientenkontakt
5. Nach Kontakt mit Patientenumgebung

12 Stomatitisprophylaxe

Verhütung von Mundschleimhautentzündungen, besonders bei Chemo, Immunsuppression und Beatmung.

MASSNAHMEN

- Mundpflege 4–6× täglich (weiche Zahnbürste)
- Schleimhäute feucht halten (Mundspray, Glycerin)
- Keine alkoholhaltigen Mundspülungen
- Kamillentee / Salbeitee zum Spülen
- Bei Chemotherapie: Mundschleimhaut kühlen (Eiswürfel)
- Bei Soor: Nystatin-Suspension
- Lippen mit Fettsalbe pflegen
- Prothesen nachts herausnehmen und reinigen

13 Parotitisprophylaxe

Verhütung der Ohrspeicheldrüsenentzündung durch ausreichende Speichelproduktion und Mundpflege.

RISIKOFAKTOREN

- Dehydration
- Mundatmung
- NPO (Nahrungskarenz)
- Immunsuppression
- Anticholinergika

MASSNAHMEN

- Ausreichend Flüssigkeit
- Regelmäßige Mundpflege
- Kaugummi kauen (Speichelfluss ↑)
- Saure Drops (Speichelproduktion ↑)
- Mundatmung vermeiden: Nasenpflege
- Ohrspeicheldrüse beobachten (Schwellung, Schmerz)

14 Hygienische Händedesinfektion

Die hygienische Händedesinfektion ist die wichtigste Einzelmaßnahme zur Verhütung nosokomialer Infektionen. Sie reduziert die transiente Keimflora auf ein sicheres Niveau (WHO, KRINKO 2016).

INDIKATIONEN

- 1. Vor Patientenkontakt
- 2. Vor aseptischen Tätigkeiten (Wundversorgung, Katheter, Infusion)
- 3. Nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material (Blut, Körperflüssigkeiten)
- 4. Nach Patientenkontakt
- 5. Nach Kontakt mit Patientenumgebung (Klingel, Bettgitter, Nachttisch)

DURCHFÜHRUNG

- Mindestens 3–5 ml alkoholisches Händedesinfektionsmittel entnehmen
- Einreiben mindestens 30 Sekunden (EN 1500)
- Schritt 1: Handfläche auf Handfläche reiben
- Schritt 2: Rechte Handfläche über linken Handrücken, wechseln
- Schritt 3: Handfläche auf Handfläche mit verschränkten Fingern
- Schritt 4: Außenseite der Finger durch Einschlagen
- Schritt 5: Daumen eingeschlossen in anderer Hand, wechseln
- Schritt 6: Fingerkuppen kreisend in Handfläche, wechseln
- Hände trocknen lassen – NICHT abwischen!

MASSNAHMEN

Creme

- Hände waschen NUR wenn sichtbar verschmutzt oder nach C.-difficile-Kontakt (Sporenbildner – Alkohol unwirksam!)
- Vor Desinfektion: Hände TROCKEN (feuchte Hände reduzieren Wirksamkeit)
- Handschuhe ersetzen Händedesinfektion NICHT
- Kein Schmuck, keine Uhren, keine langen Fingernägel, kein Nagellack
- Hautschutz: vor Dienst → Schutzpräparat · während Dienst → Pflegecreme · nach Dienst → rückfettende

HÄUFIGE FEHLER

- Zu wenig Desinfektionsmittel aufgetragen (verdampft zu schnell)
- Fingerkuppen und Daumen vergessen – häufigste Fehlerzone!
- Handschuhe abziehen ohne anschließende Desinfektion
- Hautschutz vernachlässigt → Hautschäden → Keimreservoir

Standard / Grundlage: WHO-Leitlinie Händehygiene 2009 · KRINKO-Empfehlung Händehygiene 2016 · EN 1500

15 Handschuhe – Wann ja, wann nein?

Handschuhe schützen Patient und Pflegende. Falscher Einsatz macht Handschuhe selbst zum Übertragungsweg. Sie ersetzen die Händedesinfektion NICHT.

MASSNAHMEN

HANDSCHUHE: WANN JA

HANDSCHUHE: WANN NEIN

- Nach jedem Handschuhwechsel: Händedesinfektion!
- Handschuhe direkt nach Gebrauch entsorgen – nicht in Taschen tragen
- Handschuhgröße wählen: zu eng → reißen · zu weit → rutschen
- Latexallergie: Nitril-Handschuhe verwenden
- Kontakt mit Blut, Körperflüssigkeiten, Sekreten, Exkreten
- Kontakt mit Schleimhäuten oder nicht-intakter Haut
- Legen / Pflege von Gefäßzugängen, Kathetern, Drainagen
- Wundversorgung
- Kontakt mit kontaminierten Materialien (Verbände, Wäsche)
- Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Schutzhandschuhe)
- Isolationspflichtige Patienten (MRSA, VRE, Noro etc.)
- Normaler Patientenkontakt ohne Körperflüssigkeitskontakt (Begrüßung, Blutdruck messen)
- Medikamente richten ohne Kontaminationsrisiko
- Dauerhaftes Tragen ohne Indikation → Übertragungsweg + falsche Sicherheit

WARUM NICHT DAUERHAFT TRAGEN

- Handschuhe haben mikro-poröse Defekte – kein 100% Schutz
- Beim Aus-/Anziehen leichte Kontamination der Hände möglich
- Falsches Sicherheitsgefühl: Desinfektion wird vergessen
- Erhöhtes Übertragungsrisiko bei Wechsel ohne Händedesinfektion

HANDSCHUHTYPEN

- Untersuchungshandschuhe (Nitril/Latex): nicht-steril, allgemeiner Schutz
- Sterile OP-Handschuhe: aseptische Eingriffe, sterile Katheterisierung
- Haushaltshandschuhe: Reinigung und Flächendesinfektion
- Chemikalienschutzhandschuhe: Desinfektionsmittelkonzentrate

Standard / Grundlage: TRBA 250 (Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen) · KRINKO 2016

16 Allgemeine Krankenhaushygiene

Krankenhaushygiene umfasst alle Maßnahmen zur Verhütung nosokomialer Infektionen. Ca. 400.000–600.000 nosokomiale Infektionen jährlich in Deutschland, ca. 10.000–15.000 Todesfälle.

RISIKOFAKTOREN

- Liegekatheter (CAUTI-Risiko: täglich Notwendigkeit prüfen!)
- Gefäßzugänge (ZVK-assoziierte Sepsis)
- Beatmung (VAP)
- Postoperative Wundinfektionen
- Immunsupprimierte Patienten

MASSNAHMEN

Schlussdesinfektion

- Flächendesinfektion: täglich patientennahe Flächen (Bettgitter, Nachttisch, Klingel), nach Entlassung
- Wischdesinfektion: von rein nach unrein · von oben nach unten · Einwirkzeit beachten
- Abfall: Gruppe A (Hausmüll) · Gruppe B (infektiös) · Gruppe C (Zytostatika) · Sharpsafe für Nadeln
- Kanülen NIEMALS recappen – Nadelstichverletzungsgefahr!
- Infektionswäsche: roter Sack, direkt verschließen, nicht ausschütteln
- PSA anlegen: Kittel → Maske → Brille → Handschuhe
- PSA ablegen: Handschuhe → Kittel → Brille → Maske → Händedesinfektion

ISOLATIONSMASSNAHMEN

- MRSA: Einzelzimmer, Kittel + Handschuhe + FFP2
- VRE: Einzelzimmer, Kittel + Handschuhe
- Norovirus/C. difficile: Einzelzimmer, Händewaschen (kein Alkohol!), Kittel + Handschuhe
- Tröpfchen (Influenza, COVID): chirurgischer MNS oder FFP2
- Aerogen (TBC): Einzelzimmer mit Unterdruck, FFP3

MELDEPFLICHT

NRW

- Nosokomiale MRSA/VRE/ESBL-Infektionen: Meldepflicht §6/§7 IfSG
- Ausbrüche (≥ 2 Erkrankungen, epidemiolog. Zusammenhang): sofortige Meldung ans Gesundheitsamt
- Krankenhäuser: Surveillance-Pflicht nach §23 IfSG
- Schulungspflicht: mind. 1× jährlich

Standard / Grundlage: Infektionsschutzgesetz (IfSG) §23, §36 · KRINKO-Empfehlungen · Hygieneverordnung



Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de



Pflegeplanungs- Vorlagen

Druckfertige Formulare für deine Pflegeplanung nach dem AEDL-Modell – mit Anleitung zu PESR und SMART und einem ausgefüllten Beispiel.

Bestehen ist planbar.

AEDL nach Krohwinkel

PESR

SMART-Ziele

Beispiel

8

Formulare

1

Musterbeispiel

A4

druckfertig

INHALT

1

AEDL-Übersicht & Anleitung

2

Ausgefülltes Beispiel

3

8 Formulare Pflegeplanung

△ Formulare dürfen für Ausbildung und Praxis beliebig oft kopiert werden. Es gelten die Dokumentationsvorgaben deiner Einrichtung.

So schreibst du eine gute Pflegeplanung

Die 13 AEDL nach Monika Krohwinkel und die vier Schritte zur Planung.

13 AEDL NACH KROHWINKEL

1. Kommunizieren können
2. Sich bewegen können
3. Vitale Funktionen aufrechterhalten können
4. Sich pflegen können
5. Essen und trinken können
6. Ausscheiden können
7. Sich kleiden können
8. Ruhen und schlafen können
9. Sich beschäftigen, lernen, sich entwickeln können
10. Sich als Mann/Frau/Mensch fühlen können
11. Für eine sichere/fördernde Umgebung sorgen können
12. Soziale Kontakte und Beziehungen sichern können
13. Mit existenziellen Erfahrungen umgehen können

1 • PROBLEM NACH PESR

Problem · **Einflussfaktoren** (Ursache) · **Symptome** · **Ressourcen** – immer individuell für diesen Patienten.

2 • ZIEL NACH SMART

Spezifisch · **Messbar** · **Attraktiv/erreichbar** · **Realistisch** · **Terminiert**. Aus Sicht des Patienten formulieren.

3 • MASSNAHMEN

Konkret und überprüfbar: Wer macht was, wann, wie oft, womit?

4 • EVALUATION

Datum festlegen und prüfen: Ziel erreicht? Wenn nicht – Ursache suchen und Plan anpassen.

Typischer Fehler: „Patient soll sich wohlfühlen“ ist kein Ziel – es ist weder messbar noch terminiert. Besser: „Patient gibt bis morgen 12 Uhr Schmerzen ≤ 3 auf der NRS an.“

Musterbeispiel

So kann ein ausgefülltes Formular aussehen – Patient nach Hüft-TEP, 2. postoperativer Tag.

AEDL-BEREICH

Sich bewegen können

PFLEGEPROBLEM (PESR)

Eingeschränkte Mobilität (P) durch Wundschmerz und Luxationsgefahr nach Hüft-TEP links (E), zeigt sich in Schonhaltung und Angst vor dem Aufstehen, NRS 6 bei Bewegung (S).

RESSOURCEN

Motiviert, kennt Gehstützen, Ehefrau unterstützt, versteht Anleitungen.

PFLEGEZIEL (SMART)

Patient geht am 4. postoperativen Tag mit zwei Unterarmgehstützen und Begleitung 20 m auf dem Flur, Schmerz bei Bewegung ≤ 3 (NRS).

MASSNAHMEN

Analgesie nach Anordnung 30 Min. vor der Mobilisation · Mobilisation 3× täglich mit Physiotherapie · Transfer über die operierte Seite anleiten · Verbotspositionen (Beugung $> 90^\circ$, Beine überkreuzen) erklären · Sturzprophylaxe: rutschfeste Schuhe, Klingel in Reichweite

EVALUATION

Täglich NRS und Gehstrecke dokumentieren · Zielüberprüfung am 4. postoperativen Tag



Pflegeplanung • Formular 1

Patient / Kürzel

Datum

AEDL-Bereich

PFLEGEPROBLEM (PESR: PROBLEM – EINFLUSSFAKTOREN – SYMPTOME)

RESSOURCEN

PFLEGEZIEL (SMART)

MASSNAHMEN (WER • WAS • WANN • WIE OFT)

EVALUATION • DATUM DER ÜBERPRÜFUNG



Pflegeplanung • Formular 2

Patient / Kürzel

Datum

AEDL-Bereich

PFLEGEPROBLEM (PESR: PROBLEM – EINFLUSSFAKTOREN – SYMPTOME)

RESSOURCEN

PFLEGEZIEL (SMART)

MASSNAHMEN (WER • WAS • WANN • WIE OFT)

EVALUATION • DATUM DER ÜBERPRÜFUNG



Pflegeplanung • Formular 3

Patient / Kürzel

Datum

AEDL-Bereich

PFLEGEPROBLEM (PESR: PROBLEM – EINFLUSSFAKTOREN – SYMPTOME)

RESSOURCEN

PFLEGEZIEL (SMART)

MASSNAHMEN (WER • WAS • WANN • WIE OFT)

EVALUATION • DATUM DER ÜBERPRÜFUNG



Pflegeplanung • Formular 4

Patient / Kürzel

Datum

AEDL-Bereich

PFLEGEPROBLEM (PESR: PROBLEM – EINFLUSSFAKTOREN – SYMPTOME)

RESSOURCEN

PFLEGEZIEL (SMART)

MASSNAHMEN (WER • WAS • WANN • WIE OFT)

EVALUATION • DATUM DER ÜBERPRÜFUNG



Pflegeplanung • Formular 5

Patient / Kürzel

Datum

AEDL-Bereich

PFLEGEPROBLEM (PESR: PROBLEM – EINFLUSSFAKTOREN – SYMPTOME)

RESSOURCEN

PFLEGEZIEL (SMART)

MASSNAHMEN (WER • WAS • WANN • WIE OFT)

EVALUATION • DATUM DER ÜBERPRÜFUNG



Pflegeplanung • Formular 6

Patient / Kürzel

Datum

AEDL-Bereich

PFLEGEPROBLEM (PESR: PROBLEM – EINFLUSSFAKTOREN – SYMPTOME)

RESSOURCEN

PFLEGEZIEL (SMART)

MASSNAHMEN (WER • WAS • WANN • WIE OFT)

EVALUATION • DATUM DER ÜBERPRÜFUNG



Pflegeplanung • Formular 7

Patient / Kürzel

Datum

AEDL-Bereich

PFLEGEPROBLEM (PESR: PROBLEM – EINFLUSSFAKTOREN – SYMPTOME)

RESSOURCEN

PFLEGEZIEL (SMART)

MASSNAHMEN (WER • WAS • WANN • WIE OFT)

EVALUATION • DATUM DER ÜBERPRÜFUNG



Pflegeplanung • Formular 8

Patient / Kürzel

Datum

AEDL-Bereich

PFLEGEPROBLEM (PESR: PROBLEM – EINFLUSSFAKTOREN – SYMPTOME)

RESSOURCEN

PFLEGEZIEL (SMART)

MASSNAHMEN (WER • WAS • WANN • WIE OFT)

EVALUATION • DATUM DER ÜBERPRÜFUNG

**Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.**Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de



Dokumentations- vorlagen

Fünf druckfertige Formulare für Ausbildung und Praxis – von der Wunddokumentation bis zur strukturierten SBAR-Übergabe.

Bestehen ist planbar.

Wunde

Vitalzeichen

SBAR

Pflegebericht

Sturz

5

Formulare

A4

druckfertig

∞

kopierbar

INHALT

1

Wunddokumentationsbogen

2

Vitalzeichen-Verlaufsbogen

3

SBAR-Übergabebogen

4

Pflegebericht

5

Sturz- und Ereignisprotokoll

△ Formulare zu Übungs- und Ausbildungszwecken. Es gelten die Dokumentationsvorgaben deiner Einrichtung.

1 Wunddokumentationsbogen

Patient / Kürzel

Datum

Untersucher/in

LOKALISATION & WUNDART

WUNDGRÖSSE (LÄNGE × BREITE × TIEFE IN CM)

WUNDGRUND

☐ Granulierend ☐ Fibrinbelegt ☐ Nekrotisch ☐ Epithelisierend

EXSUDAT

☐ Kein ☐ Gering ☐ Mäßig ☐ Stark

Farbe / Geruch: _____

INFEKTIONSZEICHEN

☐ Rötung ☐ Überwärmung ☐ Schwellung ☐ Schmerz ☐ Geruch

WUNDRAND / WUNDUMGEBUNG

MASSNAHMEN / VERBANDMATERIAL

VERLAUF

Datum	Größe	Wundgrund	Exsudat	Maßnahme	Hdz.

Orientierung am DNQP-Expertenstandard „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“.

2 Vitalzeichen-Verlaufsbogen

Patient / Kürzel

Woche

Station / Zimmer

[illegible]



3 SBAR-Übergabebogen

Patient / Kürzel

Datum / Uhrzeit

Übergabe von → an

S – SITUATION: WER, WO, WAS IST DAS AKTUELLE PROBLEM?

B – BACKGROUND: DIAGNOSEN, VORGESCHICHTE, MEDIKAMENTE

A – ASSESSMENT: VITALWERTE, EINSCHÄTZUNG, AUFFÄLLIGKEITEN

R – RECOMMENDATION: WAS IST ZU TUN, WAS BRAUCHE ICH?

4 Pflegegeberbericht

Patient / Kürzel

Station

Blatt-Nr.

[illegible]

5 Sturz- und Ereignisprotokoll

Patient / Kürzel

Datum / Uhrzeit

Ort

HERGANG DES EREIGNISSES (WER HAT WAS BEOBACHTET?)

VERLETZUNGEN / SYMPTOME

SOFORTMASSNAHMEN

☐ Vitalzeichen kontrolliert ☐ Arzt informiert ☐ Angehörige informiert ☐ Wunde versorgt

BEKANNTE RISIKOFAKTOREN

☐ Sturzanamnese ☐ Gangunsicherheit ☐ Sehbeeinträchtigung ☐ Sedierende Medikamente
☐ Inkontinenz

WEITERE MASSNAHMEN / ANPASSUNG DER PFLEGEPLANUNG

Dokumentiert von

Datum

Unterschrift



Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de



Reanimation & Notfallalgorithmen

4 Algorithmen im Überblick – Erwachsene, Kinder, Fremdkörper und erweiterte Maßnahmen. A4-Poster zum Ausdrucken, Laminieren und Lernen.

Bestehen ist planbar.

BLS Erwachsene

PBLS Kinder

Fremdkörper

ALS Klinik

4

Algorithmen

A4

druckfertig

ERC

Leitlinien-basiert

INHALT

1

BLS – Basic Life Support

2

PBLS – Kinder & Säuglinge

3

Fremdkörperverlegung

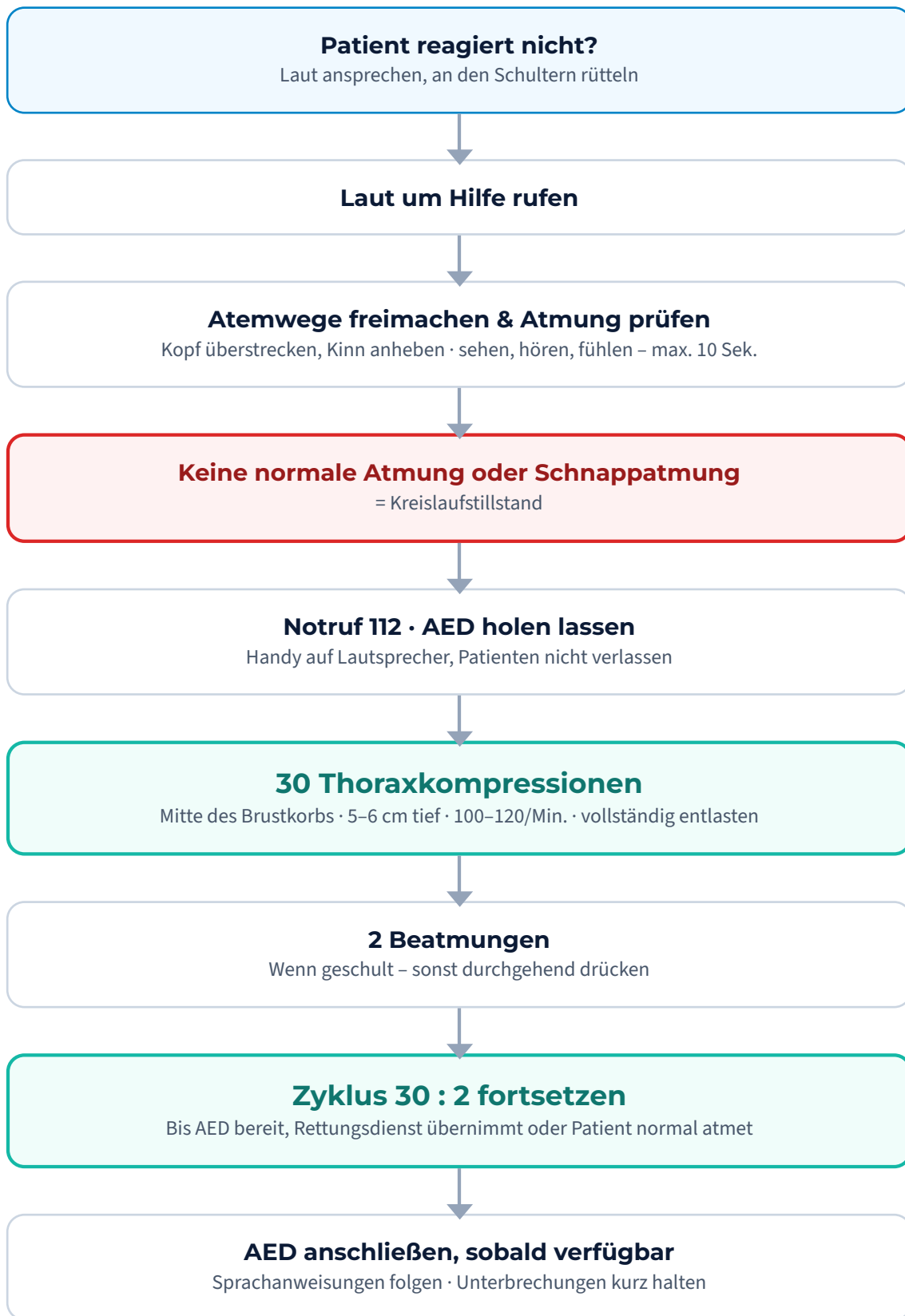
4

ALS – Advanced Life Support

⚠ Nur zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken. Ersetzt kein zertifiziertes BLS-/ALS-Training, keine innerklinischen Standards und keine ärztliche Anordnung. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen ERC-Leitlinien und dein Klinikstandard.

1 BLS – Basic Life Support

Erwachsene · Ersthelfer außerhalb und innerhalb der Klinik



Merke: Alle 2 Minuten Drücker wechseln, wenn ein zweiter Helfer da ist – die Qualität der Kompressionen lässt schnell nach.

2 PBLS – Paediatric Basic Life Support

Säuglinge und Kinder bis zur Pubertät



Merke: Säugling = zwei Finger oder zwei Daumen mit umgreifenden Händen · Kind = ein oder zwei Handballen.

3 Fremdkörperverlegung der Atemwege

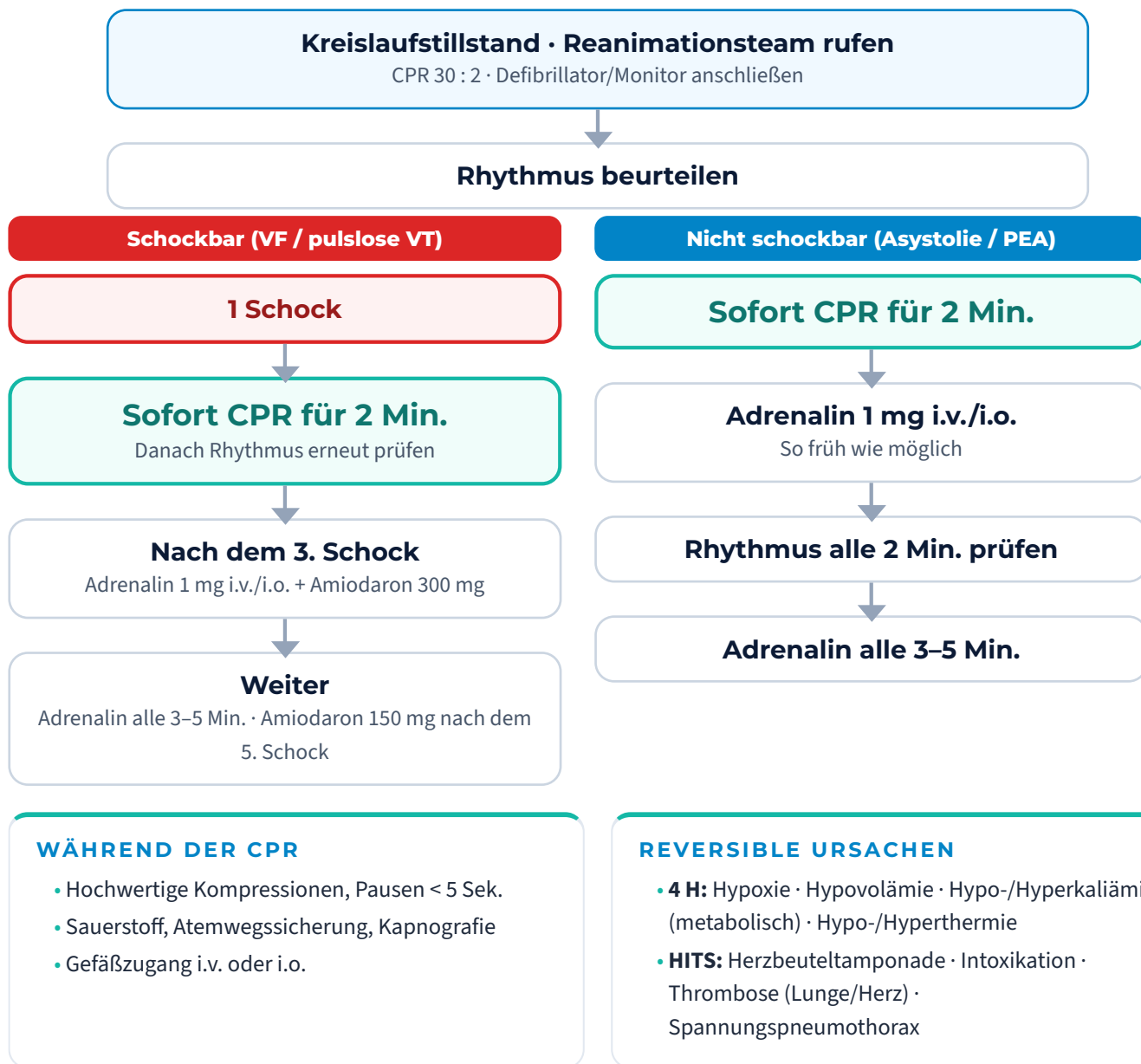
Erwachsene und Kinder · Besonderheiten beim Säugling



Nach Oberbauchkompressionen immer ärztlich abklären lassen – innere Verletzungen sind möglich.

4 ALS – Advanced Life Support

Klinischer Ablauf mit Defibrillator und Medikamenten


Nach ROSC: ABCDE-Schema • SpO₂ 94–98 % • 12-Kanal-EKG • Ursache behandeln • Fieber vermeiden.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de



Examens- Spickzettel

Alle Kernzahlen, Scores und Merksätze für das Pflegeexamen auf einen Blick – kompakt zum Ausdrucken und Wiederholen.

Bestehen ist planbar.

Vitalwerte

Scores

Perfusor

Hygiene

Recht NRW

Abkürzungen

6

Themenblöcke

60+

Kernfakten

A4

druckfertig

INHALT

1 Vitalwerte Normbereiche

2 Wichtige Scores

3 Perfusor & Dosierung

4 Hygiene-Kernfakten

5 Ausbildung & Recht NRW

6 Wichtige Abkürzungen

⚠ Lernhilfe für Ausbildung und Prüfung. Werte können je nach Lehrbuch, Leitlinie und Klinikstandard leicht abweichen – im Zweifel gilt der Standard deiner Einrichtung.

Kernzahlen auf einen Blick

Ausdrucken, an die Wand hängen, jeden Tag einmal lesen.

1 VITALWERTE NORMBEREICHE

Blutdruck (Erw.) 120/80 mmHg · normal bis 139/89

Puls (Erw.) 60–100/Min.

Atemfrequenz (Erw.) 12–20/Min.

Temperatur 36,0–37,4 °C

SpO₂ ≥ 95 % · COPD-Ziel 88–92 %

Blutzucker nüchtern 70–100 mg/dl (3,9–5,6 mmol/l)

Puls Neugeborenes 120–160/Min.

AF Neugeborenes 30–60/Min.

2 WICHTIGE SCORES

Braden-Skala 6–23 P. · ≤ 18 = Dekubitusrisiko

Barthel-Index 0–100 · 100 = selbstständig

Glasgow Coma Scale 3–15 · ≤ 8 = Atemwegssicherung erwägen

NRS Schmerz 0–10 · ab 4 behandlungsbedürftig

qSOFA ≥ 2 von 3: AF ≥ 22 · RR syst. ≤ 100 · Bewusstsein verändert

NEWS2 0–20 · ≥ 5 dringend · ≥ 7 Notfallteam

MNA ≥ 24 gut · 17–23,5 Risiko · < 17 Mangelernährung

CAM-ICU Akuter Beginn + Unaufmerksamkeit + (Denken oder Bewusstsein)

3 PERFUSOR & DOSIERUNG

Grundformel $\text{ml/h} = (\mu\text{g/kg/min} \times \text{kg} \times 60) \div (\mu\text{g/ml})$

Tropfen (20 Tr./ml) Tropfen/Min. = ml/h ÷ 3

Noradrenalin z. B. 5 mg auf 50 ml = 100 µg/ml

Insulin z. B. 50 IE auf 50 ml = 1 IE/ml

Merke Konzentrationen immer nach Klinikstandard!

4 HYGIENE-KERNFAKTEN

Hyg. Händedesinfektion 3–5 ml · mind. 30 Sek. (EN 1500)

Chirurg. Händedesinfektion 1,5–3 Min. nach Herstellerangabe

5 WHO-Momente Vor Patient · vor aseptisch · nach Körperflüssigkeit · nach Patient · nach Umgebung

C. difficile / Noro Zusätzlich Hände waschen – Sporen!

PSA anlegen Kittel → Maske → Brille → Handschuhe

PSA ablegen Handschuhe → Kittel → Brille → Maske → Händedesinfektion

5 AUSBILDUNG & RECHT NRW

Pflegefachfrau/-mann 3 Jahre Vollzeit · Teilzeit bis 5 Jahre · Verkürzung um bis zu 1 Jahr möglich

Staatliche Prüfung 3 schriftliche Klausuren · mündlich (30–45 Min.) · praktisch

Pflegefachassistenz NRW 1 Jahr · 700 h Theorie + 950 h Praxis

Ausländische Abschlüsse Kenntnisprüfung oder Anpassungslehrgang

Zuständig in NRW Bezirksregierung

6 WICHTIGE ABKÜRZUNGEN

ATL / AEDL (Aktivitäten und existenzielle Erfahrungen der) Aktivitäten des Lebens

PESR Problem – Einflussfaktoren – Symptome – Ressourcen

SMART Spezifisch · Messbar · Attraktiv · Realistisch · Terminiert

SBAR Situation · Background · Assessment · Recommendation

DNQP Dt. Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege

ROSC Return of Spontaneous Circulation

MH Maligne Hyperthermie

HIT Heparin-induzierte Thrombozytopenie



Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de